

1

*!У мужчины 56 лет имеется частичная вторичная адентия верхней челюсти с отсутствием 18, 17, 16, 15, 24, 25, 26, 28 зубов, 27 зуб наклонён незначительно в мезиальную сторону. Торус резко выражен. Нижний зубной ряд интактен.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+бюгельный протез
- *составные мостовидные протезы
- *адгезивные мостовидные протезы
- *консольные мостовидные протезы
- *частичные съёмные протезы

#2

*!У мужчины 52 лет, отсутствует 35 зуб, на 36 зубе имеется пломба (2 класс по Блеку) с медиальной стороны, 34 зуб интактен.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+мостовидный протез с опорой на коронку на 34 зуб и вкладку на 36 зуб
- *состовой мостовидный протез с опорой на 34, 36 и 37 зубы
- *мостовидный протез из пластмассы с опорой на 34 и 36, 37 зубы
- *мостовидный протез с опорой на 33, 34 и на 36 зуб и на 37 зуб
- *консольный протез с опорой на 34 зуб или с опорой на 37 зуб

#3

*!Мужчина 75 лет. Съёмные пластиночные протезы при полной адентии верхней и нижней челюстей изготовлены в третий раз. Жалобы: «привык к протезам сразу, но через полтора месяца появился шум в ушах». Объективно: старческое выражение лица.

Какая из перечисленных ниже ошибок, НАИБОЛЕЕ вероятно, была допущена?

- *завышена высота нижнего отдела лица
- *нарушен процесс полимизации
- *недоупаковка пластмассы
- *+высота нижнего отдела лица занижена
- *поставлены длинные зубы

#4

*!Мужчина 34 лет, 12, 11, 21, 22, 32, 31, 41, 42 зубы поражены кариозным процессом. Наличие полостей 4 класса по Блеку. Сопутствующее заболевание – флюороз. При осмотре и зондировании зубы изменены в цвете, эмаль неплотная.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций целесообразна?

- *+коронки
- *полукоронки
- *люминиры
- *вкладки
- *штифты

#5

*!НАИБОЛЕЕ информативный метод определения взаимного расположения головки, диска и заднего ската бугорка ВНЧС это

- *миография
- *+томография
- *реография
- *аксиография
- *мастикациография

#6

*!НАИБОЛЕЕ информативный метод определения состояние мягких тканей ВНЧС?

- *томография
- *компьютерная томография
- *+магнитно-резонансная томография
- *рентгенография в 3 проекциях
- *прицельная рентгенография

#7

*!У Мужчины 72 лет, беззубая верхняя челюсть. Атрофия альвеолярного отростка средней степени, маловыраженные бугры, средняя глубина неба, выраженный торус. Какой из перечисленных типов полной вторичной адентии НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *I – тип по Оксману
- *+II- тип по Оксману
- *II- тип по Суппле
- *III- тип по Оксману
- *III- тип по Суппле

#8

*!У Мужчины 65 лет, на нижней челюсти двухсторонний концевой дефект зубного ряда. Зубная формула : 00004321 / 12340000

Прикус ортогнатический Атрофия альвеолярных отростков умеренная. Слизистая полости рта без особенностей

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+бюгельный протез
- *мостовидный протез
- *консольные протезы
- *адгезивный протез
- *составной протез

#9

*!Мужчина 74 лет. На этапе ортопедического лечения, при введении в полость рта восковой композиции частичных съемных пластиночных протезов в/ч и н/ч нижняя треть лица удлинена, губы смыкаются с трудом, складки лица сглажены, при разговоре имеется еле заметная щель между фронтальными зубами, слышен стук зубов. Все

антагонизирующие зубы смыкаются равномерно и плотно

Какая из перечисленных ошибок была НАИБОЛЕЕ вероятно допущена врачом на этапе определения центральной окклюзии?

- *высота прикуса снижена
- *+высота прикуса завышена
- *зафиксирована передняя окклюзия
- *зафиксирована боковая окклюзия
- *зафиксирована задняя окклюзия

#10

*!При каких из перечисленных клинических ситуаций НАИБОЛЕЕ целесообразно изготовить бюгельный протез с использованием 5-типа опорно-удерживающего кламмера системы Нея?

- *двухсторонний концевой дефект-ограничен премолярами
- *односторонний концевой дефект-ограничен премолярами
- *включенные дефекты в переднем отделе с одиночно стоящими премолярами
- *+включенные дефекты в боковом отделе с одиночно стоящими молярами
- *одиночно стоящие премоляры на верхней и нижней челюсти

#11

*!Мужчина 38 лет. Обратился с жалобами на боли в области 11 зуба. При осмотре патологии твердых тканей не выявлено. В анамнезе отмечает механическую травму.

Какой из перечисленных дополнительных методов обследования НАИБОЛЕЕ рационально провести?

- *мастикациографию
- *одонтопародонтограмму
- *+рентгенографию
- *реографию
- *миографию

#12

*!Мужчина 25 лет, жалуется на повышенную чувствительность зубов к внешним раздражителям. При осмотре Полости рта: 22,21/11,12 зубах по режущему краю имеется полулунная вырезка. Стенки, края и дно углублений гладкие.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+гипоплазия эмали
- *гиперплазия эмали
- *эрозия
- *клиновидный дефект
- *эрозивная форма флюороза

#13

*!При изготовлении какой несъёмной шины НАИБОЛЕЕ целесообразно препарированием сделать параллельные пазы на верхних зубах включенных в шину?

- *+ полукоронки
- *кольцевой
- *колпачковой
- *экваторной
- *коронковой

#14

*!Мужчина 25, лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие правого центрального резца верхней челюсти. Прикус ортогнатический, слизистая полости рта без видимой патологии

Какой из перечисленных диагнозов по классификации Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *1 класс
- *2 класс
- *3 класс
- *+4 класс
- *5 класс

#15

*!Клиническая шейка зуба – это воображаемая линия которая проходит

- * на уровне анатомической шейки зуба
- *+на уровне слизистой края десны в пришеечной части коронки
- * делит зуб на коронку и корень
- * проходящая на уровне перехода эмали в цемент
- *по самой выпуклой части клинической коронки

#16

*!Искусственная коронка зуба – это протез

- *покрывающий коронку естественного зуба
- *накладываемый на естественную коронку зуба и полностью ее покрывающий
- *+восстанавливающий форму, функцию, а также эстетику

*применяемый для красоты

*применяемый для восстановления дефекта зубного ряда

#21

*!Мужчина 32 лет, жалуется на разрушенную коронку верхнего центрального резца, ранее на зубе проведено эндодонтическое лечение

Какой из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразен, если корень зуба сохранен?

*+штифтовый зуб

*полная коронка

*культевая вкладка

* имплантат с зубом

*вкладка

#22

*!При изготовлении штифтовых зубов к корням зубов предъявляются определенные требования. Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ приемлемо?

*корень зуба находится глубоко под десной, без изменения периапикальных тканей

*+корень выступает над десной или на уровне десны без изменения периапикальных тканей

*стенки канала корня достаточной толщины, с изменениями периапикальных тканей

*искривленный корень с тонкими стенками без изменения периапикальных тканей

*корень запломбирован на 1/2 длины, подвижен, без изменения периапикальных тканей

23

*!В каких из перечисленных случаях НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать вкладки?

*+ восстановления дефекта коронки зуба

*восполнения дефекта зубного ряда

* фиксации консольного протеза и улучшения их фиксации

* опоры консольных протезов

* предупреждения дальнейшей деформации зчс

#24

*!В каких из перечисленных случаях НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать виниры?

*желание пациента

*+изменения цвета зуба

*кариес и его осложнения

*потеря одного зуба

*как опора под мостовидный протез

#25

*!В клинике ортопедической стоматологии под термином камперовская горизонталь – понимают воображаемую линию проведенную

*по окклюзионной поверхности зубов

*+от основания крыла носа до середины козелка уха

*от середины центральных зубов до козелка уха

*от окклюзионной поверхности жевательных зубов одной стороны

*поверхности жевательных зубов другой стороны

#26

*!Какая НАИБОЛЕЕ правильная последовательность первого клинического этапа изготовления металло-керамической коронки?

*+обследование, обезболивание, препарирование, снятие слепка

*обследование, снятие слепка, препарирование, припасовка коронки

- *снятие слепка, припасовка колпачка, припасовка коронки, определение цвета
- *препарирование зуба, обследование, припасовка колпачка, определение цвета
- *обследование, припасовка коронки, определение цвета, фиксация на цемент

#27

*!Мужчина 29 лет. Диагноз: дефект зубного ряда верхней челюсти, 2 класс по Кеннеди, расстояние от вершины гребня до синуса 20 мм, ширина гребня 8 мм.

Какой вид имплантата НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *+внутрикостный пластиночный
- *полный субпериостальный
- *частичный субпериостальный
- *эндодонто-эндоссальный
- *игольчатый

#28

*!Мужчина 48 лет. Диагноз: дефект зубного ряда верхней челюсти, 2 класс по Кеннеди. Выраженная атрофия альвеолярного гребня в области предполагаемой имплантации.

Расстояние от вершины гребня до синуса 4-5 мм, ширина гребня 7-8 мм

Какой вид имплантата НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *полный субпериостальный
- *+частичный субпериостальный
- *эндо-субпериостальный
- *винтовой
- *пластиночный

#29

*!Мужчина 25 лет. Диагноз: полное отсутствие зубов на верхней и нижней челюстях, резкая атрофия гребня на обеих челюстях. Расстояние до придаточных пазух и нижнеальвеолярного нерва 2-4 мм, ширина гребня 6-8 мм.

Какой НАИБОЛЕЕ рациональный вид имплантации показан в данном случае?

- *+пластиночные имплантаты на обе челюсти
- *полные субпериостальные имплантаты на обе челюсти
- *эндо-субпериостальные имплантаты на верхнюю и нижнюю челюсти
- *цилиндрические
- *любой из вышеперечисленных способов

#30

*!При одонтопрепарировании опорных зубов под мостовидные протезы НАИБОЛЕЕ целесообразно придерживаться определенных правил, которые зависят от

- * конструкции мостовидного протеза
- * количества опорных зубов
- *+соблюдения параллельности стенок опорных зубов
- *положение стенок variabelьно
- *параллельность соблюдать нет необходимости, главное снятие твердых тканей зуба

#31

*!Какие НАИБОЛЕЕ вероятные ориентировочные линии наносятся на прикусном валике во фронтальном отделе после определения и фиксации центральной окклюзии?

- *носоушная, зрачковая
- *срединная линия клыков, линия углов рта
- *линия улыбки, носоушная
- *+линия улыбки, срединная линия, линия клыков
- *носоушная, срединная линия

#32

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно влияют на величину границы базиса частичного съемного протеза влияют?

- *вид пластмассы
- *толщина базиса
- *длина опорных зубов,
- *состояния пародонта опорных зубов,
- *+количество оставшихся зубов.

#33

*!В каких из перечисленных случаях НАИБОЛЕЕ целесообразно изготовить двуслойный базис пластиночных протезов?

- *желание пациента, убедительная просьба
- *+неравномерная податливость мягких тканей протезного ложа
- *низкий альвеолярный гребень, малое количество зубов
- *малое число сохранившихся зубов, низкий альвеолярный гребень
- *при небольших дефектах зубных рядов

#34

*!Фиброзная интеграция имплантата-это

- *укрепление имплантата в соединительной ткани
- *наличие фиброзной прослойки между имплантатом и костью
- *+эпителиальное прикрепление к поверхности имплантата
- *помещение имплантата под надкостницу
- *фиброзная выстилка между тканью и имплантом

#35

*!Для чего из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно проводится двухэтапная имплантация внутрикостных имплантатов?

- *+в целях достижения остеоинтеграции
- *для снижения послеоперационной травмы
- *для предупреждения фиброзной интеграции
- *при плохих способностях к регенерации костной ткани
- *в целях улучшения функционального эффекта

#36

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ правильно соответствует определению термина торус

- *костные выступы на альвеолярном отростке н/ч
- *костные выступы на альвеолярном отростке в/ч
- *костные выступы в области внутренней косой линии
- *+видимые костные утолщения в виде валика в области шва твердого неба
- *видимые костные утолщения в области нижних первых моляров с вестибулярной стороны

#37

*!Мужчина 57 лет, находится на этапе ортопедического лечения. При проверке восковой конструкции частичного съемного протеза на верхней челюсти ортопедом выявлено, что боковые зубы смыкаются плотно, а в переднем отделе имеется разобщение.

Какая из перечисленных ниже окклюзий, НАИБОЛЕЕ вероятно, была зафиксирована на предыдущем этапе ортопедического лечения?

- *боковая
- *+передняя
- *центральная

- *боковая левая
- *боковая правая

#38

*!Мужчина 53 лет, обратился с жалобами на жжение, металлический привкус во рту. При осмотре: имеются металлический мостовидный протез на верхней челюсти и золотые коронки на зубах нижней челюсти с правой стороны.

Какой из перечисленных ниже предварительных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *аллергический стоматит
- *токсический стоматит
- *протезный стоматит
- *+явления непереносимости
- *парниковый эффект

#39

*!Женщина 27 лет, обратилась в клинику с жалобами на эстетический дефект. Из анамнеза: неоднократно лечила 17 зуб по поводу кариеса, пломба часто выпадала. Объективно: на жевательной поверхности 17 зуба имеется скол пломбы, зуб в цвете не изменен.

Какой вид вкладки НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *инлей
- *+онлей
- *пинлей
- *оверлей
- *культю

#40

*!Женщине 56 лет на верхнюю челюсть изготавливают частичный съемный пластиночный с фиксацией телескопической системой на 15 и 25 зубы

Чем из перечисленных НАИБОЛЕЕ вероятно представлена телескопическая система?

- *зуб-кламмер
- *коронка-вкладка
- *коронка-кламмер
- *+колпачок-коронка
- *имплантат-кламмер

#41

*!Женщина 37 лет обратилась с целью протезирования. При осмотре: на верхней челюсти выявлены дефекты зубного ряда, включенный во фронтальном отделе и концевой в боковом отделе. Рекомендовано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть.

Какая из перечисленных ниже систем фиксации бюгельного протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *система Нея
- *+замковые крепления
- *телескопическая система
- *удерживающие кламмера
- *система Румпеля-Дольдера

#42

*!Мужчина 67 лет предъявляет жалобы на полное отсутствие зубов верхней и нижней челюстей. При осмотре выявлены экзостозы на верхней челюсти и резкая атрофия альвеолярного гребня на нижней челюсти.

Какой базис из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *металлический
- *пластмассовый
- *силиконовый
- *нейлоновый
- *+двухслойный

#43

*!Мужчина 60 лет, обратился с целью протезирования. При осмотре коронковая часть передних зубов на верхней и нижней челюсти стерты, $\frac{1}{2}$ высоту коронок, корни устойчивы. На панорамной рентгенограмме корневые каналы 131211212223 и 43;42;41;31;32;33 запломбированы. Имеется концевой дефект на верхней челюсти слева, двухсторонний концевой дефекты на нижней челюсти.

Какой вид ортопедического лечения из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразно провести

в первую очередь?

- *бюгельные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти
- *частичные съемные пластиночные протезы на обе челюсти
- *комбинированные коронки на передние зубы обеих челюстей
- *культевые штифтовые вкладки на передние зубы обеих челюстей
- *+восстановление высоты нижнего отдела лица пластмассовой каппой

#44

*!Женщина 57 лет, предъявляет жалобы на подвижность зубов верхней челюсти. При обследовании выявлена подвижность зубов в боковых отделах челюсти с поражением пародонта.

Какая стабилизация шинирующих конструкций из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *передняя
- *сагитальная
- *трансверзальная
- *+парасагитальная
- *передне – боковая

#45

*!В клинику обратился мужчина 48 лет, с жалобами на подвижность зубов с нарушением функции жевания. Объективно: верхняя губа слегка выступает, коронки верхних центральных зубов расположены веерообразно. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 зубы подвижны I степени, 28, 27, 26, 36, 37, 38 зубы отсутствуют. Прикус ортогнатический. Имеются тремы и диастемы между зубами. Шейки зубов оголены. При пальпации на всех зубах зубодесневые карманы выделяют небольшое количество гноя. Десна гиперемирована, отечна.

Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ целесообразным?

- *фронтальная стабилизация с применением колпачковой шины
- *сагитальная стабилизация, с применением экваторных коронок
- *парасагитальная стабилизация с применением шины из полукоронок
- *+круговая стабилизация с применением бюгельного протеза
- *фронтальная стабилизация с применением мостовидного протеза

#46

*!Мужчина 25 лет, обратился с жалобой на разрушение коронки 17 зуба. Анамнез: 17 зуб лечился по поводу кариеса и неоднократно лечился у терапевта-стоматолога. Наложённая пломба 2 раза выпадала. Объективно: клиническая коронка 17 зуба низкая, на окклюзионной поверхности зуба стоит обширная пломба. Зуб депульпирован, перкуссия

отрицательная, на рентгенограмме корневые каналы запломбированы до верхушки корней. Патологических изменений нет.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *цельнолитая коронка с анкерным штифтом
- *пластмассовая коронка
- *+культевая коронка с парапульпарным штифтом
- *штифтовый зуб по Ричмонду
- *пластмассовая коронка со штифтом

#47

*!Мужчина 56 лет, жалуется на недостаточную фиксацию протеза на нижнюю беззубую челюсть во время функции жевания и разговора. Объективно: определяются наличие широкого объемного языка, заполняющего свободное пространство.

Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ рациональным и эффективным?

- *удлинение границы протеза
- *+создание углубления в базисе с язычной стороны
- *сделать эластическую подкладку под базис протеза
- *перебазировка самотвердеющей пластмассой
- *переделка съемного протеза

#48

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятным противопоказанием к проведению имплантации?

- *наличию кариозных зубов
- *заболевания СОПР
- *заболевания парадонта
- *+нарушения кальциевого обмена
- *повышенная стираемость зубов

#49

*!Остеоинтеграция имплантата-это

- *плотное укрепление имплантата
- *помещение имплантата в костную ткань
- *+плотный контакт между новообразованной костной тканью и поверхностью имплантата
- *наличие фиброзной ткани между имплантатом и костью
- *эпителиальная выстилка между имплантатом и костью

#50

*!Мужчина 25 лет, обратился с жалобой на внезапное блокирование движений в височно-нижнечелюстном суставе. При этом отмечает болезненность в области сустава. Анамнез: эти симптомы появились после широкого открывания рта во время откусывания яблока. Пациент отмечает, что при надавливании пальцем в области сустава движения нижней челюсти восстанавливаются.

Объективно: лицо симметрично, кожные покровы чистые, прикус ортогнатический, бледно-розового цвета. На 16, 17 зубах имеются пломбы.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+вывих мениска
- *вывих челюсти
- *перелом нижней челюсти
- *неврогенная контрактура
- *подвывих челюсти

#51

*!Мужчины 56 лет, жалуется на плохое пережевывание пищи из-за отсутствия зубов. Зубы удалены 2 месяца тому назад вследствие осложненного кариеса. Имеется частичная вторичная адентия верхней челюсти с отсутствием 16, 15, 25, 26 зубов. Остальные зубы интактны. Нижний зубной ряд интактен.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *бюгельный протез
- *составные мостовидные протезы
- *адгезивные мостовидные протезы
- *+металлокерамические мостовидные протезы
- *частичные съемные протезы

#52

*!Мужчины 52 лет, жалуется на плохое пережевывание пищи из-за отсутствия зубов. Зубы удалены в связи с подвижностью месяц назад. Объективно-отсутствуют премоляры и моляры на правые стороны верхней челюсти. Свод твердого неба выражен. На нижней челюсти зубы интактны, слизистая полости рта без видимой патологии.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+бюгельный протез на аттачменах
- *частичный съемный протез
- *консольный протез
- *бюгельный протез на кламмерах
- *составной протез

#53

*!У мужчины 52 лет, при объективном осмотре обнаружена повышенная стираемость твердых тканей зуба, уменьшение вертикальных размеров коронок всех зубов, снижение межальвеолярной высоты, высота нижней трети лица не изменена.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+генерализованная компенсированная повышенная стираемость твердых тканей зубов
- *локализованная компенсированная стираемость
- *локализованная некомпенсированная повышенная стираемость зубов
- *генерализованная субкомпенсированная форма, повышенная стираемость зубов
- *генерализованная некомпенсированная форма, повышенная стираемость зубов

#54

*!Мужчина 50 лет, жалуется на частичное отсутствие зубов, эстетический дефект, нарушение акта жевания. Зубы удалялись в течение 9 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась.

Объективно: на верхней челюсти отсутствуют все премоляры, моляры и два центральных резца, оставшиеся зубы имеют патологическую подвижность 1 степени

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *мостовидный протез
- *+частичный съемный протез
- *полный съемный протез
- *микро протез
- *консольный протез

#55

*!Мужчина 30 лет. При объективном осмотре обнаружена повышенная стираемость твердых тканей зуба II степени, уменьшение вертикальных размеров коронок всех зубов, снижение межальвеолярной высоты, высота нижней трети лица не изменена. Зубная формула: на верхней челюсти двухсторонний концевой дефект а на нижней челюсти односторонний концевой дефект

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ эффективна?

- *бюгельный протез с шинирующими элементами
- *+частичный съемный протез
- *полный съемный протез
- *микро протез с шинирующими элементами
- *металлокерамический мостовидный протез

#56

*!При припасовке индивидуальной ложки на верхнюю челюсть с использованием функциональных проб по Гербсту у мужчины 23-х лет, при вытягивании губ слепочная ложка смещается с верхней челюсти

В каком месте индивидуальной ложки НАИБОЛЕЕ целесообразна коррекция?

- *+ укорачивание вдоль переходной складки
- *в таких случаях укорачивают по линии А
- *укорачивают по боковому краю
- *необходимо укоротить на участке верхнечелюстного бугра
- *укорачивают в зоне между клыками

#57

*!Мужчина 48 лет, жалуется на стираемость зубов, эстетический дефект, чувствительность зубов к температурным раздражителям. Объективно: смешанная форма патологического стирания более, чем на 1/3 длины их коронки. Межальвеолярная высота снижена на 5-6 мм. Прикус ортогнатический.

Какой метод лечения НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *изготовление пластмассовой каппы на весь зубной ряд верхней челюсти
- *изготовление пластмассовой каппы на весь зубной ряд нижней челюсти
- *лечение провести в 2 этапа (подготовительный и рациональное протезирование)
- *+изготовление встречных конструкций в боковых отделах
- * изготовление металлокерамических конструкций на верхнюю и нижнюю челюсть

#58

*!Какое НАИБОЛЕЕ рациональное расположение плеч внутрикостного имплантата по отношению к кортикальной пластинке?

- *плечи расположены на уровне кортикальной пластинки
- *выше кортикальной пластинки
- *выше кортикальной пластинки на 2-3 мм
- *+выше кортикальной пластинки на 2-3 мм
- *в зависимости от состояния кости

#59

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятным показанием к проведению имплантации?

- *+полное отсутствие зубов, потеря 1 зуба
- *множественный кариес
- *повышенная стираемость зубов
- *заболевания парадонта
- *желание пациента

#60

*!Врач рекомендует пациенту бюгельный протез на нижнюю челюсть. Изучая модель на параллелометре, предлагает изготовить 2-тип, опорно-удерживающий кламмер системы Нея.

НАИБОЛЕЕ вероятно это объясняется следующей клинической картиной

- *+экваторы опорного зуба выражены
- *экваторы опорного зуба не выражены

- *опорный зуб имеет наклон в оральную сторону
- *опорный зуб имеет наклон в вестибулярную сторону
- *опорные зубы конвергированы в сторону дефекта

#61

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно является основной причиной развития анкилоза ВНЧС?

- *опухоль
- *мастоидит
- *околоушный гипергидроз
- *целлюлит околоушно-жевательной области
- *+травма мышечковых отростков нижней челюсти

#62

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно является основной причиной развития анкилоза ВНЧС?

- *опухоль
- *мастоидит
- *околоушный гипергидроз
- *+остеомиелит нижней челюсти
- *целлюлит околоушно-жевательной области

#63

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно является ведущим симптомом клиники двухстороннего костного анкилоза ВНЧС?

- *шум в ушах
- *нарушение глотания
- *множественный кариес
- *выраженный болевой симптом
- *+полное отсутствие движений нижней челюсти.

#64

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятным дополнительным методом исследования при диагностике анкилоза ВНЧС?

- *миография
- *аудиометрия
- *биохимия крови
- *+компьютерная томография
- *электроодонтодиагностика

#65

*!Чем из перечисленных НАИБОЛЕЕ вероятно характеризуется рентгенологическая картина костного анкилоза ВНЧС?

- *прерывистой суставной щелью
- *+сплошным костным конгломератом
- *четко контурируемыми элементами суставных структур
- *уплощение суставной головки
- *сужение суставной щели

#66

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ рациональным методом лечения больных с костным анкилозом ВНЧС?

- *физиотерапия
- *+хирургический

- *консервативный
- *ортопедический
- *ортодонтический

#67

*!Какое НАИБОЛЕЕ вероятное функциональное нарушение встречается при патологической стираемости зубов?

- *развитие пульпита
- *+снижение эффективности жевания
- *подвижность зубов
- *развитие кариеса
- *гиперестезия

#68

*!По форме стираемости поверхности зубов различают?

- *+горизонтальную, комбинированную, вертикальную
- *виртуальную, овальную
- *круглой формы, центральную
- *диагональную
- *цилиндрическую

#69

*!Мужчина 37 лет, жалуется на изменение формы верхних передних зубов, косметический дефект. Прикус: глубокое резцовое перекрытие. На оральной поверхности и режущем крае верхних передних зубов эмаль отсутствует, за счет чего высота коронок верхних фронтальных зубов уменьшена. Контакт с нижними фронтальными зубами есть.

Какой НАИБОЛЕЕ вероятный диагноз?

- *+патологическая стираемость (смешанная). локализованная компенсированная форма
- *патологическая стираемость (горизонтальная). локализованная компенсированная форма
- *патологическая стираемость (смешанная). генерализованная декомпенсированная форма
- *патологическая стираемость (вертикальная). локализованная декомпенсированная форма
- *патологическая стираемость (смешанная). генерализованная компенсированная форма

#70

*!Женщина 48 лет, жалуется на отсутствие зубов на нижней челюсти. 38, 37, 34, 45, 46 зубы отсутствуют. 35, 36, 44, 47 зубы стерты более, чем на 2/3 длины коронки.

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+частичный съемный протез с окклюзионными накладками
- *частично съемный пластинчатый протез
- *бюгельный протез
- *мостовидный металлокерамический протез
- *паянный мостовидный протез

#71

*!Мужчина 43 лет, жалуется на стирание зубов верхней и нижней челюсти. Объективно: все зубы верхней и нижней челюсти стерты до десенного края. В отдельных участках от них остались небольшие, слегка выступающие над деснами культи.

Какая НАИБОЛЕЕ вероятная форма патологической стираемости описана?

- *смешанная
- *локализованная вертикальная
- *генерализованная вертикальная
- *локализованная горизонтальная
- *+генерализованная горизонтальная

#72

*!Женщина 45 лет, жалуется на стирание зубов на верхней челюсти, боли при термических и химических раздражителях, эстетический дефект. Объективно: прикус прямой, коронки всех зубов на в/ч стерты на 1/3, форма стирания горизонтальная. Высота нижней трети лица снижена, снижена межальвеолярная высота.

Какая НАИБОЛЕЕ рациональная методика восстановления высоты прикуса?

- *пластмассовыми коронками
- *+протезирование в два этапа
- *штифтовыми конструкциями
- *цельнолитыми конструкциями
- *штампованно-паянными коронками

#73

*!Мужчина 49 лет, жалуется на стираемость зубов, эстетический дискомфорт, повышенную чувствительность. Объективно: коронки всех зубов стерты более чем на 1/3 длины. Межальвеолярная высота снижена на 5-6 мм. Прикус прямой. Все зубы устойчивы, зондирование жевательной поверхности болезненное.

Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать в боковых участках при протезировании больного?

- *вкладки
- *пластмассовые коронки
- *+конструкции с литой жевательной поверхностью
- *металлокомпозитные коронки
- *металлокерамические коронки

#74

*!Какие размеры иглы НАИБОЛЕЕ рациональны для интралигаментарной анестезии?

- *+10-12 мм
- *14-15 мм
- *16-25 мм
- *24-25 мм
- *8-14 мм

#75

*!Мужчина 52 лет, жалуется на стираемость зубов, эстетический дефект, повышенную чувствительность 15, 16, 13, 14, 23, 24, 25, 26 при принятии горячей пищи, холодной и сладкой пищи. Объективно: премоляры и моляры стерты более чем на 1/3 высоты коронок. Межальвеолярная высота занижена на 5-6 см. Прикус ортогнатический. Все зубы устойчивы, зондирование их окклюзионной поверхности болезненное.

Какое НАИБОЛЕЕ рациональное дополнительное обследование необходимо провести?

- *реопародонтография
- *+панорамная рентгенография
- *электромиография
- *жевательная проба по Рубинову
- *мастикациограмму

#76

*!Какой НАИБОЛЕЕ целесообразный метод инфильтрационной анестезии, при котором раствор вводится непосредственно в область периодонта обезболиваемого зуба?

- *подслизистая
- *поднадкостничная
- *надкостничная
- *+интралигаментарная
- *внутрипульпарная

#77

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ обоснованным и целесообразным методом лечения привычного вывиха и подвывиха нижней челюсти является?

- *миогимнастика и механотерапия
- *+ограничение чрезмерного открывания рта
- *протезирование дефектов зубного ряда
- *устранение заболевания сопр
- *повышение функционирования нижней челюсти

#78

*!Женщина 36 лет жалуется на резкую боль, щелканье в правом внчс. Жжение в области внешнего слухового прохода. Движения нижней челюсти ступенчатые, с кратковременными блокирующими моментами в суставе и острой болью. Объективно: лицо симметрично, прикус ортогнатический. При внутриротовой пальпации латеральных крыловидных мышц ощущается боль справа. На томограмме контуры костных структур суставных поверхностей ровные, гладкие.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *ревматический артрит внчс
- *острый посттравматический артрит
- *+нейромышечный синдром внчс
- *деформирующий артроз внчс
- *анкилоз внчс

#79

*!Для исследования состояния мягких тканей сустава НАИБОЛЕЕ рационально использовать

- *артрографию
- *+магниторезонансную томографию
- *ортопантограмму
- *компьютерная томографию
- *мастикациграфию

#80

*!Аускультация ВНЧС при артрозе и хроническом артрите НАИБОЛЕЕ достоверно выявляет

- *флюктуацию
- *авномерные, мягкие, скользящие звуки трущихся поверхностей
- *+щелкающие звуки, крепитацию
- *отсутствие суставного шума
- *треск

#81

*!Каким из перечисленных материалов НАИБОЛЕЕ целесообразно снять двухслойные оттиски?

- *+силиконовые
- *альгинатные
- *твердокристаллические
- *агаровые
- *комбинированные

#82

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятным преимуществом силиконовых оттисковых материалов?

- *+четкое отображение тканей протезного ложа, отсутствие усадки
- *большая эластичность, усадка, прочность на разрыв,отсутствии пор
- *стерилизация нагреванием, прочность на разрыв
- *многократное использование
- *большая эластичность

#83

- *!Какие НАИБОЛЕЕ вероятные контакты могут быть в боковых окклюзиях на рабочей стороне?
- *групповые щечных бугров жевательных зубов
- *клыков и боковых резцов
- *резцов и щечных бугров премоляров
- *резцов
- *+щечных бугров жевательных зубов или клыков.

#84

- *!Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ полно отражает хроническое заболевание сустава, которое характеризуется дистрофическими изменениями
- *перелом суставного отростка нижней челюсти
- *вывих внчс
- *артрит внчс
- *синдром болевой дисфункции внчс
- *+артроз внчс

#85

- *!Для фиксации ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ рациональное время замешивания цинк-фосфатных цемента не должно превышать:
- *30-40 секунд
- *50-60 секунд
- *100-120 секунд
- *+60-90 секунд
- *15-20 секунд

#86

- *!Каким из перечисленных цемента не рекомендуется фиксировать большие металлические ортопедические конструкции?
- *стеклоиномерные
- *+поликарбоксилатные
- *цинк-фосфатные
- *полимерные
- *силикатные

#87

- *!Что из перечисленного относится к НАИБОЛЕЕ важным качествам стеклоиномерных цемента?
- *цветостойкость, легко замешивается, хорошая прочность
- *отсутствие усадки, хорошая прочность, износостойкость
- *+хорошая адгезия за счет связи с кальцием твердых тканей зуба
- *отсутствие токсичности, повышенная прочность,пластичность
- *прозрачность и просвечиваемость

#88

- *!Из каких ниже перечисленных сплавов золота, НАИБОЛЕЕ целесообразно изготовить коронки, мостовидные протезы?

- *375-й пробы
- *750-й пробы
- *+900-й пробы
- *383-й пробы
- *500-й пробы

#89

*!При некоторых клинических ситуациях возникает необходимость изготовления мягких прокладок, для чего НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать следующую пластмассу

- *+эладент-100
- *акрел
- *синма-74
- *фторакс
- *протакрил-М

#90

*!У мужчины 68 лет, после перенесенного инсульта отмечались частые позывы на рвоту, при которых происходили вывихи сустава с одной стороны. Вправлять вывихи удавалось только под наркозом. Отсутствуют 21 - 28, 15 - 18, 36, 37, 44 - 47.

Какая рациональная конструкция протеза на период лечения будет НАИБОЛЕЕ оптимальной?

- *аппарат Ходорович-Бургонской с ограничителем
- *аппарат Петросова с ограничителем
- *аппарат Шредера со скользящим шарниром
- *+съемные пластиночные протезы с ограничителем открывания рта
- *аппарат Ядровой с ограничителем

#91

*!При протезировании пациентов с частичной и полной адентией широко используются пластиночные пластмассовые базисы, для изготовления которых НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать следующие пластмассы

- *+акрел, акронил
- *ортосил-м, ПМ-01
- *боксил, ортопласт
- * синма-74, сикор
- * протакрил-М

#92

*!В клинике ортопедической стоматологии нередко пациенты обращаются с просьбой починить сломавшийся протез, для чего НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать пластмассу:

- *ортосил-м
- *бакрил
- *ортопласт
- *+протакрил-м
- *акрел

#93

*!На первом клиническом этапе изготовления полных съемных протезов, для снятия анатомического слепка с беззубой челюсти НАИБОЛЕЕ часто применяются следующие массы

- *+альгинатные массы, мягкий гипс
- *воск, репин, силиконовые массы
- *быстротвердеющая пластмасса

- *термостойкий гипс, альгинаты
- *супергипс, воск,стенс, альгинаты

#94

*!В некоторых клинических ситуациях возникает необходимость проведения клинической перебазировки базиса протеза,для этого НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать пластмассу

- *этакрил, фторакс
- *бакрил,синма-М
- *норакрил, акрилоксид
- *+протакрил, редонт
- *синма,фторакс

#95

*!В какой группе зубов НАИБОЛЕЕ вероятно должен быть достигнут линейно окклюзионный контакт после проведения метода избирательной пришлифовки зубов при пародонтите?

- *+фронтальных зубов
- жевательных зубов
- зубного ряда верхней челюсти
- зубного ряда нижней челюсти
- зубных рядов обеих челюстей

#96

*!Чем НАИБОЛЕЕ вероятно является временное шинирование зубов при пародонтите?

- *+патогенетическим лечением пародонтита.
- патогенетическим лечением пародонтоза
- этиологическим лечением пародонтита
- симптоматическим лечением пародонтита
- профилактикой развития пародонтоза

#97

*!Каким требованиям НАИБОЛЕЕ вероятно должны отвечать временные шины при лечении болезней пародонта?

- *хорошо проводить электрический ток
- препятствовать лекарственной терапии
- *+надежно фиксировать шинируемые зубы
- травмировать слизистую оболочку десны
- неравномерно распределять жевательное давление

#98

*!Каким требованиям НАИБОЛЕЕ вероятно должны отвечать временные шины при лечении болезней пародонта?

- *хорошо проводить электрический ток
- препятствовать лекарственной терапии
- препятствовать смыканию зубов
- травмировать слизистую оболочку десны
- *+равномерно распределять жевательное давление

#99

*!Женщина 60 лет жалуется на невозможность жевания, боли в жевательных мышцах и височно-нижнечелюстных суставах. Протезы изготовлены месяц назад. Объективно: конфигурация лица нарушена. Губы смыкаются с усилием. Нижняя треть лица удлинена.

При улыбке оголяется базис полного съемного протеза на верхней челюсти, дикция нарушена.

Какая НАИБОЛЕЕ вероятная допущена ошибка?

- *определена передняя окклюзия
- *определена боковая окклюзия
- *+завышена высота прикуса
- *неправильно определена протетическая плоскость
- *снижена высота прикуса

#100

*!В клинику ортопедической стоматологии обратился мужчина 57 лет с жалобами на тупую боль в области правого внчс, усиливающуюся во время жевания. Заболевание началось постепенно со скованности движений нижней челюсти по утрам и имеет волнообразное течение. Объективно: лицо симметричное, рот открывается на 3 см. При открывании рта суставный шум и щелканье (ступенчатое смещение нижней челюсти). Кожа над суставом не изменена. Пальпаторно тонус мышц не изменен.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *артроз правого внчс
- *подвывих нижней челюсти
- *нейромускулярный синдром
- *+окклюзионно-артикуляционный синдром
- *острый артрит правого внчс

#101

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятными причинами расцементирования металлокерамических коронок?

- *+чрезмерная конусность культи зуба
- *чрезмерная толщина литого каркаса
- *усадка металла при литье
- *некачественное литье
- *деформация двухслойного слепка

#102

*!Все оттисковые материалы обладают рядом свойств, основным из которых НАИБОЛЕЕ вероятно является

- *простота в обращении
- *+эластичность
- *приятный цвет
- *пластичность
- *приятный вкус

#103

*!В каком месте НАИБОЛЕЕ целесообразно расположить уступ при препарировании зуба под фарфоровую коронку?

- *+по всему периметру шейки зуба
- *на вестибулярной поверхности
- *с оральной и апроксимальных сторон
- *на апроксимальных поверхностях
- *с оральной стороны

#104

*!Что из перечисленных НАИБОЛЕЕ вероятно относится к основным параметрам функциональной ценности зуба

- *воспаление десны и цвет зуба
- *цвет и размер зуба
- *+атрофия кости и подвижность зуба
- *подвижность зуба и зубные отложения
- *зубные отложения и воспаление десны

#105

- *!Перед снятием двухслойного слепка НАИБОЛЕЕ целесообразно сделать ретракция десны чтобы получить, или
- *+точный отпечаток поддесневой части зуба
- *точный отпечаток наддесневой части зуба
- *остановить кровотечение
- *обезболить десневой край
- *высушить поверхность культы зуба

#106

- *!Какая из перечисленных форм промежуточной части мостовидного протеза НАИБОЛЕЕ характерна при отсутствии зубов 22 и 23?
- *седловидная
- *промывная
- *+касательная
- *ступенчатая
- *диаторическая

#107

- *!При каких клинических ситуациях НАИБОЛЕЕ рационально изготовить мостовидные протезы?
- *дефект коронковой части зуба
- *патологическая стираемость
- *пародонтит тяжелой степени
- *+включенный дефект зубного ряда
- *концевой односторонний дефект зубного ряда

#108

- *!Какой из перечисленных клинических проявлений является НАИБОЛЕЕ вероятным противопоказанием к изготовлению металлокерамической коронки?
- *значительный наклон зуба
- *значительное разрушение коронки зуба
- * подвижность зуба первой степени
- *+подвижность зуба третьей степени
- *смещение зуба по вертикальной оси

#109

- *!Какой из перечисленных материалов НАИБОЛЕЕ рационален для временной фиксации несъемных протезов?
- *эластичные пластмассы
- *стеклоиономерный цемент
- *масляный дентин
- *+водный дентин
- *акриловые пластмассы

#110

- *!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятным показанием для изготовления культевой коронки?

- *подвижность зуба третьей степени
- *восстановление дефекта зубного ряда
- *ИРОПЗ = 0,4
- *ИРОПЗ = 0.6
- *+тотальное разрушение коронковой части зуба

#111

- *!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятным показанием для изготовления литой цельнометаллической коронки?
- *изменение цвета зуба
- *подвижность зуба третьей степени
- *ИРОПЗ = 0,4.
- *+использование зуба для опоры мостовидного протеза
- *тотальное разрушение коронковой части зуба

#112

- *!При проверке окклюзии восковой конструкции бюгельного протеза между искусственными и естественными зубами определяется не верный фиссурно-бугорковый контакт
- Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?
- *перестановка искусственного зуба непосредственно в полости рта,
- *перестановка искусственного зуба в лаборатории
- *+повторное определение центральной окклюзии
- *снятие оттисков
- *делать коррекцию на готовом протез

#113

- *!При выраженном рвотном рефлекс дугу бюгельного протеза НАИБОЛЕЕ целесообразно расположить
- *в передней трети твёрдого нёба
- *+в средней трети твёрдого нёба
- *в задней трети твёрдого нёба
- *в месте перехода средней трети твёрдого нёба в заднюю треть
- *на два мм спереди от линии А

#114

- *!В пределах каких тканей НАИБОЛЕЕ рационально провести избирательную пришлифовку зубов при пародонтите?
- *+эмали
- *дентина
- *экватора зуба
- *цемента корня
- *пульпы зуба

#115

- *!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ целесообразно провести после сошлифовывания твердых тканей зуба?
- *+полировку зубов
- *шлифовку зубов
- *анестезию
- *цементировку зубов
- *покрытие временной коронкой

#116

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ целесообразно провести после сошлифовывания твердых тканей зуба?

- *+обработку фторсодержащими препаратами
- *покрытие временной коронкой
- *цементировку зубов
- *шлифовку зубов
- *анестезию

#117

*! В случае потери от 20 до 40% твердых тканей моляра или премоляра, при котором имеется ослабление стенки полости НАИБОЛЕЕ целесообразно при изготовлении вкладок

- *+предусматривается создание одного или двух захватов к основной структуре вкладки
- *создание дополнительных захватов не обязательно,использование парапульпарных штифтов
- *создание дополнительных захватов ослабляет стенки полости
- *создание дополнительных захватов на усмотрение врача
- *создание дополнительных захватов зависит от степени подвижности зуба

#118

*!При тотальных дефектах коронковой части зуба (80-90% и более) НАИБОЛЕЕ рационально введения в конструкцию вкладки

- *+штифтов (у девитализированных зубов)
- *микроштифтов (у зубов с живой пульпой) и тотального козырька
- *введение штифтов не обязательно
- *необходимость введения тотального козырька определяется пациентом
- *введение штифтов и микроштифтов является ошибкой со стороны врача

#119

*!Какие конструкционные материалы НАИБОЛЕЕ целесообразны для изготовления микропротезов?

- *+фарфор, компомеры, сплавы металлов
- *нержавеющая сталь ,пластмасса
- *кобальто-хромовый сплав
- *сплавы титана, пластмасса
- *стекловолокна,керамика

#120

*!При изготовлении несъемных конструкций для восстановления формы и функции коронковой части зуба, НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать индекс

- *Пона,Пономаревой
- *+Миликевича
- *Шиллера-Писарева
- *Грина - Вермильона
- *Федорова-Володкина

#121

*!Система"Cerес",которыми оснащены современные стоматологические клиники-это

- *+изготовление ортопедических конструкций с помощью фрезерования
- *аппарат для снятия панорамной рентгенограммы и распечатывание ее
- *система для постановки зубов при полном отсутствии зубов в артикуляторе
- *система для полимеризации пластиночных протезов в вакууме под давлением
- *система для снятия коронок и мостовидных протезов

#122

*!При подготовке полости зуба под вкладку НАИБОЛЕЕ вероятно фальц формируют с целью

*предупреждения смещения,улучшения прочности

*исключения опрокидывающего момента,

*+лучшей фиксации и прилегания, предупреждение вторичного кариеса

*улучшения качества вкладки и ее прочности

*исключения рассасывания цемента,удлинения сроков пользования

#123

*!С какой целью НАИБОЛЕЕ вероятно в клинике ортопедической стоматологии используются вкладки?

*+восстановления дефекта коронки зуба

*восполнения дефекта зубного ряда

* фиксации консольного протеза

* постановки зубов

* определения параллельности зубов

124

*!В клинику обратился мужчина 68 лет с жалобами на плохое пережевывание пищи из-за отсутствия зубов. Объективно- имеется двухсторонний концевой дефект нижней челюсти, ограниченный боковыми резцами. Слизистая полости рта без видимой патологии.

Оставшиеся зубы мелкие

Какая ортопедическая конструкция НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*бюгельный протез на аттачменах

*бюгельный протез на кламмерах

*консольный протез с опорой на 32

*консольный протез с опорой на 42

*+частичный съемный протез

#125

*!В каком месте НАИБОЛЕЕ целесообразно расположить край штампованной коронки на зубе?

*на уровне анатомической шейки зуба

*на уровне клинической шейки зуба

*погружается под десну на 0,4мм

*погружается под десну на 0,2-0,3мм

*+погружается под десну на 0, 1-0,2мм

#126

*!Мужчина 35 лет, жалуется на отсутствие зубов на нижней челюсти справа. 36, 35 зубы отсутствуют. 37 зуб имеет медиальный наклон, на медиально-апроксимальной поверхности пломба эод-5 мкА.

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*+мостовидный протез с опорой на 34 зуб и вкладкой на 37 зуб

*мостовидный протез с опорой на 34, 37 зубы

*бюгельный протез

*частично съемный протез

*консольный протез с опорой на 34, 33 зубы

#127

*!Мужчине 35 лет, необходимо изготовить на 21 зуб металлокерамическую коронку. С целью профилактики осложнений вовремя одонтопрепарирования зуба под искусственную коронку

Какие НАИБОЛЕЕ обязательные требования к инструментам и методам?

- *мелкое зерно абразивного материала
- *малые обороты абразивного инструмента
- *малые обороты, водяное охлаждение
- * средние обороты
- *+высокие обороты бормашины, водяное охлаждение

#128

*!Мужчине 60 лет, изготавливается цельнолитой мостовидный протез, с опорой на 35 и 38 зубы. Пациент явился на клинический этап "проверка конструкции мостовидного протеза".

С помощью чего НАИБОЛЕЕ рационально определить наличие окклюзионных супраконтактов?

- *копировальной бумагой в центральной и передней окклюзиях
- *+артикуляционной бумагой во всех окклюзиях
- *мастикациографией
- *окклюзограммой во всех видах окклюзии
- *полоской воска в центральной окклюзии

#129

*!Применение каких мостовидных протезов НАИБОЛЕЕ приемливо провести без препарирования опорных зубов?

- *на временных коронках
- *на панцирных накладках
- *на полукоронках
- *на вкладках
- *+адгезивных

#130

*!Мужчина 28 лет, обратился через 3 дня после травмы с жалобами на боли в области тела нижней челюсти слева. Отмечается подвижность отломков в области 35. При попытке закрывания рта отмечается смыкание моляров-антагонистов слева. В центральном отделе и в области моляров справа смыкания зубов нет. На рентгенограмме в левой боковой проекции выявлена щель перелома в области 35. Диагноз: перелом тела нижней челюсти слева в области 35.

Какой из видов консервативного лечения НАИБОЛЕЕ рационален?

- *шина Порта
- *працевидная повязка Померанцевой-Урбанской
- *+двучелюстные шины с зацепными петлями
- *лигатурное связывание зубов
- *гладкая шина-скоба на нижнюю челюсть

#131

*!Мужчина 69 лет с полной потерей зубов жалуется на боль в углу нижней челюсти.

Протезами не пользовался. Объективно: незначительная припухлость, открытие рта затруднено. Рентгенологически: правосторонний костный перелом тела нижней челюсти в области отсутствующих 35 и 36 без дефекта кости.

Какую шину НАИБОЛЕЕ рационально использовать для лечения пациента?

- *Вебера
- *+Лимберга
- *Тигерштедта
- *Збаржа
- *Ванкевича

#132

*!У мужчины 32 лет, огнестрельный перелом н/ч. До ранения пользовался съемными протезами (частичными пластиночными для в/ч и полными для н/ч).

Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ рационально использовать для транспортной иммобилизации перелома?

- *аппарат Збаржа
- *шину Энтелиса
- *+протезы пациента
- *шину Васильева
- *шину Тигерштедта

#133

*!Мужчину 42 лет, госпитализировали с переломом верхней челюсти по типу Ле-фор 2. Выберите НАИБОЛЕЕ рациональный аппарат для лечения этого больного

- *Пенна-Брауна
- *Ядровой
- *Рудько
- *Кулагина
- *+Збаржа

#134

*!У мужчины 26 лет, ложный сустав нижней челюсти справа в области 44, 45 зубов с дефектом кости до 1 см. Присутствуют все зубы.

Какая НАИБОЛЕЕ оптимальная конструкция зубного протеза показана больному?

- *пластинчатый односуставной шарнирный протез по Оксману
- *+несъемный мостовидный протез с шарниром по Оксману
- *цельнолитой мостовидный пластиночный протез
- *пластинчатый шарнирный протез по Гаврилову
- *бюгельный протез на замковых креплениях

#135

*!На какие группы зубов НАИБОЛЕЕ рационально провести избирательную пришлифовку при пародонтите?

- *верхней челюсти
- *нижней челюсти
- *+верхней и нижней челюстей
- *в переднем отделе зубного ряда
- *в боковом отделе зубного ряда

#136

*!В каких из перечисленных клинических случаях применение несъемных мостовидных протезов является АБСОЛЮТНЫМ противопоказанием?

- *малые дефекты зубного ряда, ограниченные устойчивыми зубами
- *+концевые или включенные дефекты зубного ряда, дистально ограниченные подвижным зубом
- *отсутствие четырех резцов верхней челюсти
- *дефект зубного ряда, ограниченный зубами с одной функциональной группой
- *отсутствие двух резцов с одной стороны верхней челюсти

#137

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ предпочтительнее для снятия цельнолитых конструкций ?

- *разрезание коронок алмазным бором с небной стороны
- *+аппарат Коппа или аналогичный
- *электрофорез с 0,9 % раствором NaCl

- *локальное нагревание и охлаждение коронок
- *разрезание коронок вулканитовым диском с вестибулярной стороны

#138

*!Мужчине 37 лет в клинике изготавливают металлокерамическую коронку на 21 зуб. Когда НАИБОЛЕЕ целесообразно провести ретракцию десны?

- *перед припасовкой каркаса
- *после снятия оттиска
- *+перед получением оттиска
- *перед фиксацией
- *после припасовки каркаса

#139

*!У женщины 45 лет после протезирования штампованно-паяными протезом с опорой на 34-37 зубы появилось жжение, на кончике языка извращенные вкусовые ощущения. Какие манипуляции НАИБОЛЕЕ целесообразно следует провести для устранения этих явлений?

- *ввести пациенту антигистаминные препараты
- *провести интенсивное полоскание ротовой полости слабым раствором перманганата калия
- *заменить штампованно-паянный мостовидный протез на пластмассовый
- *обработать кончик языка хлоргексидином
- *+снять этот протез и изготовить новый, цельнолитой

#140

*!Мужчина 19 лет жалуется на разрушение зуба, нарушение эстетики. Объективно: коронка 24 зуба разрушена ниже десневого края. Корневые каналы запломбированы до апекса. Какую штифтовую конструкцию НАИБОЛЕЕ целесообразно применить в данном случае:

- *штифтовую конструкцию Ричмонда
- *+литую штифтовую конструкцию
- *штифтовую конструкцию Ильиной-Маркосян
- *стандартный штифтовый зуб
- *коронку Ахмедова

#141

*!Женщина 35 лет обратилась к врачу с жалобами на эстетический и фонетический дефект. Коронка 12 зуба отломилась 5 дней назад при откусывании твердой пищи. На рентгенографии корневой канал 12 зуба заполненный пломбировочным материалом до верхушки.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *отлом коронки 12 зуба
- *+травматический дефект коронки 12 зуба
- *перелом 12 зуба
- *травма 12 зуба
- *дефект коронки 12 зуба

#142

*!При отсутствии 25 и 26 зубов выносливость пародонта 24 зуба снижена наполовину, а у 27 и зубов антагонистов пародонт в норме.

В качестве опорных зубов при изготовлении мостовидного протеза НАИБОЛЕЕ рационально использовать

- *24 и 27
- *24, 27 и 28

- *+23, 24 и 27.
- *23, 24 и 27, 28
- *22, 23, 24 и 27

#143

*!У мужчины 60 лет в результате огнестрельного ранения образовался обширный дефект носа. От хирургического лечения больной временно отказался, и ему было предложено изготовление эктопротеза носа, удерживаемого с помощью оправы очков.

Какой оттисковой массой НАИБОЛЕЕ целесообразно получить у данного больного слепок с лица?

- *оттиск эластической массой с дефекта
- *оттиск термопластической массой со всего лица
- *гипсовый оттиск
- *оттиск термопластической массой с дефекта
- *+гипсовый оттиск со всего лица

#144

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно может быть использована в качестве опоры несъемного мостовидного протеза?

- *+коронки, полукоронки, вкладки
- *опорно-удерживающие кламмера
- * телескопические коронки
- * кламмеры, аттачмены
- *балочные системы, замки, штифты

#145

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно является основным недостатком цельнолитого мостовидного протеза?

- *быстрая истираемость
- плохая фиксируемость
- +значительное препарирование зуба.
- неточное прилегание к зубу в пришеечной области
- быстро меняется цвет протеза

#146

*!Мужчина 40 лет, обратился в клинику с жалобами на утрату жевательных зубов на нижней челюсти. Объективно: на верхней челюсти все зубы интактны, на нижней челюсти отсутствуют 46,47,34,36,37 зубы. Оставшие зубы интактны, однако клинические коронки 48 и 38 зуба очень низкие, 38 зуб слегка наклонен в сторону дефекта зубного ряда. Прикус ортогнатический

Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ рациональной конструкцией для замещения дефектов зубного ряда при данной клинической ситуации?

- *цельнолитые мостовидные протезы
- *частичный съемный протез
- *+бюгельный протез
- *паяные мостовидные протезы
- *адгезивные мостовидные протезы

#147

*!Женщина 36 лет обратилась с целью протезирования. Объективно: отсутствуют 18,17,16,15,25,26,27,28,38, зубы прикус ортогнатический, слизистая оболочка без видимых патологических изменений. Зубы, которые остались на нижней челюсти, стойкие, интактны, с хорошо выраженным экватором и фиссурами. 14 зуб изменен в цвете после эндодонтического лечения. Пациентка ставит высокие эстетические требования.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ показана?

- *+Бюгельный протез на замковых креплениях
- *Пластиночный протез на кламмерах
- *Бюгельный протез с литыми кламерами
- * Бюгельный протез с гнутыми кламерами
- * Бюгельный протез с телескопической системой фиксации

#148

*!Женщина. 26 лет, обратилась с целью протезирования. Объективно: на нижней челюсти двусторонний концевой дефект, ограниченный премолярами. Последнее удаление 2 недели назад. Верхние и боковые зубы имеют тенденцию относительного зубоальвеолярного выдвижения.

Какую НАИБОЛЕЕ рациональную конструкцию, необходимо использовать для предупреждения развития деформации?

- *частичный съемный пластиночный протез кламмерной фиксации
- *цельнолитые эстетические коронки на премоляры с разобщением зубных рядов на 1-1,5 мм
- *Консольные мостовидные протезы с опорой на два зуба с каждой стороны челюсти
- *+Бюгельный протез с последующим протезированием мостовидными протезами на имплантатах
- * Временные пластмассовые коронки на премоляры с разобщением зубных рядов на 1-1,5

#149

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ частыми причинами непригодности каркаса бюгельного протеза?

- *отсутствие зазора между каркасом и слизистой оболочкой в области седел
- *большая протяженность каркаса и сложность его концентрации
- *деформация каркаса
- *применение кламмеров разных типов
- *+отсутствие зазора между дугой и слизистой оболочкой, деформация каркаса

#150

*!Женщина 26 л, обратилась с целью протезирования. Объективно на нижней челюсти двухсторонний концевой дефект, ограниченный премолярами. Последнее удаление 2 недели назад. Верхние боковые зубы имеют тенденцию относительно зубоальвеолярного выдвижения

Какая НАИБОЛЕЕ рациональная конструкция для предупреждения развития деформации?

- *частичный съемный пластиночный протез с кламмерной фиксацией
- *цельнолитые эстетические коронки на премоляры с разобщением зубных рядов на 1-1.5 мм
- *консольные мостовидные протезы с опорой на 2 зуба с каждой стороны челюсти
- *+бюгельный протез с последующим протезированием мостовидными протезами на имплантатах
- *временные пластмассовые коронки на премоляры с разобщением зубных рядов на 1-1.5 мм

#151

*!В каких из перечисленных случаях НАИБОЛЕЕ часто используются двуслойный базис съемного пластиночного протеза?

- *в любом случае по желанию пациента, при равномерной податливости слизистой
- *+при неравномерной податливости мягких тканей протезного ложа и экзостозах
- *при низком альвеолярном гребне, хорошо увлажненной слизистой полости рта
- *при малом числе сохранившихся зубов и сухой слизистой полости рта

*при небольших дефектах зубных рядов и хорошо увлажненной слизистой

#152

*!При каких случаях НАИБОЛЕЕ целесообразно при изготовлении пластиночных протезов ставить зубы на приточке?

*низкий альвеолярный отросток в переднем отделе

*высокий альвеолярный отросток в боковом отделе

*+высокий альвеолярный отросток в переднем отделе

*низкий альвеолярный отросток в боковом отделе

*альвеолярный отросток средней высоты

#153

*!Что из перечисленного является НАИМЕНЕЕ выгодным креплением частичного съемного пластиночного протеза?

*диагональное

*+точечное

*трансверсальное

*сагиттальное

*плоскостное

#154

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ соответствует определению термина кламмеры по Кемени?

*опорно-удерживающие кламмеры

*металлопластмассовые пелоты

*+пластмассовые дентоальвеолярные кламмеры

*металлические многозвеньевые кламмеры

*телескопические системы

#155

*!Мужчина 68 лет, обратился в клинику с целью изготовления полного съемного протеза на в/ч. Объективно: на в/ч 2 тип по Оксману, слизистая оболочка 3 класса по Суппле. НАИБОЛЕЕ вероятная граница расположения полного съемного протеза у данного пациента?

*по активно-подвижной слизистой

*+по "клапанной" зоне

*выше активно-подвижной слизистой

*по переходной складке

*по пассивно-подвижной слизистой

#156

*!Мужчина 65 лет жалуется на плохую фиксацию протеза при разговоре. При приеме пищи фиксация протеза хорошая. Протез изготовлен 1 месяц назад.

В чем НАИБОЛЕЕ вероятная причина сбрасывания протеза у данного пациента?

*укорочена дистальная граница протеза по всему краю

*ошибка в снятии функционально-присасывающегося оттиска

*+ошибка в постановке зубов

*укорочена граница протеза по всему краю

*укорочена граница протеза во фронтальном участке

#157

*!Какая НАИБОЛЕЕ важная функция окклюзионной накладки?

*+передача жевательной нагрузки опорному зубу

*нагрузить или разгрузить опорный зуб от боковой нагрузки

- *восстановить нарушенный окклюзионный контакт с антагонистом
- *создать контакт протеза с опорным зубом
- *распределение давления на соседние зубы

#158

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ рациональным фиксирующим элементом в частичном пластиночном протезе?

- *переходная складка
- *базис протеза
- *искусственный зубной ряд
- *+кламмера, аттачмены
- *граница протеза

#159

*!В каких случаях НАИБОЛЕЕ рациональным при изготовлении частичного съемного пластиночного протеза считается применение бесцветной пластмассы?

- *в любом случае по желанию пациента
- *+при наличии аллергии на красители
- *при гиперсаливации, тошноте, рвоте
- *при парниковом эффекте
- *при гипосаливации, дискомфорте

#160.

У пациента 46 лет при протезировании мостовидным металлокерамическим протезом на опорные зубы 1.2; 2.1 во фронтальном сегменте какая форма промежуточной части необходима?

- *+касательная
- *чечевидная
- *серповидная
- *седловидная
- *зависит от состояния десны

#161.

У пациента 52 лет при обследовании полости рта на ортопедическом приеме выявлен односторонний концевой дефект зубного ряда на нижней челюсти, по классификации Кеннеди какой класс?

- *первому
- *+второму
- *третьему
- *четвертому
- *седьмому классу

#162.

У пациентки 55 лет при протезировании металлокерамическим мостовидным протезом какие зуботехнические методы изготовления данной конструкции применялись?

- *штамповка
- *протяжка
- *+литье
- *ковка
- д) волочение

#*163.

У пациента 68 лет при осмотре полости рта врач стоматолог ортопед поставил диагноз: "Дефект зубного ряда на нижней челюсти 3-класс по Кеннеди". Выбрана конструкция:

съемный мостовидный протез с опорами на 37 и 33 зубы. Вследствие каких причин рекомендована данная конструкция мостовидного протеза?

*из-за подвижности опорных зубов, ограничивающих дефект

*из-за включенного бокового дефекта зубного ряда

*+из-за большой протяженности дефекта зубного ряда

*из-за глубокого прикуса, при смыкании зубов

*из-за большой конвергенции зубов, ограничивающих дефект

#164.

У пациента 50 лет на ортопедическом приеме при осмотре полости рта обнаружен дефект зубного ряда зубная формула: 1817161501211/ 2122232425000. Поставьте диагноз и определите жевательную эффективность по Агапову:

*III класс IV подкласс по Кеннеди, 20 %

*I класс III подкласс по Кеннеди, 40 %

*III класс I подкласс по Кеннеди, 50 %

*III класс IV подкласс по Кеннеди, 60 %

*+II класс III подкласс по Кеннеди, 26 %

#165.

Врач стоматолог-ортопед после осмотра полости рта пациента 52 лет, рекомендует бюгельный протез на нижнюю челюсть. При анализе гипсовой модели в параллелометре, предлагает изготовить 5-тип опорно-удерживающего кламмера системы Нея. Укажите дефект зубного ряда больного?

*двухсторонний концевой дефект-ограничен премолярами

*односторонний концевой дефект-ограничен премолярами

*+включенные дефекты в боковом отделе с одиночно стоящими молярами

*включенные дефекты в переднем отделе с одиночно стоящими премолярами

*одиночно стоящие премоляры на верхней и нижней челюсти

#1655.

Мужчина 53 года обратился с жалобами на жжение, металлический привкус во рту. При осмотре: имеются металлический мостовидный протез на верхней челюсти и золотые коронки на зубах нижней челюсти с правой стороны. Какой из перечисленных ниже предварительных диагнозов наиболее вероятен?

*а) Аллергический стоматит

*б) Токсический стоматит

*в) Протезный стоматит

*+г) Явления непереносимости

*д) Парниковый эффект

#166.

Женщина 54 лет предъявляет жалобы на жжение в полости рта после протезирования. При осмотре: на верхней челюсти имеются старые металлические мостовидные протезы и новый частичный съемный платиночный протез на нижней челюсти. Какую из перечисленных ниже диагностических методов наиболее целесообразно провести?

*а) Электроодонтодиагностику

*б) Одонтопародонтограмму

*в) Гнатодинамометрию

*г) Оклюзиограмму

*+д) Кожные пробы

#167.

У пациента при осмотре наблюдается мостовидный протез верхней челюсти с опорными коронками на 2.3-2.6 зубы. 2.7-2.8 зубы отсутствуют. После снятия мостовидного протеза

рекомендовано удаление 2.6 зуба, так как зуб полностью разрушен. Поставьте диагноз:

- *+а) I класс по Гаврилову
- *б) II класс по Гаврилову
- *в) III класс по Гаврилову
- *г) IV класс по Гаврилову
- *д) V класс по Гаврилову

#168.

На 3-й день после снятия мостовидного протеза с опорами 3.5; 3.8 зубов под анестезией, больной обратился с жалобами на «плохое» открывание рта. На месте вкола и введения анестетика признаки воспаления отсутствуют. Зубы интактные, перкуссия, зондирование безболезненны. Какое осложнение развилось у больного?

- *а) Неврит нижнелуночного нерва
- *б) Воспалительная контрактура
- *+в) Постинъекционная контрактура
- *г) Анкилоз ВНЧС
- *д) Парез лицевого нерва

#169.

После снятия мостовидного протеза больной обратился с жалобами на «плохое» открывание рта. При обследовании больного, врач поставил диагноз: Постинъекционная контрактура. Ваша тактика лечения.

- *а) Антибактериальная терапия, ЛФК
- *+б) Физиолечение, механотерапия, ЛФК
- *в) Новокаиновые блокады, физиолечение
- *г) Лучевая терапия, механотерапия
- *д) Контурная пластика, ЛФК

#170.

Больной Ж. 52 года обратился с жалобами на ощущение привкуса металла и чувство кислоты во рту. Анамнез: протезировался 2 месяца назад. Объективно: слизистая оболочка полости рта без изменений, в полости рта имеются протезы из разнородных материалов (мостовидные протезы из сплава золота, нержавеющей стали), прикус фиксированный. Кожные пробы на никель, хром, кобальт отрицательные. Наиболее вероятным диагнозом является:

- *а) Аллергический стоматит
- *б) Травматический стоматит
- *+в) Гальванооз
- *г) Химико-токсический стоматит
- *д) Токсический стоматит

#171.

У пациентки 70 лет, при протезировании частичными съёмными пластиночными протезами на первом клиническом этапе сняты полные анатомические оттиски, альгинатными массами. Каковы критерии качества и требования анатомического оттиска?

- *а) слепок хорошо складывается в стандартную ложку, отображает протезное ложе. Края закруглены, поверхность без пор, выступает на 1, 5-2,0 см. от ложки.
- *б) слепок хорошо отражает рельеф протезного ложа, четко отражены шейки зубов. Толщина слепка более 6мм. Без пор и раковин.
- *в) отображает микро рельеф протезного ложа, переходные складки, зубной рельеф контуры межзубных промежутков и шеек, без пор, трещин, воздушных раковин, толщина слепка 2 мм
- *г) слепок четко отражает рельеф протезного поля, края ровные, закруглены.
- *+д) гипсового слепка плотно прилегают друг к другу. Слепок четко отражает рельеф

протезного ложа, переходную складку, зубной ряд, контуры межзубных промежутков и шеек зубов. Толщина слепков от бортов и дна стандартной ложки 3-4 мм, края ровные, закруглены, поверхность без размывов и воздушных раковин.

#172. Пациент 45 лет обратился в стоматологическую клинику с целью протезирования под металлокерамические коронки фронтальной группы зубов 12,11,21,22 перечислить последовательность клинических этапов изготовления металлокерамических коронок?

- *+а) обследование, обезболивание, препарирование, снятие слепка, припасовка колпачка, определение цвета, припасовка коронки, сдача
- *б) обследование, снятие слепка, препарирование, припасовка коронки, определение цвета, сдача
- *в) снятие слепка, припасовка колпачка, припасовка коронки, определение цвета, сдача
- *г) препарирование зуба, обследование, припасовка колпачка, определение цвета, сдача .
- *д) обследование, припасовка коронки, определение цвета, фиксация на цемент

#173.

Опорная металлическая вкладка мостовидного протеза не должна превышать высоту прикуса с целью:

- *профилактики ее отлома
- *+профилактики перегрузки опорных зубов
- *профилактики развития вторичного кариеса
- *распределения жевательного давления на тело протеза
- *распределения жевательного давления на опорные зубы

#174.

Какое осложнение может возникнуть после протезирования штифтовым зубом по Ильиной-Маркосян, если кубической формы вкладка неплотно прилежит к сформированной полости в устье корневого канала:

- *-подвижность антагониста
- *-отлом коронковой части
- *+расцементировка штифта
- *-воспалительные изменения в периодонте
- *-воспалительные изменения в краевой десне

#175. Выберите рациональную ортопедическую конструкцию у пациента с отсутствием 4.4 зуба и подвижностью зубов (1 степени) ограничивающих дефект, учитывая, что согласно одонтопародонтограмме по Курляндскому В.Ю. изготовление несъемных шин-протезов показано при резобции (атрофии) костной ткани альвеолярных частей менее $\frac{1}{4}$ длины корня:

- *-бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами на 4.3, 4.5 и 4.6
- *+мостовидный протез с опорой на 4.3, 4.5 и 4.6
- *-мостовидный протез с опорой на 4.3, 4.5
- *-частичный съемный протез
- *-имплантат в области 4.4

#176.

У пациента 30 лет, отсутствует 3.3 зуб. Учитывая возраст пациента и современные аспекты протезирования, а также, то, что соседние с дефектом зубы относятся к двум разным функциональным группам, определите, какую ортопедическую конструкцию предпочтительнее изготовить:

- *-пластмассовый мостовидный протез с опорой на 3.2 и 3.4 зубы
- *-штампованный мостовидный протез с опорой на 3.2 и 3.4 зубы
- *-металлокерамический консольный протез с опорой на 3.4 зуб
- *-консольный металлический протез с опорой на 3.4 зуб

*+имплантат в области 3.3 зуба

#178.

Как сошлифовывают ткани с боковых поверхностей зуба под штампованную коронку с целью предупреждения попадания пищи в межзубные промежутки, и плотного прилегания коронки к шейке зуба:

- *-на толщину материала
- *-меньше периметра шейки зуба
- *+равными периметру шейки зуба
- *-равными периметру режущего края
- *-соответственно вершине межзубного десневого сосочка

#179.

Создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под фарфоровую коронку обуславливает:

- *-травму пародонта
- *+ослабление фиксации
- *-затрудненное наложение
- *-снижение жевательной эффективности
- *-эстетический дефект в области шейки зуба

#180.

При изготовлении штампованного консольного несъемного протеза отрицательным является:

- *-препарирование большого количества зубов
- *-неудовлетворительное эстетическое качество
- *-необходимость депульпирования опорных зубов
- *+наличие опрокидывающего момента в области опорных зубов
- *-сошлифовывание большого количества тканей опорных зубов

#190.

При переднем наклоне модели на столике параллелометра задний край модели:

- *-ниже переднего края модели
- *+выше переднего края модели
- *-на одном уровне с передним краем модели
- *-расположен параллельно фронтальной плоскости
- *-расположен параллельно горизонтальной плоскости

#191.

Какой наклон модели при параллелометрии выбирают, для расположения линии обзора у фронтальных зубов верхней челюсти с вестибулярной поверхности, ближе к десне, и с целью эстетического расположения плеча кламмера:

- *-передний
- *+задний
- * -нулевой
- * -правый
- * -левый

#192.

Причина нечеткого отображения поддесневого уступа препарированного зуба в двухслойном оттиске:

- *+плохо проведенная ретракция десны
- *-высокая текучесть корригирующего слоя
- *-излишняя компрессия при снятии оттиска

- *-недостаточная увлажненность культи зуба
- *-слишком большое количество корригирующей массы

#193.

При прямом способе гипсовки после раскрытия кюветы в ее основании находятся:

- *-гипсовая модель
- *-гипсовая модель, кламмеры
- *-искусственные зубы и кламмеры
- *-искусственные зубы, гипсовая модель
- *+гипсовая модель, искусственные зубы, кламмеры

#194.

Съемный пластиночный протез, изготавливаемый при включенном дефекте зубного ряда, нуждается в припасовке в полости рта вследствие:

- *-возможных ошибок при постановке искусственных зубов
- *+наличия поднатурений в области естественных зубов
- *-нарушений пропорций при подготовке пластмассы
- *-нарушений режима полимеризации пластмассы
- *-индивидуальных особенностей протезного ложа

#195.

Свободное наложение пластиночного протеза (при дефекте зубного ряда) на этапе его припасовки может быть затруднено вследствие:

- * -занижения высоты нижнего отдела лица
- * -завышения высоты нижнего отдела лица
- * -ошибки при постановке искусственных зубов
- * -дефектов базиса при недопаковке пластмассы
- * +прилегания базисной пластмассы к шейкам зубов

#196.

Причиной завышения высоты нижнего отдела лица вследствие утолщения базиса съемного протеза является:

- * -неточность снятия оттиска
- *-нарушение режима полимеризации пластмассы
- * +неплотное соединение частей кюветы при паковке пластмассы
- * -отсутствие изоляции поверхности гипсовой модели от пластмассы
- * -деформация протеза в момент извлечения его из кюветы после полимеризации

#197.

Причинами непригодности каркаса бюгельного протеза является:

- * -ощущение во рту инородного тела при припасовке и наложении каркаса
- * -большая протяженность каркаса и сложность его конструкции
- * +отсутствие зазора между дугой и слизистой оболочкой
- *-применение кламмеров разных типов
- * -появление повышенной саливации

#198.

Степень атрофии альвеолярного отростка (альвеолярной части) определяется уровнем расположения вершины гребня по отношению к:

- *+переходной складке
- *-зубам-антагонистам
- *-шейкам естественных зубов
- *-межалвеолярному расстоянию

*-окклюзионной поверхности естественных зубов

#199.

Функциональные изменения височно-нижнечелюстного сустава после полной утраты зубов:

- *-уплощение суставной ямки
- *-атрофия суставного бугорка
- *+увеличение амплитуды движений нижней челюсти
- *-истончение и разволокнение внутрисуставного диска
- *-атрофия тела верхней челюсти, углубление собачьей ямки

#200.

Повторная фиксация центрального соотношения челюстей методом наложения восковой пластинки на искусственные зубы нижней челюсти возможна при:

- *-смещении нижней челюсти влево
- *-смещении нижней челюсти вправо
- *-смещении нижней челюсти вперед
- *-завышении высоты нижнего отдела лица
- *+снижении высоты нижнего отдела лица

#201

Физико-биологический метод фиксации съемного протеза обеспечивается:

- *-замковыми креплениями и функциональной присасываемостью
- *-функциональной присасываемостью и кламмерами
- *+адгезией и функциональной присасываемостью
- *-кламмерами и замковыми креплениями
- *-замковыми креплениями и адгезией

#202.

На этапе определения центрального соотношения челюстей при включенных дефектах зубного ряда, межальвеолярная высота - это расстояние между:

- *+ гребнями альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей
- *-вершинами бугров моляров верхней и нижней челюстей
- *-режущими краями резцов верхней и нижней челюстей
- *-губными уздечками верхней и нижней челюстей
- *-основанием крыльев носа и краем подбородка

#203.

В основном, заготовительном помещении зуботехнической лаборатории выполняются

- *-Литейные работы
- *-Полировальные работы
- *+Основные работы по изготовлению зубных протезов
- *-Полимеризационные работы
- *-Работы с гипсом

#204.

У паяных золотых мостовидных протезов по сравнению со стальными

- *-Выше гальванизм и выше твердость
- *-Выше гальванизм, но ниже твердость
- *-Ниже гальванизм, но выше твердость
- *+Ниже гальванизм и ниже твердость
- *-Гальванизм и твердость одинаковы

#205.

Перелом коронки зуба на уровне с краем десны является показанием к протезированию

- *-Искусственной коронкой
- *-Вкладкой
- *-Мостовидным протезом
- *+Штифтовой конструкцией
- *-Съемным протезом

#206.

Определение окклюзии:

- *+Частный вид артикуляции
- *-Состояние физиологического покоя
- *-Смыкание зубных рядов при различных положениях н/ч
- *-Тип прикуса
- *-Вид смыкания искусственных зубов

#207.

К четвертому классу дефектов зубного ряда по Гаврилову относится:

- *-Включенный дефект в боковом отделе
- *-Односторонний концевой дефект
- *-Двухсторонний концевой дефект
- *-Включенный дефект в переднем отделе
- *+Одиночно стоящий зуб

#208.

Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть:

- *-Круговая щечная, собственно жевательная
- *-Височная, наружная шиловидная, грудиноключичнососцевидная
- *-Внутренняя крыловидная мышца грушевидного отверстия, щечная
- *-Собственножевательная шиловидная, височная
- *+Собственножевательная, височная, внутренняя крыловидная

#209.

С появлением разрушенных зубов в ВНЧС наиболее вероятно развитие:

- *-Артрита
- *-Привычного вывиха сустава
- *+Дисфункции сустава: окклюзионноартикуляционного синдрома
- *-Дисфункции сустава: нейромускулярного синдрома
- *-Подвывиха сустава

#210.

Особенности изготовления коронок и мостовидных протезов на зубы с разрушенной коронковой частью:

- *-Особенности отсутствуют
- *-Зубы подлежат удалению
- *+Разрушенные зубы нужно предварительно восстановить культевыми вкладками или анкерными штифтами
- *-Разрушенные зубы нужно предварительно восстановить пломбой
- *-Разрушенные зубы нужно предварительно восстановить металлическими колпачками слитой поверхностью

#211.

На верхней челюсти отсутствует 18, 17, 16, 15, 24, 25, 26, 28 зубов. 27 зуб наклонен незначительно в мезиальную сторону. Торус резко выражен. Нижний зубной ряд интактен. Ортопедическое лечение в данной ситуации:

- *+Бюгельный протез на верхней челюсти с фиксацией с 13, 14, 23, 27 зубам
- *-Съемный пластиночный протез
- *-Шинирующий бюгельный протез
- *-Первый и второй ответы правильные
- *-Несъемного протезирования с применением имплантов

#212.

Отсутствуют два зуба 34 и 35. Поставьте диагноз:

- *-Дефект зубного ряда 1класс по Кеннеди
- *-Дефект зубного ряда 2класс по Кеннеди
- *+Дефект зубного ряда 3класс по Кеннеди
- *-Дефект зубного ряда 4класс по Кеннеди
- *-Дефект зубного ряда 5класс по Кеннеди

#213.

Укажите причину ошибки при наличии следующих признаков:

- 1.сглаженность носогубных и подбородочных складок при разговоре;
- 2.отсутствие просвета между зубами в состоянии физиологического покоя:

- *Снижение высоты нижнего отдела лица
- *+Завышение высоты нижнего отдела лица
- *-Сдвиг нижней челюсти медиально
- *-Сдвиг нижней челюсти дистально
- *-Мышечные контрактура

#214.

Укажите причину ошибки при наличии следующих признаков:

- 1.выраженность носогубных и подбородочных складок;
 - 2.избыток мягких тканей нижней трети лица
- наличие просвета между зубами в состоянии физиологического покоя в пределах 68 мм:
- *-Сдвиг нижней челюсти медиально
 - *+Снижение высоты нижнего отдела лица
 - *-Повышение высоты нижнего отдела лица
 - *-Сдвиг нижней челюсти дистально
 - *-Повышенная стираемость зубов

#215.

При проверке конструкции полных съемных протезов обнаружено: повышение прикуса с неравномерным и неопределенным бугровым контактом боковых зубов, просвет между фронтальными зубами. Возможная ошибка допущенная при определении центральной окклюзии:

- *-Смещение верхнего базиса с валиком вперед
- *-Смещение нижнего базиса с валиком назад
- *+Смещение нижней челюсти вперед
- *-Деформация верхнего воскового базиса
- *-Компрессия слизистой оболочки альвеолярных отростков во фронтальном участка челюсти

#216.

Слизистая оболочка, покрывающая верхнюю челюсть атрофична, зона небного шва широкая, место выхода сосудистонервных пучков при пальпации болезненны. Вид оттиска -

- *-Компрессионный
- *+Декомпрессионный
- *-Дифференцированный

- *-Функциональноприсасывающиеся
- *-Анатомический

#217.

Слизистая оболочка, покрывающая верхнюю и нижнюю челюсти, имеет различную степень податливости. Небный торус, небные складки. Вид оттиска -

- *-Компрессионный
- *-Декомпрессионный
- *+Дифференцированный
- *-Функциональноприсасывающиеся
- *-Анатомический

#218.

Зондирование используется в ортопедической стоматологии:

- *-Для выявления болевой реакции периодонта
- *-Определения тонуса мышц и податливости слизистой, выявления скрытых костных выступов
- *+Определения глубины зубодесневых желобков и пародонтальных карманов, глубины кариозной полости и чувствительности ее стенок
- *-Для удаления зубного камня
- *-Для удаления камня из слюнного протока

#219.

К четвертому классу полостей по классификации Блека относятся полости, расположенные:

- *-На контактной поверхности боковых зубов
- *-На жевательноконтактных поверхностях боковых зубов
- *-На контактных поверхностях передних зубов
- *+На контактных поверхностях передних зубов с поражением углов коронки
- *-В пришеечной зоне вестибулярной поверхности всех зубов

#220. К первому классу дефектов зубного ряда по Кеннеди относится:

- *-Односторонний концевой дефект
- *Двухсторонний концевой дефект
- *-Двухсторонний включенный дефект в боковом отделе
- *-Включенный дефект в переднем отделе
- *-Односторонний включенный дефект в боковом отделе

#221.

При частичной потере зубов зубные ряды в функциональном отношении распадаются на две основные группы зубов:

- *-Наклоненные или перемещенные в сторону дефекта
- *-Имеющие или не имеющие соседних зубов
- *+Находящиеся под нормальной нагрузкой или в условиях функциональной перегрузки
- *-Имеющие антагонистов (функционирующая группа) или утратившие их (нефункционирующая группа)
- *-Анатомические и функциональные

#222.

Свойства сшитого сополимера зависят:

- *-От длины цепочки макромолекул
- *-От величины молекулярной массы
- *+От соотношения мономеров
- *-От пропорции мономер, полимер

*-От количества поперечных связей между макромолекулами

#223.

За величину атрофии костной ткани альвеолы принимается размер, полученный при зондировании:

- *-С вестибулярной стороны
- *-Оральной стороны
- *-Медиальной стороны
- *-Дистальной стороны
- *+Независимо от стороны, но наибольший

#224.

Свойства наполнителя улучшающие свойства гетерогенной пластмассы:

- *-Плотности
- *-Шарикообразной формы частиц наполнителя
- *-Шероховатости частиц наполнителя
- *+За счет возникновения между ними химической связи или адгезивности
- *-Одинакового удельного веса

#225.

Основные стадии процесса полимеризации:

- *-Приготовление смеси мономер-полимер, 1:1
- *-Приготовление смеси мономер-полимер, 1:2
- *-Приготовление смеси мономер-полимер, 2:1
- *+Инициирование (активация), рост полимерной цепи, обрыв цепи
- *-Песочная, клейкая, тестообразная, резиноподобная, твердая

#226.

Под пластмассовую коронку зуб препарируется с уступом:

- *+Обязательно
- *-Только на вестибулярной поверхности
- *-Если он депульпирован
- *-Необязательно
- *-Если больной старше 25 лет

#227.

Если во время осмотра полости рта больного у врача возникло подозрение на наличие сифилиса, врач должен:

- *-Продолжить осмотр и начать лечение стоматологического заболевания
- *-Сообщить больному о своем подозрении и прекратить прием
- *-Отказать больному в стоматологической помощи
- *+Завершить осмотр больного и отправить на анализ крови
- *-Все ответы верны

#228.

Для какой стабилизации зубного ряда используется съемные шинирующие протезы:

- *-Дуговая стабилизация
- *-Парасагитальная стабилизация
- *-Фронтальная стабилизация
- *+Парафронтосагитальная стабилизация
- *-Сагитальная стабилизация

#229.

Комбинации местных анестетиков с вазоконстрикторами:

- *-Увеличивают длительность местной анестезии
- *-Увеличивают длительность местной анестезии и усиливают ее эффективность
- *+Увеличивают длительность местной анестезии, усиливают ее эффективность и уменьшают токсичность
- *-Не увеличивают длительность местной анестезии
- *-Увеличивают длительность местной анестезии

#230.

В искусственной коронке, наложенной пациенту 60 лет, жевательные бугры:

- *-Должны быть хорошо выражены
- *-Должны быть представлены слабо при отсутствии антагонистов
- *+Не должны быть выражены
- *-Моделируются в соответствии с формой и выраженностью бугров зубов-антагонистов
- *-Выражены слегка

231.

Промежуточная часть (тело) мостовидного протеза в переднем отделе зубного ряда верхней челюсти по отношению к слизистой оболочке располагается:

- *-Касательно
- *-В виде седла
- *+С промывным пространством (висячая форма)
- *-Произвольно
- *-Зависит от протяженности дефекта зубного ряда

#232.

При полном дефекте коронковой части 11 зуба принято решение провести его ортопедическое лечение с применением фарфоровой искусственной коронки из соображений обеспечения максимального эстетического эффекта. Вид штифтово-культевую конструкцию использующиеся в этом случае для формирования протезного ложа под фарфоровую коронку:

- *-Литую индивидуальную металлическую штифтово-культевую вкладку
- *+Стандартный стекловолоконный штифт в сочетании формированием культы коронки зуба из гелиокомпозита прямым способом
- *-Стандартный металлический анкерный штифт в сочетании с формированием культы зуба из гелиокомпозита прямым способом
- *-Культевую штифтовую вкладку из галодента
- *-Простой штифт в сочетании с формированием культы зуба из пластмассы прямым способом

#233.

При проверке конструкции частичного съемного протеза на верхней челюсти определяется повреждение модели в области передних небных складок. Тактика врача при этом:

- *-изготовить съемный протез на этой модели с последующей коррекцией
- *+вновь снять оттиски и повторить клинические и лабораторные этапы
- *-устранить повреждение модели с помощью жидкого гипса
- *-не обращать на это внимание
- *-снять функциональный оттиск коррегирующим материалом на восковой конструкции съемного протеза

#234.

На вестибулярной поверхности 11, 12, 21, 22 зубов определяются чашеобразные углубления овальной формы. На дне углублений эмаль истончена, и через нее просвечивает дентин желтоватого цвета. Дно, стенки и края углубления гладкие. Дефекты

локализуются в области экватора и при шеечной области, режущие края резцов сохранены. Диагноз: гипоплазия эмали. Вид конструкций зубного протеза показана в данном случае:

- *-Искусственные коронки
- *+Виниры
- *-Полукоронки
- *-Трехчетвертные коронки
- *-Восстановительные пломбы

#235. При починке съемного пластиночного протеза нижней челюсти в связи с потерей естественного зуба необходимо получить оттиск:

- *-С нижней челюсти без протеза
- *-С нижней челюсти вместе с протезом
- *-С обеих челюстей без протеза на нижней челюсти
- *-С верхней челюсти и нижней челюсти вместе с протезом
- *+С обеих челюстей без протеза на верхней челюсти

#236.

Ко второму классу дефектов зубного ряда по Кеннеди относится:

- *+Односторонний концевой дефект
- *-Двухсторонний концевой дефект
- *-Двухсторонний включенный дефект в боковом отделе
- *-Включенный дефект в переднем отделе
- *-Односторонний включенный дефект в боковом отделе

#237.

Функция окклюзионной накладки:

- *-Удержание протеза
- *-Шинирование зубов
- *+Распределение жевательной нагрузки
- *-Непрямая фиксация протеза
- *-Устранить дефект

#238.

Частичные съемные пластиночные протезы восстанавливают жевательную эффективность:

- *-до20%
- *+50%
- *-70%
- *-90%
- *-100%

#239.

Часть поверхности коронки зуба, расположенная между разделительной (межевой) линией и жевательной (режущей) поверхностью зуба, называется:

- *-Зоной поднутрения
- *+Окклюзионной зоной
- *-Ретенционной зоной
- *-Кламмерной зоной
- *-Межевая линия

#240.

В классификации Шредера представлены:

- *-Пять типов атрофии беззубой нижней челюсти

- *-Три типа атрофии беззубой нижней челюсти
- *+Три типа атрофии беззубой верхней челюсти
- *-Два типа атрофии беззубой нижней челюсти
- *-Четыре типа атрофии беззубой нижней челюсти

#241. Назовите физиологические типы прикуса:

- *-Прогнатия, прогения, ортогнатия
- *-Прогения, прямой, открытый
- *-Прямой, прогнатия, прогения
- *-Открытый, прямой, прогнатия
- *+Прямой, ортогнатия, бипрогнатия

#242. Клинические этапы изготовления искусственной штампованной коронки:

- *-Обследование, препарирование, снятие слепка, отливка модели, припасовка и сдача коронки
- *-Препарирование, снятие слепка, моделировка коронковой части, штамповка, припасовка коронки
- *-Обследование, снятие слепка, отливка контрштампа, окончательная штамповка, сдача коронки
- *+Обследование, препарирование, снятие слепка, припасовка коронки, сдача фиксации на цемент
- *-Снятие слепка, предварительная и окончательная штамповка, отбеливание, фиксация на цемент

#243.

Врач стоматолог во время обследования пациента определил дефект зубного ряда нижней челюсти III - класс по Кеннеди. Атрофия альвеолярного отростка умеренная. Какой вид дентальной имплантации из перечисленных ниже наиболее целесообразен:

- *-Субмукозная
- *+Эндооссальная
- *-Субпериостальная
- *-Трансмандибулярная
- *-Эндонто-эндооссальная

*244.

Гнатодинамометрия:

- *-Исследует микротоки в полости рта
- *-Исследует движение нижней челюсти
- *-Регистрирует биопотенциалы мышц
- *+Определяет выносливость пародонта к жевательному давлению
- *-Исследование морфологических особенностей

*245.

К какому виду фиксации относятся аттачмены:

- *-К физическому
- *+К механическому
- *-К химическому
- *-К биологическому
- *-К комбинированному

*246.

Какое кламмерное крепление считается надежным с биомеханической точки зрения и почему:

- *-Точечное - минимально нарушает эстетические нормы

- *-Линейное - шинирует имеющиеся зубы в полости рта
- *+Плоскостное - исключает опрокидывание или вращение протеза
- *-Одностороннее- не создает ретенционных пунктов
- *-Двухстороннее - удерживает протез во время функции жевания

#247.

При изготовлении несъемных конструкций для восстановления формы и функции коронковой части зуба, наиболее целесообразно использовать индекс:

- *-Попа
- *+Миликевича
- *-Шиллера-Писарева
- *-Грина - Вермильона
- *-Федорова-Володкина

#248.

Какая форма суставного бугорка развивается при ортогнатическом прикусе:

- *-Крутое
- *-Плоское
- *+Средневыпуклое
- *- Выпуклое
- *-Овальное

#249.

Анатомическая коронка - это:

- *-Часть зуба, выступающая над десной
- *-Самая широкая часть коронки зуба
- *+Часть зуба, покрытая эмалью
- *-Область перехода коронки в корень
- *-Широкая часть зуба

#250.

Клиническая коронка - это:

- *+Часть зуба выступающая над десной
- *-Область перехода коронки в корень
- *-Часть зуба, покрытая эмалью
- *-Самая широкая часть коронки
- *-Широкая часть зуба

#251.

Окклюзиограмма - определение:

- *+Метод определения и анализа окклюзионных контактов, получаемых на тонких пластинках воска при смыкании зубных рядов
- *-Метод определения межокклюзионной высоты при смыкании зубных рядов
- *-Метод определения выраженности воспалительного процесса
- *-Метод определения степени подвижности зубов
- *-Метод выбора рационального протезирования

#256.

Окклюзионная плоскость-определение:

- *+Плоскость, проведенная от режущего края резцов н/ч к вершине медиально-щечного бугорка второго моляра
- *-Плоскость, проведенная от режущих краев передних зубов до жевательных бугорков жевательных зубов
- *-Плоскость, проведенная по окклюзионной поверхности зубов н/ч

*-Плоскость, проведенная от режущих краев передних зубов до бугорков жевательных зубов

*-Это плоскость, проведенная от режущего края центрального резца н/ч к вершине дистального щечного бугорка второго моляра, или середине ретромолярного бугорка

#257.

Оценка качества анатомического слепка:

*-Слепок хорошо складывается в стандартную ложку, отображает протезное ложе. Края закруглены, поверхность без пор, выступает на 1, 5-2см от ложки;

*-Слепок хорошо отражает рельеф протезного ложа, четко отражены шейки зубов. Толщина слепка более 6мм. Без пор и раковин.

*-Отражает рельеф протезного ложа, переходные складки. Без пор, воздушных раковин, толщина слепка 2мм

*-Слепок четко отражает рельеф протезного поля, края ровные, закруглены

*+Все части гипсового слепка плотно прилегают друг к другу. Слепок четко отражает рельеф протезного ложа, переходную складку, зубной ряд, контуры межзубных промежутков и шеек зубов. Толщина слепков от бортов и дна стандартной ложки 3-4 мм, края ровные, закруглены, поверхность без размывов и воздушных раковин

#258.

При отсутствии резцов и клыков пациенты предъявляют жалобы:

*+На эстетический дефект, нарушение речи, невозможность откусывания пищи

*-На нарушение речи, западение щек, нарушение пережевывания пищи

*-На эстетический дефект, нарушение приема пищи, на образование заед в углах рта

*-На боль в области височно-нижнечелюстных суставов

*-На невозможность откусывания пищи

#259.

Дайте правильное определение понятия "клинический экватор":

*-Наиболее широкая часть клинической коронки

*-Самая выпуклая часть клинической коронки

*+Наиболее выпуклая часть клинической коронки на вестибуло-оральной поверхности зуба при его функционально-пространственном положении в альвеолярном отростке

*-Клинической экватор есть анатомический экватор

*-Наиболее узкая часть клинической коронки

#260.

Дайте правильное определение понятия "клиническая шейка":

*-Воображаемая линия, проходящая на уровне анатомической шейки зуба

*+Воображаемая линия, проходящая на уровне края слизистой десны в пришеечной части коронки зуба

*-Воображаемая линия, которая делит зуб на коронку и корень

*-Воображаемая линия, проходящая на уровне перехода эмали в цемент

*-Воображаемая линия, проходящая по самой выпуклой части клинической коронки

#261.

Назовите ткань зуба, составляющую основную массу клинической коронки зуба:

*-Эмаль

*+Дентин

*-Пульпа

*-Кутикула эмали

*-Цемент

#262.

Какие из указанных биофизических свойств эмали помогают выдерживать жевательное давление:

- *+Физиологическая прочность, твердость
- *-Неравномерная толщина
- *-Радиальное положение эмалевых призм
- *-Кутикула эмали
- *-Упругость эмали

#263.

Каково значение пульпы для зуба:

- *-Ткань внутренней среды
- *-Ткань межсистемных взаимоотношений
- *+Нервно-рецепторный аппарат зуба, трофическая функция
- *-Сохраняет форму коронки зуба
- *-Трофическая функция

#264.

Кто из ученых специально изучал толщину стенок передних зубов у лиц разного возраста:

- *-Voisson
- *-М.С.Липец
- *+Н.Г.Аболмасов., Е.И.Гаврилов
- *-Б.С.Клюев., Е.И.Гаврилов
- *-В.Н.Копейкин

#265.

Какие формы верхних центральных резцов характерны для людей нормостенического типа:

- *+Зубы любой формы с незначительным преобладанием высоты над шириной
- *-Зубы узкие, длинные, прямоугольные
- *-Зубы овальные, широкие, короткие
- *-Зубы овальные, длинные узкошейные
- *-Зубы прямоугольные, короткие, широкие

#266.

Какие формы верхних резцов характерны для людей астенического типа:

- *-Зубы овальные, широкие, короткие
- *+Зубы узкие, длинные, прямоугольные
- *-Зубы любой формы с незначительным преобладанием высоты над шириной
- *-Зубы овальные, длинные, узкошейные
- *-Зубы прямоугольные, короткие, широкие

#267.

Какие формы верхних резцов характерны для людей гиперстенического типа:

- *+Зубы овальные, широкие, любой формы с незначительным преобладанием высоты над шириной
- *-Зубы овальные, длинные, узкошейные
- *-Зубы узкие, длинные, прямоугольные
- *-Белый с различными оттенками отдельных в естественном зубе
- *-Зубы прямоугольные, короткие

#268.

Содержание углерода в сплаве придает

- *+Повышение коррозионной стойкости
- *-Повышение пластичности

- *-Облегчение обработки давлением
- *-Повышение твердости
- *-Повышение плотности

#269.

Избыточное образование ткани зуба в процессе его развития

- *-Флюороз
- *+Гиперплазия
- *-Гипоплазия
- *-Эрозия твердых тканей
- *-Дисплазия Капдепона

#270.

Как называется II этап функции, составляющий процесс менеджмента

- *+Организация
- *-Руководство
- *-Управление
- *-Планирование
- *-Прогнозирование

#271.

Как называется I этап функции, составляющий процесс менеджмента

- *-Организация
- *-Руководство
- *-Управление
- *+Планирование
- *-Контроль

#272.

При припасовке паянного каркаса бюгельного протеза на н/ч обнаружено, что протез балансирует на протезном ложе. Опорно-удерживающие кламмера I типа по Нею на 3.4,3.3,4.4 неплотно прилегают к зубам в области вестибулярного плеча, находящегося полностью выше линии обзора. При давлении на каркас в области седла, каркас смещается вверх и назад. Зубная формула: 00004321/12300000 Альвеолярные отростки в области дефектов зубного ряда значительно атрофированы. Объясните возможные причины балансирования каркаса и определите дальнейшую тактику врача?

- *+Деформация каркаса вследствие смещения деталей при пайке - необходимо снять новые оттиски и вновь изготовить каркас
- *-Большая протяженность каркаса и сложность его конструкции - необходимо заменить кламмер на 2 тип по Нею.
- *-Усадка металла во время литья – необходимо провести коррекцию каркаса бюгельного протеза
- *-Нарушение режима полимеризации– необходимо провести перебазировку каркаса
- *-Наличие поднутрения области дефекта зубного ряда - необходимо снять новые оттиски и изготовить модели

#273.

Больному запланировали бюгельные протезы на в/ч и н/ч. Сняли анатомические слепки. Отлили из высокопрочного гипса модели. Приготовленную модель изучают в параллелометре; в лаборатории техник начал подводить к каждому опорному зубу грифель, но по данной методике параллелометрии разделительная линия не совпадала с анатомическими экваторами зубов. Какой метод параллелометрии описан?

- *-Метод выявления среднего наклона длинных осей опорных зубов
- *+Произвольный метод

- *-Метод выбора
- *-Метод параллелометрии
- *-Метод определения экватора

#274.

Больной А., 45 лет обратился в клинику для ортопедического лечения. При осмотре - зубная формула: 00054321/1230000. Сохранившиеся зубы устойчивы, интактны, имеют хорошо выраженную анатомическую форму. Альвеолярные отростки умеренно атрофированы, слизистая оболочка альвеолярных отростков и твердого неба плотная, умеренно податливая. Поставьте диагноз:

- *+I класс по Кеннеди
- *-II класс по Кеннеди
- *-III класс по Кеннеди
- *-IV класс по Кеннеди
- *V класс по Гаврилову

#275.

Больной 30 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на боли в области 2.7 зуба. При проведении осмотра полости рта врач отметил положительную реакцию зуба на перкуссию. В области жевательной поверхности имеется вкладка из металла. Какие методы исследования понадобятся врачу для постановки диагноза?

- *-ЭОД
- *-Термодиагностика
- *-Зондирование
- *-Одонтопародонтограмма
- *+Рентгенография

*278.

У при осмотре выявлено – односторонний концевой дефект верхней челюсти. Поставьте диагноз:

- *-I класс по Кеннеди
- *+II класс по Кеннеди
- *-III класс по Кеннеди
- *-IV класс по Кеннеди
- *-IV класс по Гаврилову

#279.

У больного 4.1,4.2,3.1,3.2 зубы подвижны вестибулооральном и медиодистальном направлении. Определите степень подвижности зубов?

- *-I степень по Энтину
- *+II степень по Энтину
- *-III степень по Энтину
- *-IV степень по Энтину
- *-V степень по Энтину

#280.

При осмотре больного выявлена: верхние передние зубы выдвинуты вперед, между верхними и нижними передними зубами щель. Соотношение шестых зубов: медиальный щечный бугор верхнего 2.6 зуба находится на одноименном бугорке нижнего или между 3.5 и 3.6 зубами. Определите тип прикуса:

- *-Ортогнатический
- *+Прогнатический
- *-Прогенический
- *-Вынужденная прогения

*-Бипрогнатия

#281.

При осмотре больного выявлена: нижние передние зубы перекрывают верхние передние зубы, между верхними и нижними передними зубами щель. Соотношение шестых зубов: медиальный щечный бугор 2.6 зуба находится между 2.6-2.7 зубами. Определите тип прикуса:

*-Ортогнатический

*-Прогнатический

*+Прогенический

*-Опистогнатия

*-Бипрогнатия

#282.

У пациента при осмотре наблюдается мостовидный протез верхней челюсти с опорными коронками на 2.3-2.6 зубы. 2.7-2.8 зубы отсутствуют. После снятия мостовидного протеза рекомендовано удаление 2.6 зуба, так как зуб полностью разрушен. Поставьте диагноз:

*+I класс по Гаврилову

*-II класс по Гаврилову

*-III класс по Гаврилову

*-IV класс по Гаврилову

*-V класс по Гаврилову

#283.

Во время припасовки металлического каркаса 2.3 зуба произошло завышение прикуса. Определите тактику врача?

*-Переделывание металлического каркаса

*-Снятие повторного слепка

*+Стачивание металлического каркаса

*-Штампование металлического каркаса

*-Препарирование 2.3 зуба

#284.

При припасовке штампованной металлической коронки на нижний первый премоляр шейка коронки короткая. Определите тактику ортопеда?

*+Препарирование 3.5 зуба

*-Расширение шейки коронки на 3.5 зуб

*-Переделка коронки на 3.5 зуб

*-Удлинение шейки коронки 3.5 зуба

*-Сужение шейки коронки на 3.5 зуб

#285.

У больного при осмотре выявлено - зубная формула: 80004321/12340008

Планируется изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть. Сколько моделей необходимо отлить и их функция?

*-3 модели - рабочая, вспомогательная, анатомическая

*+2 модели - рабочая, диагностическая

*-2 модели - рабочая, вспомогательная

*-2 модели - функциональная, анатомическая

*-3 модели - функциональная, диагностическая, вспомогательная

#286.

На 3-й день после снятия мостовидного протеза с опорами 3.5; 3.8 зубов под анестезией, больной обратился с жалобами на «плохое» открывание рта. На месте вкола и введения

анестетика признаки воспаления отсутствуют. Зубы интактные, перкуссия, зондирование безболезненны. Какое осложнение развилось у больного?

- *-Неврит нижнелуночного нерва
- *-Воспалительная контрактура
- *+Постинъекционная контрактура
- *-Анкилоз ВНЧС
- *-Парез лицевого нерва

#287.

После снятия мостовидного протеза больной обратился с жалобами на «плохое» открывание рта. При обследовании больного, врач поставил диагноз: Постинъекционная контрактура. Ваша тактика лечения.

- *-Антибактериальная терапия, ЛФК
- *+Физиолечение, механотерапия, ЛФК
- *-Новокаиновые блокады, физиолечение
- *-Лучевая терапия, механотерапия
- *-Контурная пластика, ЛФК

#288.

Больной явился в стоматологическую поликлинику с целью протезирования. При осмотре – включенный дефект в боковом отделе. Поставьте диагноз:

- I класс по Кеннеди
- II класс по Кеннеди
- +III класс по Кеннеди
- IV класс по Кеннеди
- V класс по Гаврилову

#289

Двухсторонний концевой дефект нижней челюсти какому классу относятся по Кеннеди?

- *А) II класс
- *В) III класс
- *С) IV класс
- *+D) I класс
- *Е) V класс

#290

К какому виду фиксации относятся аттачмены:

- *А) к физическому
- *+В) к механическому
- *С) к химическому
- *D) к биологическому
- *Е) к комбинированному

#291

Коронковая часть 13 зуба разрушена, Индекс разрушения окклюзионных поверхностей зубов (ИРОПЗ) >0,7. Прикус глубокий. Какую конструкцию штифтового зуба предлагаете?

- *А) штифтовый зуб по Ричмонду
- *В) простой штифтовый зуб
- *+С) цельнолитой штифтовый зуб
- *D) культевая коронка
- *Е) культевая штифтовая вкладка

#292

Больной 30 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на постоянное выпадение пломбы. При осмотре коронка 2.6 разрушена на 1/3 высоты коронки зуба, зуб запломбирован, антагонизирующие зубы не в контакте. Для изготовления на 2.6 зуб восстановительную металлическую штампованную коронку, врач отпрепарировал 2.6 зуб, снял частичный анатомический слепок с верхней челюсти. При припасовке коронки было выявлено, что коронка завывает окклюзию. На каком этапе допущена ошибка, почему завывает окклюзия?

- *А) 1-лабораторный этап, неправильно смоделирован зуб;
- *В) 1-лабораторный этап, неправильно штампована коронка;
- *+С) 1-клинический этап, неправильно сняли слепок;
- *D) 1-клинический этап, неправильно препарирован зуб;
- *Е) 1- лабораторный этап, неправильно получена модель;

#293

Во время припасовки штампованной металлической коронки на 3.7 зуб, коронка завывает центральную окклюзия. Препарированный зуб имеет цилиндрическую форму, между окклюзионной поверхностью и антагонистами имеется горизонтальная щель в толщину 0,2 мм. Между соседними зубами при зондировании зонд проходит свободно. На каком этапе была допущена ошибка и какая?

- *А) на 1-клиническом этапе, неправильное препарирование зуба
- *В) на 2-клиническом этапе, неправильно определена центральная окклюзия
- *С) на 1-лабораторном этапе, неправильно отлита модель
- *D) на 1-лабораторном этапе, неправильно смоделирован зуб
- *Е) на 1-лабораторном этапе, неправильно определена клиническая шейка зуба

#294

На 2-клиническом этапе изготовления металлокерамической коронки металлический каркас без усилий припасовывается на культю зуба, точно прилегает к уступу, межокклюзионная щель с зубами-антагонистами 0,5 мм, толщина металлического колпачка 0,8 мм. Какие могут быть осложнения?

- *А) расцементировка коронки
- *В) плохая фиксация коронки
- *+С) скол керамической массы
- *D) эстетический дефект коронки
- *Е) продырявливание металлического колпачка

#295

У больного отсутствует 2.2;2.3;2.4;2.5;2.6 зубы, 1.1; 2.1; 2.7 зубы интактные, патологические изменения не выявлены, врач рекомендует больному изготовить металлокерамические мостовидные протезы с опорами на 1.1;2.1 и 2.7 зубы. Правильно ли выбраны опорные зубы и конструкция протеза?

- *А) Правильно – мостовидные протезы полностью восстанавливают жевательное давление
- *В) Неправильно – опорные зубы не депульпированы
- *+С) Неправильно – большая нагрузка на опорные зубы
- *D) Правильно – эстетично, быстро привыкает к протезу
- *Е) Неправильно - количество опорных зубов недостаточно

#296

Больной 48 лет, обратился с просьбой изготовить мостовидный протез при отсутствии 2.1;1.1;2.2 зубов. На этапе припасовки комбинированного мостовидного протеза из металла с пластмассовыми фасетками врач припасовал протез на опорные зубы и обнаружил, что в положении центральной окклюзии смыкаются только верхние резцы с фасетками, а остальные зубы не смыкаются. Припой в месте пайки между коронкой 13 зуба и промежуточной частью касается десневого сосочка. Ваши дальнейшие действия?

- *А) освободить десневой сосочек от припоя и установить мостовидный протез в глубже
- *В) освободить десневой сосочек от промежуточной части мостовидного протеза
- *+С) освободить десневой сосочек от припоя и удалить контактный участок фасетки
- *D) освободить десневой сосочек от фасетки и припоя, допрепарировать опорные зубы
- *Е) освободить десневой сосочек от припоя, допрепарировать зубы антагонисты;

#297

Больной 50 лет обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов на нижней челюсти. Зубы удалялись вследствие осложненного кариеса 5 лет назад. Зубы устойчивые.

Зубная формула: 87654321/12340078

Диагноз? Выберите наиболее рациональную конструкцию протеза.

- *А) Дефект зубного ряда по Кеннеди 3 класс, металлический мостовидный протез
- *В) Дефект зубного ряда по Кеннеди 2 класс, металлокерамический мостовидный протез
- *+С) Дефект зубного ряда по Кеннеди 3 класс, металлокерамический мостовидный протез
- *D) Дефект зубного ряда по Кеннеди 4 класс, комбинированный мостовидный протез из пластмассы
- *Е) Дефект зубного ряда по Кеннеди 3 класс, пластмассовый мостовидный протез;

#298

Какое клammerное крепление считается надежным с биомеханической точки зрения и почему?

- *А) точечное - минимально нарушает эстетические нормы
- *В) линейное - шинирует имеющиеся зубы в полости рта
- *+С) плоскостное - исключает опрокидывание или вращение протеза
- *D) одностороннее - не создает ретенционных пунктов
- *Е) двухстороннее - удерживает протез во время функции жевания

#299

Эффективно ли применение металлических штампованных коронок при патологической стираемости II степени боковых зубов, почему?

- *А) эффективно, потому что восстанавливает прикус на толщину металлических штампованных коронок
- *+В) не эффективно, потому что возможны осложнения, связанные с травмой маргинального пародонта краем коронки
- *С) не эффективно, потому что не восстанавливает анатомическую форму стертых зубов в боковом отделе
- *D) эффективно, потому что толстый слой цемента между жевательной поверхностью стертых зубов и окклюзионной поверхностью коронки препятствует продвижению края коронки под десну
- *Е) не эффективно, потому что толщина металлических штампованных коронок не достаточна для восстановления прикуса

#300

У больного беззубая верхняя челюсть. Атрофия альвеолярного отростка средней степени, маловыраженные бугры, средняя глубина неба, выраженный торус. Ваш диагноз?

- *А) полная вторичная адентия, I – тип по Оксману
- *+В) полная вторичная адентия, II- тип по Оксману
- *С) полная вторичная адентия, II- тип по Суппле
- *D) полная вторичная адентия, III- тип по Оксману
- *Е) полная вторичная адентия, III- тип по Суппле

#301

Больному при припасовке индивидуальной ложки на нижнюю челюсть с использованием функциональных проб по Гербсту, в момент глотания слепочная ложка смещается с нижней челюсти, ваша тактика?

*+А) ложку необходимо укоротить на участке от места позади бугорка до челюстно-подъязычной линии

*В) ложку в таких случаях укорачивают по вестибулярному краю сзади

*С) ложку укорачивают по вестибулярному краю спереди

*D) ложку укорачивают вдоль челюстно-подъязычной линии

*Е) ложку укорачивают в зоне между клыками с вестибулярной стороны

(Правильный ответ) =А

#302

На 3-м клиническом этапе после введения восковых конструкций протеза, в положении центральной окклюзии имеется щель между фронтальными зубами, при смещении н/ч вперед зубы смыкаются плотно по всей зубной дуге. На каком этапе произошла ошибка, из-за чего?

*А) на 2-клиническом этапе, при определении ЦО зафиксирована боковая окклюзия;

*В) на 2-лабораторном этапе, при постановке искусственных зубов;

*С) на 2-лабораторном этапе, модели неправильно зафиксированы в окклюдатор;

*+D) на 2-клиническом этапе, при определении ЦО зафиксирована передняя окклюзия;

Е) на 2-клиническом этапе, восковая конструкция протеза деформирована;

#304

У больного на нижней челюсти двухсторонний концевой дефект зубного ряда.

Зубная формула : 00004321 / 12340000

Был изготовлен частичный съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами на 34 и 44 зубы. Какой вид кламмерной фиксации съемного протеза указан?

*+А) трансверзальный

*В) поперечный

*С) точечный

*D) сагитальный

*Е) диагональный

#305

При введении в полость рта восковой композиции частичных съемных пластиночных протезов в/ч и н/ч нижняя треть лица удлинена, губы смыкаются с трудом, складки лица сглажены, при разговоре имеется еле заметная щель между фронтальными зубами, слышен стук зубов. Все антагонизирующие зубы смыкаются равномерно и плотно. Какая ошибка была допущена и ваша тактика?

*А) высота прикуса завышена- шлифовать окклюзионный поверхность боковых зубов

*В) неправильная постановка фронтальных зубов- разогреть воск и глубже установить фронтальные зубы

*С) высота прикуса занижена- зависить прикус разогретой пластинкой воска

*D) высота прикуса завышена- шлифовать окклюзионный поверхность фронтальных зубов

*+Е) высота прикуса завышена- заново определить центральную окклюзия

#306

У больного диагноз : «Дефект зубного ряда на нижней челюсти 3-класс по Кеннеди».

План лечение: составной мостовидный протез с опорами на 37 и 33 зубы

Почему выбрана такая конструкция протеза?

*А) из-за подвижности опорных зубов, ограничивающих дефект

*В) из-за включенного бокового дефекта зубного ряда

- *+С) из-за большой конвергенций зубов, ограничивающих дефект
- *D) из-за большой протяженности дефекта зубного ряда
- *E) из-за глубокого прикуса, при смыкании зубов

#307

Зубная формула: 87650321 / 12345000

Поставьте диагноз и определите жевательную эффективность по Агапову:

- *A) III класс IV подкласс по Кеннеди, 20 %
- *+B) II класс III подкласс по Кеннеди, 30 %
- *C) I класс III подкласс по Кеннеди, 40 %
- *D) III класс I подкласс по Кеннеди, 50 %
- *E) III класс IV подкласс по Кеннеди, 60 %

#307

Врач рекомендует больному бюгельный протез на нижнюю челюсть. Изучая модель в параллелометре, предлагает изготовить 5-тип опорно-удерживающего кламмера системы Нея. Укажите дефект зубного ряда больного?

- *A) двухсторонний концевой дефект-ограничен премолярами
- *B) односторонний концевой дефект-ограничен премолярами
- *C) включенные дефекты в переднем отделе с одиночно стоящими премолярами
- *+D) включенные дефекты в боковом отделе с одиночно стоящими молярами
- *E) одиночно стоящие премоляры на верхней и нижней челюсти

#308

К лабораторному методу исследования в ортопедической стоматологии относятся:

- *A) перкуссия
- *+B) рентгенография
- *C) миография
- *D) мионометрия
- *E) изучение диагностической модели

#309

Больному запланировали бюгельные протезы на в/ч и н/ч. Сняли анатомические слепки. Отлили из высокопрочного гипса модели. Приготовленную модель изучают в параллелометре; в лаборатории техник начал подводить к каждому опорному зубу грифель, но по данной методике параллелометрии разделительная линия не совпадала с анатомическими экваторами зубов.

Какой метод параллелометрии описан?

- *A) метод выявления среднего наклона длинных осей опорных зубов
- *+B) произвольный метод
- *C) метод выбора
- *D) метод параллелометрии
- *E) метод определения экватора

#310

Культия зуба цилиндрической формы, где диаметр клинической шейки зуба равен диаметру зуба на уровне клинического экватора, но с дополнительной препаровкой вестибулярной поверхности сохраняет конусовидную форму с уступом на уровне десны, разобщение зубов антагонистов в прикусе 1,5-2,0 мм. Под какую искусственную коронку отпрепарирован данный зуб?

- *A) штампованно-металлическая
- *B) фарфоровая
- *+C) комбинированная
- *D) пластмассовая

*Е) экваторная коронка

#311

Пациенту был изготовлен штампованно-паянный мостовидный протез. Десна в области протеза гиперемированна, отечна. При зондировании края коронки не обнаруживаются. На каком этапе была допущена ошибка?

- *А) на 1-клиническом
- *В) на 1-лабораторном
- *С) на 2-клиническом
- *D) на 2-лабораторном
- *+Е) на 3-клиническом

#312

Больной А., 47 лет обратился в клинику для ортопедического лечения с диагнозом:

«Дефект зубного ряда в/ч II класс по Кеннеди ».

Зубная формула: 00054321 ! 12340000

Сохранившиеся зубы устойчивы, интактны, имеют хорошо выраженную анатомическую форму. Альвеолярные отростки умеренно атрофированы, слизистая оболочка альвеолярных отростков и твердого неба плотная, умеренно податливая.

План лечения - изготовить бюгельный протез на верхнюю челюсть.

Какие оттисковые материалы применяются для снятия оттисков при изготовлении данного протеза?

- *+А) эластические
- *В) твердокристаллические
- *С) термопластические
- *D) гидроколлоидные
- *Е) полиэфирные

#313

Какое кламмерное крепление считается надежным с биомеханической точки зрения и почему?

- *А) точечное- минимально нарушает эстетические нормы
- *В) линейное- шинирует имеющиеся зубы
- *+С) плоскостное- исключает опрокидывание или вращение протеза
- *D) одностороннее- не создает ретенционных пунктов
- *Е) двухстороннее- удерживает протез во время функции

#314

Больной, 38 лет. Обратился с жалобами на боли в области 11 зуба. При осмотре патологии твердых тканей не выявлено. В анамнезе отмечает механическую травму.

Какие методы обследования следует провести?

- *А) мастикациография
- *В) одонтопародонтограмма
- *+С) рентгенография
- *D) реография
- *Е) миография

#315

Больной С., 27 лет, обратился с целью протезирования. Объективно: высота нижнего отдела лица не изменена. Слизистая полости рта бледно-розовой окраски.

Зубная формула: 870054321/12345678. Ваш диагноз?

- *А) 1 класс по Кеннеди.
- *В) 2 класс по Кеннеди
- *+С) 3 класс по Кеннеди

*D) 4 класс по Кеннеди

*E) 5 класс по Кеннеди

#316

Больной К., 25 лет, жалуется на повышенную чувствительность зубов к внешним раздражителям. При осмотре полости рта: 22,21/11,12 зубах по режущему краю имеется полулунная вырезка. Стенки, края и дно углублений гладкие. Сформулируйте диагноз.

*+A) гипоплазия

*B) гиперплазия

*C) эрозия

*D) клиновидный дефект

*E) флюороз

#317

Больной М.. 36 лет, обратился в клинику с целью протезирования. Анамнез: зубы удалены вследствие осложненного кариеса, ранее не протезировался.

Объективно: Зубная формула: 00000321/12345678

Слизистая оболочка бледно розового цвета, без видимых патологических изменений.

Прикус по типу ортогнатического. Выберите конструкцию протеза.

*+A) частично-съёмный пластиночный протез.

*B) полный съёмный пластиночный протез

*C) съёмный мостовидный протез

*D) адгезивный мостовидный протез

*E) пластмассовые каппы

#318

Больная обратилась с жалобами на полное отсутствие зубов на нижней челюсти. Ранее протезировалась.

Объективно: Лицо симметричное. Нижняя треть лица снижена.

Слизистая покрывающая альвеолярные отростки и небо атрофирована натянута тонким слоем. Места прикрепления естественных складок расположены близко к вершине альвеолярного отростка, резкая, равномерная атрофия альвеолярного отростка. Поставьте диагноз.

*A) 2 тип по Оксману, 1 класс по Суппле, потеря жевательной эффективности по Агапову 100%;

*B) 1 тип по Оксману, 3 класс по Суппле, потеря жевательной эффективности по Агапову 100%;

*+C) 3 тип по Оксману, 2 класс по Суппле, потеря жевательной эффективности по Агапову 100%;

*D) 4 тип по Оксману, 4 класс по Суппле, потеря жевательной эффективности по Агапову 100%;

*E) 2 тип по Оксману, 2 класс по Суппле, потеря жевательной эффективности по Агапову 100%;

#319

Больной Б.. 33 года, обратилась с жалобами на изменение цвета передних зубов и частое выпадение пломбы.

Объективно:

876543пп/п2345678. Диагноз: Дефект коронки 11,12,21 зубов. Выберите конструкцию протеза.

*A) вкладка

*B) штифтовый зуб

*C) литая коронка

*+D) металлокерамическая коронка.

*Е) пластмассовая полукоронка

#320

Больному запланировали полные съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти. На 4 лабораторном этапе техник записал модели в кювету и оставил затвердевать. После начал вываривать воск и опустил модели в кипящую воду и промыл в течение 3 минут, дал остыть. Затем произвел паковку пластмассы, продавил под прессом и опустил в кипящую воду кювету и варил 30 минут.

Какая допущена ошибка и возможные осложнения.

*А) несоблюдение технологии приготовления пластмассового теста приводит к расширению пластмассы.

*В) несоблюдение технологии приготовления пластмассового теста приводит к появлению микротрещин.

*С) температурный режим полимеризации не нарушен не приводит к появлению микротрещин.

*D) технология приготовления пластмассового теста не нарушена не приводит к расширению пластмассы.

*+Е) нарушение температурного режима полимеризации приводит к дефектам готовых изделий

#321

Больной К., обратился с жалобами на отсутствие зубов, затрудненный прием пищи.

в\ч 0000000!00000000; н\ч 0000321!12345000

Слизистая бледно-розового цвета, уздечки и щечные тяжи на в\ч расположены близко к вершине альвеолярного гребня, на н\ч оставшиеся зубы устойчивые, перкуссия б/б, выявлена равномерная атрофия альвеолярного отростка.

На этапе проверки конструкции протеза врач заметил, что при улыбке пациента видна альвеолярная часть протеза. На каком этапе допущена ошибка и какая?

*А) на лабораторном этапе - постановка на искусственной десне

*В) на клиническом этапе - неправильно подобраны искусственные зубы

*С) на лабораторном этапе – перекрестная постановка

*+D) на лабораторном этапе- постановка на «приточке»

*Е) на клиническом этапе – неправильно определен тип прикуса

#322

При изготовлении какой несъемной шины препарированием делают параллельные пазы на верхних зубах включенных в шину и почему:

*+А) шины из полукоронки- обеспечивает надежную иммобилизацию

*В) кольцевая шина- улучшает параллельность опорных зубов

*С) колпачковая шина- обеспечивает хорошую фиксацию

*D) экваторная шина- улучшает лечебные свойства

*Е) коронковая шина- выгодна в эстетическом отношении

(Правильный ответ) =А

#323

У больного отсутствует 32,33,34,35,36 зубы, врач решил изготовить больному металлокерамический мостовидный протез с опорами на 31 и 37 зубы. Правильно ли выбрана конструкция протеза и почему?

*А) правильно – мостовидные протезы полностью восстанавливают жевательное давление;

*В) неправильно – опорные зубы не депульпированы;

*+С) неправильно – большая нагрузка на опорные зубы;

*D) правильно – эстетично, быстро привыкает к протезу;

*Е) неправильно - количество опорных зубов недостаточно;

#324

Больной М., обратился с жалобой на боли при накусывании на 26 зуб. Из анамнеза неделю назад на 26 зуб изготовлена металлическая коронка, при временном пользовании коронкой до фиксации болевых ощущений не было. Ваша тактика?

- *+А) снятие коронки с зуба
- *В) назначить противовоспалительную терапию
- *С) назначить обезболивающие
- *D) депульпировать зуб через коронку
- *Е) удаление зуба с коронкой

#325

Больной С., 57 лет, обратилась в клинику с жалобами на чувство жжения под протезом. Анамнез: неделю назад был изготовлен частичный съемный пластиночный протез. Спустя 2 дня появилась чувство жжения и покалывания. При осмотре полости рта: на верхней челюсти имеется съемный пластиночный протез, который соответствует всем технологическим и клиническим требованиям. Слизистая оболочка твердого неба и альвеолярного отростка слегка гиперемирована, отечна, соответственно протезному ложу и границам ЧСПП. Поставьте диагноз.

- *А) острый стоматит
- *В) травматический стоматит
- *+С) аллергический стоматит
- *D) афтозный стоматит
- *Е) рецидивирующий стоматит

#326

Больной А., 61 год. Жалобы на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. Объективно: Лицо симметричное, кожные покровы чистые, носогубные складки выражены, нижняя треть лица снижена. В полости рта: на в/ч зубы полностью отсутствуют, на н/ч сохранились 35, 34, 33, 43, 44 зубы, перкуссия б/б, устойчивы. После сдачи врачом полного съемного протеза на в/ч и частичного съемного - на н/ч через несколько дней больной предъявил жалобы на боли в области ВНЧС и прикусывание щеки слева. На каком этапе была допущена ошибка и какая?

- *+А) на клиническом этапе – неправильное определение центрального соотношения челюстей
- *В) на клиническом этапе – деформация прикусного валика во время определения центральной окклюзии
- *С) на лабораторном этапе – неправильная постановка искусственных зубов
- *D) на лабораторном этапе – ошибка во время заливки моделей в кювету
- *Е) на лабораторном этапе – нарушен режим полимеризации

#327

Больному В., 39 лет, с диагнозом: дефект коронки 16 зуба была изготовлена штампованная коронка из золота. Во время припасовки коронки врач не смог наложить коронку на зуб. В чем заключается причина невозможности наложения искусственной коронки на зуб?

- *А) толщина коронки не соответствует толщине снятия твердых тканей зуба
- *+В) узкая коронка
- *С) недопрепарирован зуб
- *D) длинная коронка
- *Е) коронка с жевательной поверхности залита припоем

#328

Больной М., 20 лет, обратился с жалобой на боли при накусывании на 26 зуб. Из анамнеза неделю назад на 26 зуб изготовлена металлическая коронка. Укажите возможную причину боли в 26 зубе.

- *А) вторичный кариес
- *В) острый пульпит
- *С) острый периодонтит
- *+D) травматический периодонтит
- *Е) травматический узел

#329

Больной М., обратился с жалобой на боли при накусывании на 26 зуб. Из анамнеза неделю назад на 26 зуб изготовлена металлическая коронка, при временном пользовании коронкой до фиксации болевых ощущений не было. Ваша тактика?

- *+А) снять коронку с зуба
- *В) назначить полоскание
- *С) назначить обезболивающие
- *D) депульпировать зуб через коронку
- *Е) направить на рентген снимок

*330

При припасовке металлического колпачка он очень свободно садится на культю, а края лежат на десне. Была ли допущена ошибка и почему?

- *А) очень тонкий слой компенсационного лака
- *+В) чрезмерный слой компенсационного лака
- *С) заполнение слепка очень жидким супергипсом
- *D) заполнение слепка очень густым супергипсом
- *Е) слишком быстрый подъем температуры до 250 С при прогреве муфеля

#331

Наиболее целесообразная тактика при протезировании больных с полной потерей зубов и наличии незначительно выраженного небного торуса:

- *А) изоляция торуса
- *В) укорочение протеза
- *С) хирургическое вмешательство
- *+D) получение дифференцированного оттиска
- *Е) моделирование базиса протеза с отверстием для торуса.

#332

Больной А., 51 год. Жалобы на полное отсутствие зубов на верхней челюсти.

Объективно: Лицо симметричное, кожные покровы чистые, носогубные складки выражены, нижняя треть лица снижена. В полости рта: на в/ч зубы полностью отсутствуют, на н/ч сохранились 35, 34, 33, 43, 44 зубы, перкуссия б/б, устойчивы. После сдачи врачом полного съемного протеза на в/ч и частичного съемного - на н/ч через несколько дней больной предъявил жалобы на боли в области ВНЧС и прикусывание щеки слева. Ваше дальнейшее действие?

- *А) перебазировка базиса протеза
- *В) перепостановка искусственных зубов
- *+С) переделка протезов
- *D) консультация хирурга -стоматолога
- *Е) консультация терапевта-стоматолога

#333

Какой слепок снимается при изготовлении мостовидных протезов при формировании промежуточной части мостовидного протеза:

- *+А) полный анатомический слепок
- *В) слепок в прикусе
- *С) частичный слепок
- *D) функциональный слепок
- *Е) дифференцированный слепок.

#334

Больной К., 68 лет обратился с жалобами на полное отсутствие зубов в/ч и частичное на н/ч. Врач предложил полный съемный протез на в/ч и частичный съемный - на н/ч. Снял точные анатомические слепки. После припасовки и сдачи съемных протезов на в/ч протезы не фиксировались.

На каком этапе врачом были допущены ошибки?

- *+А) на клиническом – получение функционального оттиска
- *В) на клиническом- получение полного анатомического оттиска
- *С) на лабораторном – неправильно отлита модель
- *D) на лабораторном – нарушен режим полимеризации пластмассы
- *Е) на клиническом- неправильно определена центральная окклюзия

#335

При изготовлении какой несъёмной шины препарированием делают параллельные пазы на верхних зубах включенных в шину, почему:

- *+А) шины из полукоронки- обеспечивает надежную иммобилизацию
- *В) кольцевая шина- улучшает параллельность опорных зубов
- *С) колпачковая шина- обеспечивает хорошую фиксацию
- *D) экваторная шина- улучшает лечебные свойства
- *Е) коронковая шина- выгодна в эстетическом отношении

#336

Больной 30 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на боли в области 27 зуба. При проведении осмотра полости рта врач отметил положительную реакцию зуба на перкуссию. В области жевательной поверхности имеется вкладка из металла. Какие методы исследования понадобятся для постановки диагноза?

- *А) реография
- *+В) рентгенография
- *С) электроодонтометрия
- *D) томография
- *Е) гнатодинамометрия

#337

У больного в течение многих лет были сохранены только фронтальные зубы. Протезами он не пользовался. Какая ошибка наиболее вероятна при определении центрального соотношения у этого больного?

- *А) боковая правая окклюзия
- *В) боковая левая окклюзия
- *+С) передняя окклюзия
- *D) центральная окклюзия
- *Е) средняя окклюзия

#338

Больной С., 33 года, обратился с жалобой на металлический привкус во рту. Какова причина данного заболевания?

- *А) парниковый эффект
- *В) токсический стоматит
- *С) протезный стоматит

- *D) аллергический стоматит
- *+E) гальванизм

#339

Больной обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов.

Зубная формула: 00000300 / 00300000. Поставьте диагноз.

- *A) 1 класс, 2 подкласс по Кеннеди;
- *B) 2 класс, 3 подкласс по Кеннеди;
- *+C) 1 класс 4 подкласс по Кеннеди;
- *D) 3 класс, 1 подкласс по Кеннеди;
- *E) 4 класс, 1 подкласс по Кеннеди;

#340

Каким должно быть отношение тела промежуточной части мостовидного протеза из металлокерамики к слизистой оболочке альвеолярного отростка в области фронтальных зубов?

- *+A) касательная форма промежуточной части, с промывом 1-2 мм
- *B) седловидная форма
- *C) височная форма
- *D) седловидная и височная форма
- *E) плотно касаться к слизистой оболочке альвеолярного отростка.

#341

Если вкладка изготавливается прямым методом, можно ли ее смоделировать в полости рта?

- *+A) можно, вкладка моделируется непосредственно в полости рта
- *B) нельзя, слепок снимается кольцом заполненной термопластической массой
- *C) можно, но при этом перед моделировкой в канал вводится штифт
- *D) нельзя, снимается полный анатомический слепок с верхней и нижней челюсти
- *E) нельзя, слепок снимается непосредственно в полости рта из воска

#342

Больной, 48 лет. Обратился с жалобами на боли в области 11 зуба. При осмотре патологии твердых тканей не выявлено. В анамнезе отмечает механическую травму. Какие методы обследования следует провести?

- *A) мастикациография
- *B) одонтопародонтограмма
- *+C) рентгенография
- *D) реография
- *E) миография

#343

На металлическом колпачке видны пустоты, недоливы. В чем причина?

- *A) заполнение слепка очень жидким супергипсом
- *B) заполнение слепка очень густым супергипсом
- *C) деформация слепка
- *D) отслоение уточняющего слоя слепка
- *+E) недостаточно прогретый или успевший остыть муфель.

#344

При припасовке металлического колпачка на 11,24 зубы колпачок продвигается по культе очень туго и не садится до конца. Возможные причины этого:

- *A) очень тонкий слой формовочной массы.

- *В) недостаточное обезжиривание
- *+С) очень тонкий слой компенсационного лака
- *D) чрезмерный слой компенсационного лака
- *Е) нечеткие контуры отпрепарированного зуба в слепке.

#345

Почему пластмассовая коронка увеличивается в объеме в полости рта:

- *+А) из-за гигроскопичности материала"
- *В) наличие остаточного мономера"
- *С) не увеличиваться в объеме"
- *D) нарушен режим полимеризации"
- *Е) нарушен режим приготовления пластмассового теста

#346

При припасовке металлического колпачка на 11,24 зуб колпачок продвигается по культе очень туго и не садится до конца. Возможные причины?

- *А) очень тонкий слой формовочной массы
- * В) недостаточное обезжиривание
- *+ С) очень тонкий слой компенсационного лака
- * D) чрезмерный слой компенсационного лака
- * Е) заполнение слепка очень густым супергипсом

#347

Больному С., 56 лет, был изготовлен съемный пластиночный протез на н/ч в связи с отсутствием 181716151425262728 зубов. Какая лечебная и профилактическая помощь была осуществлена данным зубным протезом?

- *А) функционально перегрузить опорные зубы
- *+В) восстановление жевания и речи.
- *С) распределение жевательной нагрузки
- *D) шинирование оставшихся зубов.
- *Е) дальнейшее разрушение зубного ряда

#348

Применяют ли мостовидные протезы с опорой на один зуб в клинике ортопедической стоматологии?

- *А) да, все мостовидные протезы опираются на один зуб
- *В) нет, такие протезы не применяются
- *+С) применяют для протезирования фронтальной группы зубов и боковых зубов
- *D) применяют только для протезирования боковой группы зубов
- *Е) применяют только в тех случаях, когда другой вид протезирования невозможен

#349

Больному В., 37 лет, был изготовлен мостовидный протез с опорой на 24,27 зубы. Какие лечебные и профилактические задачи стояли перед врачом?

- *А) функционально перегрузить опорные зубы
- *+В) восстановление жевания, речи и шинирование.
- *С) распределение жевательной нагрузки
- *D) восстановление эстетики.
- *Е) дальнейшее разрушение зубного ряда

#350

При проверке конструкции протеза в полости рта обнаружено, что центральные резцы смещены в левую сторону. Причина ошибки, как ее исправить?

- *+А) не провели среднюю линию на модели, провести перестановку зубов.

- *В) средняя линия резцов не совпадает с уздечкой губ, провести перестановку зубов;
- *С) средняя линия верхних резцов не совпадает с линией нижних резцов, перестановка зубов;
- *Д) не правильно подготовлена прикусной валик верхней челюсти, переделать валик;
- *Е) не правильно определена центральная окклюзия, заново определить;

#351

В клинику ортопедической стоматологии обратился пациент с жалобой на перелом тела мостовидного протеза. На каком этапе была допущена ошибка?

- *А) на 1-клиническом этапе
- *В) на 1-лабораторном этапе
- *С) на 2-клиническом этапе
- *+Д) на 2-лабораторном этапе
- *Е) на 3-клиническом этапе

#352

При припасовке индивидуальной ложки на верхнюю челюсть с использованием функциональных проб по Гербсту у больного, при вытягивании губ слепочная ложка смещается с верхней челюсти, ваша тактика?

- *А) ложку необходимо укоротить на участке верхнечелюстного бугра;
- *В) ложку в таких случаях укорачивают по линии А;
- *С) ложку укорачивают по боковому краю;
- *+Д) ложку укорачивают вдоль переходной складки, в области фронтальных зубов
- *Е) ложку укорачивают в зоне между клыками;

#353

Можно ли снимать двухслойный слепок, если вкладка изготавливается прямым методом.

- *+А) нельзя т.к. вкладка моделируется непосредственно в полости рта
- *В) нельзя т.к. слепок снимается кольцом заполненной термопластической массой
- *С) можно, но при этом в полость вводится штифт
- *Д) нельзя, снимается полный анатомический слепок с верхней и нижней челюсти
- *Е) нельзя, слепок снимается непосредственно в полости рта из воска

#354

Во время примерки ЧСПП обнаружилось, что протез неплотно прилегает к протезному ложу. На каком этапе допущена ошибка и как ее устранить?

- *+А) неправильно снят слепок, нужно произвести перебазировку протеза
- *В) не был соблюден режим полимеризации, переделать протез
- *С) была неправильная постановка искусственных зубов, заново изготовить протез
- *Д) неправильно загипсовали в кювету, нужно произвести перебазировку протеза
- *Е) неправильно определена центральная окклюзия, переделать протез

#355

Пациенту 5 лет назад был изготовлен ЧСПП на нижнюю челюсть. 2 месяца назад опорный зуб на котором держался кламмер был удален. Пациент просит приварить искусственный зуб. Каким образом вы снимете оттиск?

- *А) нижней челюсти без протеза
- *+В) нижней челюсти с протезом
- *С) с обеих челюстей без протеза
- *Д) оттиски снимать не нужно
- *Е) индивидуальной ложкой

#356

У больного поломка частичного съемного пластиночного протеза верхней челюсти. Врач осмотрев протез, решил, что протез подлежит к починке. Что можно увидеть в подобных случаях?

- *А) множественные мелкооскольчатые переломы
- *В) пациент попытался самостоятельно склеить части протеза
- *С) линии перелома имеется сложный рельеф
- *D) протез сломан несколько раз
- *+Е) линия перелома находится в области сохранившиеся зубов

#356

При прямом методе восковая модель будущей вкладки изготавливается

- *+А) непосредственно в полости рта
- *В) на модели из супергипса
- *С) на модели из серебряной амальгамы
- *D) по гипсовому штампу в разборной модели
- *Е) по металлическому штампу в разборной модели

#357

При припасовке мостовидного протеза на 13 и 16 зубы у больного не удастся посадить протез на опорные зубы. Укажите причину. Ваши действия?

- *+А) параллельность опорных зубов нарушена, необходимо допрепарировать
- *В) деформирован мостовидный протез, необходимо переделать
- *С) при паянии разрушен форма опорных коронок, переделать коронки
- *D) параллельность опорных зубов нарушена, необходимо переделать
- *Е) неправильно восстановлен опорные коронки, переделать опорные коронки

#358

Эффективно ли применение металлических штампованных коронок при патологической стираемости II степени боковых зубов, почему?

- *А) эффективно, потому что восстанавливает прикус на толщину металлических штампованных коронок
- *+В) не эффективно, потому что возможны осложнения, связанные с травмой маргинального пародонта краем коронки
- *С) не эффективно, потому что не восстанавливает анатомическую форму стертых зубов в боковом отделе
- *D) эффективно, потому что толстый слой цемента между жевательной поверхностью стертых зубов и окклюзионной поверхностью коронок препятствует продвижению края коронки под десну
- *Е) не эффективно, потому что толщина металлических штампованных коронок не достаточна для восстановления прикуса

#359

Больному при припасовке индивидуальной ложки на верхнюю челюсть с использованием функциональных проб по Гербсту, в момент глотания слепочная ложка смещается с верхней челюсти, ваша тактика?

- *А) ложку необходимо укоротить на участке верхнечелюстного бугра;
- *+В) ложку в таких случаях укорачивают по линии А;
- *С) ложку укорачивают по боковому краю;
- *D) ложку укорачивают вдоль переходной складки;
- *Е) ложку укорачивают в зоне между клыками;

#360

Правильная схема заполнения истории болезни:

- *+А) жалобы, анамнез, объективные данные, диагноз, план лечения, дневник лечения

- *В) анамнез, жалобы, план лечения, объективные данные, диагноз, дневник лечения
- *С) объективные данные, жалобы, анамнез, диагноз, план лечения, дневник лечения
- *D) диагноз, жалобы, анамнез, объективные данные, план лечения, дневник лечения
- *Е) план лечения, дневник лечения, жалобы, анамнез, объективные данные, диагноз

#361

Метод определения консистенции, подвижности тканей и органов, болевой реакции, размеров и границ патологического очага

- *А) осмотр
- *+В) пальпация
- *С) опрос
- *D) рентгенологический
- *Е) лабораторный

#362

К клиническим методам обследования относится

- *+А) опрос, осмотр, пальпация, оценка состояния зубов, мягких тканей, тканей пародонта, прикуса
- *В) биохимические и клинические показатели крови, мочи и слюны
- *С) рентгенологический, реография, полярография
- *D) электроодонтометрия, цитологический, гистологический
- *Е) электромиография, транслюминисцентный, определение окислительно-восстановительного потенциала

#363

Мастикациография, электромиография, гальванометрия, капилляроскопия, реография, электроодонтометрия относятся к

- *А) клиническим методам исследования
- *+В) лабораторным методам исследования
- *С) рентгенологическим методам исследования
- *D) физическим методам исследования
- *Е) радиологическим методам исследования

#364

Наиболее эффективный рентгенологический метод исследования при артрозах ВНЧС

- *А) телерентгенография
- *В) пантомография
- *+С) томография
- *D) электрорентгенография
- *Е) ортопантомография

#168

Женщина 48 лет, на верхнюю челюсть изготавливается бюгельный протез. Во время определения центральной окклюзии произошел перелом воскового шаблона с прикусными валиками. Какая тактика врача-ортопеда на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *переснять оттиск;
- *изготовит восковый шаблон;
- *отдать в лабораторию для переделки модели;
- *+изготовить восковой шаблон с прикусными валиками;
- *определить центральную окклюзию;

#169

Мужчина 57 лет, запланировано изготовление бюгельного протеза нижней челюсти. Во время наложения воскового шаблона прикусные валики в центральной окклюзии не касаются окклюзионной поверхности зубов антогонистов. Какая тактика врача-ортопеда на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразно ?

- *отдать в лабораторию;
- *+добавить восковую пластинку на прикусной валик;
- *определить центральную окклюзию;
- *снять оттиск;
- *изготовить восковой шаблон;

#170

Женщина 56 лет, запланировано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть. Во время разогревания воскового прикусного валика была повреждена гипсовая модель в месте протезного ложа. Какая тактика врача-ортопеда на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *отдать в лабораторию;
- *+снять оттиск;
- *определить центральную окклюзию;
- *изготовить восковой шаблон;
- *добавить восковую пластинку на прикусной валик;

#171

Мужчина 38 лет, запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. Во время снятия воскового шаблона с прикусными валиками с гипсовой модели обнаружены поры на модели в области протезного ложа. Какая тактика врача-ортопеда на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *определить центральную окклюзию;
- *+снять оттиск;
- *разогреть прикусной валик;
- *отдать в лабораторию;
- *изготовить восковой шаблон;

#172

Женщина 42 года. Находится на этапе ортопедического лечения. Во время снятия с моделей восковых шаблонов с прикусными валиками обнаружены сколы и места склеивания гипсовой модели. Какая тактика врача-ортопеда на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *отдать в лабораторию;
- *разогреть прикусной валик;
- *+снять оттиск;
- *дезинфекция восковых шаблонов;
- *нанести ориентировочные линии на прикусной валик;

#173

Мужчина 45 лет. Запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. Во время оценки качества изготовленные восковых шаблонов с прикусными валиками на гипсовой модели имеются сколы и отсутствие гипсовых зубов. Какая тактика врача-ортопеда на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *+снять оттиск и определить центральную окклюзию;
- *разогреть прикусной валик и отдать в лабораторию;
- *нанести ориентировочные линии на прикусной валик и отдать в лабораторию;
- *разогреть прикусной валик и скрепить модели в центральном соотношении при помощи прикусных валиков;

*определить центральную окклюзию;

#174

Женщина 48 лет.запланировано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть. При осмотре: на верхней челюсти имеется включенный дефект во фронтальном отделе и односторонний в боковом отделе слева. Сохранившиеся зубы интактны, устойчивы. Применение каких вспомогательных материалов при определении центральной окклюзии НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *спиртовки;
- *зуботехнический шпатель;
- *+базисный воск;
- *расцветка;
- *химический карандаш;

#175

В каком случае при изготовлении бюгельного протеза НАИБОЛЕЕ целесообразно применение воскового шаблона с прикусными валиками?

- *параллелометрии;
- *дублирования моделей;
- *гнатодинамометрии;
- *+определения центральной окклюзии;
- *наложение каркаса;

#177

Мужчине 66 лет предъявляет жалобы на отсутствие зубов на верхней челюсти, нарушение жевания. При осмотре: имеется односторонний концевой дефект зубного ряда верхней челюсти слева. Какие функционально ориентированные группы зубов будут участвовать в проведении фиксации центральной окклюзии?

- *+фронтальная и правая боковая группа зубов, антогонистов;
- *фронтальная и левая боковая группа зубов, антогонистов;
- *левая и правая боковая группа зубов, антогонистов;
- *фронтальная группа зубов, антогонистов;
- *правая группа зубов, антогонистов;

#178

Женщина 56 лет предъявляет жалобы на эстетический дефект, затруднения откусывания пищи. При осмотре: имеется включенный дефект зубного ряда верхней челюсти. Какая функционально-ориентированная группа зубов будет участвовать в проведении фиксации центральной окклюзии.

- *фронтальная группа зубов, антогонистов;
- *+правая и левая группа зубов антогонистов;
- *фронтальная и право-боковая группа зубов антогонистов;
- *фронтальная и лево-боковая группа зубов антогонистов;
- *левосторонняя группа зубов антогонистов;

#179

Мужчина 48 лет предъявляет жалобы на отсутствие зубов верхней и нижней челюсти, нарушение жевания. При осмотре: имеется односторонний концевой дефект зубного ряда верхней челюсти справа и нижней челюсти слева. Какие функционально-ориентированные группы зубов будут участвовать в проведении фиксации центральной окклюзии?

- *фронтальная и правая группа зубов, антогонистов;
- *правая и левая группа зубов антогонистов;
- *+фронтальная группа зубов, антогонистов;

- *лево-боковая группа зубов антогонистов;
- *право-боковая группа зубов антогонистов;

#180

Женщина 45 лет предъявляет жалобы на эстетический дефект, затруднения пережевывания пищи. При осмотре: отсутствует 11; 12; 13; 22; 25; 26; 27. Какие функционально-ориентированные группы зубов будут участвовать в проведении фиксации центральной окклюзии?

- *фронтальная и правая группа зубов, антогонистов;
- *правая и левая группа зубов антогонистов;
- *фронтальная группа зубов, антогонистов;
- *+право-боковая группа зубов антогонистов;
- *лево-боковая группа зубов антогонистов;

#181

Женщине 60 лет находится на этапе ортопедического лечения. При осмотре имеется включенный дефект зубного ряда нижней челюсти слева. После определения центральной окклюзии средняя линия лица не совпадает с линией проходящей между центральными резцами. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *определение межальвеолярного расстояния;
- *на окклюзионный валик добавить базисный воск;
- *+повторно определить окклюзию;
- *снять оттиск;
- *подготовка прикусных валиков;

#182

Женщине 57 лет на этапе ортопедического лечения изготовлены прикусные валики. Во время наложения прикусных валиков отсутствует контакт зубов антогонистов, увеличение нижней трети лица. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *скрепление моделей при помощи прикусных валиков;
- *+уменьшить прикусные валики;
- *снять оттиск;
- *добавить базисный воск на окклюзионный валик;
- *нанести ориентировочные линии на прикусной валик;

#183

Мужчина 48 лет на этапе ортопедического лечения определения центральной окклюзии. При осмотре: средняя линия лица смещена вправо от центральной резцовой линии. Какая из перечисленных ниже окклюзий НАИБОЛЕЕ вероятна?

- *фронтальная окклюзия;
- *левая боковая окклюзия;
- *передняя окклюзия;
- *+правая боковая окклюзия;
- *центральная окклюзия;

#184

Женщина 50 лет на этапе ортопедического лечения определения центральной окклюзии. При осмотре: средняя линия лица смещена влево от центральной резцовой линии. Какая из перечисленных ниже окклюзий НАИБОЛЕЕ вероятна?

- *центральная окклюзия;
- *передняя окклюзия;
- *+левая боковая окклюзия;
- *фронтальная окклюзия;
- *правая боковая окклюзия;

#185

Женщине 60 лет запланировано изготовление бюгельного протеза. На четвертом клиническом этапе. При осмотре: видно смыкание друг с другом фронтальных зубов, между окклюзионными поверхностями боковых зубов имеется зазор. Какая из перечисленных ниже окклюзий НАИБОЛЕЕ вероятна?

- *+передняя окклюзия;
- *центральная окклюзия;
- *правая боковая окклюзия;
- *фронтальная окклюзия;
- *левая боковая окклюзия;

#186

Мужчина 66 лет запланировано изготовление бюгельного протеза. На втором клиническом этапе. При осмотре: виден сдвиг нижней челюсти влево, контакт одноименных бугров зубных рядов. Какая из перечисленных ниже групп зубного ряда НАИБОЛЕЕ вероятно называется рабочей?

- *правая боковая группа зубов;
- *+левая боковая группа зубов;
- *фронтальная группа зубов;
- *передняя группа зубов;
- *центральная группа зубов;

#187

Мужчине 60 лет запланировано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть. При осмотре: на верхней челюсти имеется включенный дефект во фронтальном отделе. Сохранившиеся зубы интактно устойчивы.

Применение каких функционально-ориентированных групп зубов НАИБОЛЕЕ показано на втором клиническом этапе?

- *+боковая группа зубов;
- *фронтальная группа зубов;
- *правая боковая группа зубов;
- *левая боковая группа зубов;
- *центральная группа зубов;

#188

Женщине 58 лет запланировано изготовление бюгельного протеза на нижнюю челюсть. При осмотре: на нижней челюсти имеется односторонний концевой дефект слева. Сохранившиеся зубы интактно устойчивы.

Применение каких функционально-ориентированных групп зубов НАИБОЛЕЕ показано на втором клиническом этапе?

- *+боковая группа зубов;
- *центральная группа зубов;
- *фронтальная и правая боковая группа зубов; +
- *фронтальная и левая боковая группа зубов;
- *центральная и боковая группа зубов;

#189

Мужчине 48 лет запланировано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть. При осмотре: на верхней челюсти имеется включенный дефект во фронтальном отделе и односторонний включенный концевой дефект слева. Сохранившиеся 17, 16, 15 и 23, 24, 27 интактно устойчивы.

Применение каких функционально-ориентированных групп зубов НАИБОЛЕЕ показано на втором клиническом этапе?

- *+боковая группа зубов;
- *фронтальная группа зубов;
- *центральная группа зубов;
- *центральная и боковая группа зубов;
- *фронтальная и левая боковая группа зубов;

#190

Женщине 49 лет запланировано изготовление бюгельного протеза на нижнюю челюсть. При осмотре: имеется двусторонний концевой дефект зубного ряда нижней челюсти. Сохранившиеся зубы интактны, устойчивы.

Применение каких функционально-ориентированных групп зубов НАИБОЛЕЕ показано на втором клиническом этапе?

- *боковая группа зубов;
- *+фронтальная группа зубов;
- *центральная и боковая группа зубов;
- *фронтальная и Левая боковая группа зубов;
- *фронтальная и Правая боковая группа зубов;

#191

Мужчине 67 лет запланировано изготовление бюгельного протеза на верхнюю и нижнюю челюсть. При осмотре: на верхней челюсти имеется односторонний концевой дефект слева, а на нижней челюсти односторонний концевой дефект справа. Сохранившиеся зубы интактны, устойчивы.

Применение каких функционально-ориентированных групп зубов НАИБОЛЕЕ показано на втором клиническом этапе?

- *центральная и боковая группа зубов;
- *боковая группа зубов;
- *+фронтальная группа зубов;
- *фронтальная и левая боковая группа зубов;
- *фронтальная и правая боковая группа зубов.

#192

Какой съемный протез с точки зрения биомеханики и профилактики более надежный?

- *частичный съемный;
- *+бюгельный;
- *каппа;
- *мостовидный;
- *брекет;

#198

Женщина 58 лет обратилась в клинику с жалобами на кровоточивость десен затрудненное пережевывание пищи. При осмотре имеется включенный двусторонний боковой дефект зубного ряда верхней челюсти, подвижность имеющихся зубов второй степени, явление гингивита. Какое ортопедическое лечение НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *ортодонтическое и хирургическое;
- *хирургическое, терапевтическое;
- *+ортопедическое, терапевтическое;
- *ортодонтическое, терапевтическое;
- *терапевтическое, ортодонтическое;

#199

Женщина 50 лет запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. При осмотре имеется дефект зубного ряда верхней челюсти 3 группа Гаврилова, подвижность 1-2 степени, гингивит. В целях профилактики и благоприятного прогноза лечения добавление какого элемента в каркас НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *отростки базиса протеза;

- *+многозвеньевой кламмер;
- *передние небные дуги;
- *кольцевидные отростки;
- *вестибулярную дугу;

#200

Женщине 48 лет изготовлен бюгельный протез верхней челюсти. Во время проверки имеются поры в базисной пластмассе. Какая тактика врача на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *провести коррекцию;
- *консультация;
- *сдача протеза;
- *починка протеза;
- *+снятие оттиска;

#201

Мужчина 60 лет изготовлен бюгельный протез нижней челюсти. Во время проверки базисная пластмасса не прозрачна, имеет мраморную поверхность. Какой из перечисленных ниже этапов НАИБОЛЕЕ вероятно был нарушен?

- *подбор искусственных зубов;
- *клинические этап;
- *+лабораторный этап;
- *определение окклюзии;
- *снятие оттиска;

#202

Женщина 57 лет предъявляет жалобы на отсутствие зубов на верхней челюсти, нарушения жевания. При осмотре имеется дефект зубного ряда верхней челюсти 1 класс Кеннеди, обильные зубные отложения, гингивит, подвижность оставшихся зубов 2 степени. Какая из перечисленных ниже конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+бюгельный протез;
- *частично-съёмный протез;
- *шина Эльбрехта;
- *шина Шпренгера;
- *шина Ван-тиля;

#203

Мужчине 48 лет запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. При обследовании полости рта имеется двусторонний включенный дефект зубного ряда верхней челюсти. Какой из перечисленных ниже конструкционных материалов отвечает современным физико-механическим свойствам НАИБОЛЕЕ вероятен в данном клиническом случае?

- *золото;
- *пластмасса;
- *титан;
- *+КХС;
- *НХС;

#204

Женщине 58 лет запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. При осмотре имеется двусторонний включенный дефект зубного ряда верхней челюсти. Для облегчения удельного веса каркаса какой конструкционный материал НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *КХС;
- *+титан;
- *НХС;
- *пластмасса;

*золото;

#205

Мужчина 57 лет обратился в клинику с жалобами на опрокидывание протеза нижней челюсти. При осмотре: имеется двусторонний дефект зубного ряда нижней челюсти 1 класс Кеннеди, низкое расположение дуги. Применение какого элемента НАИБОЛЕЕ целесообразно было включить в конструкцию протеза?

*аттачмен;

*седло;

*искусственные зубы;

*+кипмайдер;

*кламмер;

#212

Женщине 57 лет на верхнюю челюсть изготовлен каркас бюгельного протеза. При припасовке каркаса кламмера плотно не охватывают опорные зубы идет сброс конструкции. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*согнуть кламмер;

*отдать в лабораторию;

*разогнуть кламмер;

*подточить каркас;

*+снять оттиск;

#213

Мужчина 60 лет на 3 клиническом этапе окклюзионная накладка опорно-удерживающего кламмера по отношению к окклюзионной поверхности опорных зубов должна находиться под углом?

*+5-10 градусов;

*15-20 градусов;

*10-15 градусов;

*18-25 градусов;

*20-25 градусов;

#214

Мужчина 47 лет изготовлен каркас бюгельного протеза нижней челюсти. При припасовке на опорные зубы было замечено отсутствие окклюзионных накладок кламмеров. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*определить цвет искусственных зубов;

*+перелить каркас;

*отдать в лабораторию;

*снять оттиск;

*определить центральную окклюзию;

#215

Женщина 57 лет изготовлен каркас бюгельного протеза верхней челюсти. При припасовке опорно-удерживающая часть кламмера IV-типа система Нея находится в окклюзионной зоне. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*снятие оттиска;

*определить центральную окклюзию;

*отдать в лабораторию;

*+перемоделировать;

*изогнуть кламер;

#216

Мужчина 48 лет изготовлен каркас бюгельного протеза нижней челюсти. При припасовке каркаса дуга располагается ниже экватора альвеолярной части и давит на уздечку языка. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *отдать в лабораторию;
- *+перемоделировать дугу;
- *подточить дугу;
- *изогнуть дугу;
- *снять оттиск;

#217

Женщине 57 лет изготовлен каркас бюгельного протеза нижней челюсти. При припасовке каркаса дуга располагается выше экватора альвеолярной части и имеет зазор 3мм. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *подточить дугу;
- *отдать в лабораторию;
- *изогнуть дугу;
- *снять оттиск;
- *+перемоделировать дугу;

#218

Женщина 57 лет запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. При осмотре на верхней челюсти имеется включенный дефект фронтальной части и левой боковой части зубного ряда. Применение какой фиксации НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *точечная фиксация;
- *трансверзальная фиксация;
- *центральная фиксация;
- *+плоскостная фиксация;
- *линейная фиксация;

#219

Мужчина 58 лет запланировано изготовление бюгельного протеза на нижней челюсти. При осмотре имеется двусторонний концевой дефект зубного ряда нижней челюсти. Сохранившиеся зубы интактны, устойчивы. Применение какой кламмерной линии НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *плоскостная фиксация;
- *боковая фиксация;
- *сагиттальная фиксация;
- *точечная фиксация;
- *+ трансверзальная фиксация;

#225

Мужчина 45 лет запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. При осмотре: у каркаса бюгельного протеза отсутствует вестибулярная удерживающая часть кламмера I типа Нея. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *поставить гнутый кламмер;
- *отдать в лабораторию;
- *снять оттиск;
- *+заново отлить каркас;
- *удалить весь кламмер;

#226

Женщина 48 лет запланировано изготовление бюгельного протеза нижней челюсти. При осмотре каркаса бюгельного протеза имеются поры в области соединения дуги и седла. Какая тактика врача НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *отдать в лабораторию;

- *снять оттиск;
- *+заново отлить каркас;
- *запаять пору;
- *закрыть базисной пластмассой;

#227

Женщина 58 лет запланировано изготовление бюгельного протеза верхней челюсти. Во время проверки: каркас хорошо лежит на модели, в полости рта кламеры плотно не прилегают к опорным зубам, наблюдается деформация дуги. Какие из нижеперечисленных ошибок НАИБОЛЕЕ вероятны?

- *+ снятие оттиска;
- *отливка рабочей модели;
- *отливка огнеупорной модели;
- *отливка каркаса;
- *параллелометрия;

#228

Женщина 58 лет на верхней челюсти изготовлен каркас бюгельного протеза. после наложения наблюдается деформация дуги. Какая тактика врача ортопеда на этапе ортопедического лечения НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *отдать в лабораторию;
- *+снять оттиск;
- *подогнуть кламмера;
- *отливка каркаса;
- *подогнуть дуги;

#229

Мужчина 60 лет запланирована изготовление бюгельного протеза нижней челюсти. Во время проверки каркас не ложится на модель и не фиксируется в полости рта. Какая из перечисленных ниже ошибок НАИБОЛЕЕ вероятна?

- *клиническая;
- *+литье по выплавляемым формам;
- *литье по дублированной модели;
- *литье по огнеупорной модели;
- *литье на рабочей модели;

#230

Мужчина 58 лет изготовлен каркас бюгельного протеза верхней челюсти. Во время проверки: каркаса наблюдается неравномерная толщина всех элементов, грубая форма кламеров. На каком этапе была допущена ошибка?

- *+технологическом;
- *клиническом;
- *снятие оттиска;
- *отливка модели;
- *литье;

#231

В каком случае при изготовлении бюгельных протезов НАИБОЛЕЕ целесообразно применение кламмеров Роуча?

- *опорный зуб с резко выраженным экватором;
- *опорный зуб с слабо выраженным экватором;
- *опорный зуб наклонен орально;
- *+опорный зуб наклонен вестибулярно;
- *одиночно стоящий моляр;

#232

Мужчина 49 лет запланировано изготовление бюгельного протеза на нижней челюсти. При осмотре имеется дефект зубного ряда нижней челюсти 1 класса по Кеннеди, сохранившиеся зубы интактны, устойчивы 44,43,42,41,31,32,33,34. Какое расположение окклюзионной накладки НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *+медиальной межбугорковой ямки;
- *дистальной межбугорковой ямки;
- *латеральной межбугорковой ямки;
- *сагиттальной межбугорковой ямки;
- *дистальном бугре;

#233

В каком случае при изготовлении бюгельного протеза окклюзионную накладку НАИБОЛЕЕ целесообразно расположить в медиальной межбугорковой ямке?

- *4-3 класс Кеннеди;
- *+ 1-2 класс Кеннеди;
- *3-5 класс Кеннеди;
- *4-5 класс Кеннеди;
- *3 класс Кеннеди;

#234

Неприятные ощущения в полости рта- чувство жжения, металлический привкус, изменение вкусовых ощущений, изменение цвета металлического протеза, а также гингивиты и стоматиты являются наиболее вероятными признаками:

- *Аллергии
- *Красного плоского лишая
- *+Гальванизма
- *Токсических стоматитов
- *Механических повреждений, вызванные зубным протезом

#346

Мужчина 49 лет обратился с целью протезирования после полной резекции верхней челюсти. Применение какого из перечисленных ниже obturators НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *пустотелого
- *формирующего
- *+воздухоносного
- *плавающего
- *массивного

#347

*!У мужчины 56 лет имеется частичная вторичная адентия верхней челюсти с отсутствием 18, 17, 16, 15, 24, 25, 26, 28 зубов, 27 зуб наклонён незначительно в мезиальную сторону. Торус резко выражен. Нижний зубной ряд интактен.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+бюгельный протез
- *составные мостовидные протезы
- *адгезивные мостовидные протезы
- *консольные мостовидные протезы
- *частичные съёмные протезы

#348

*!У мужчины 52 лет, отсутствует 35 зуб, на 36 зубе имеется пломба (2 класс по Блеку) с медиальной стороны, 34 зуб интактный.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*+мостовидный протез с опорой на коронку на 34 зуб и вкладку на 36 зуб

*состовной мостовидный протез с опорой на 34 , 36 и 37 зубы

*мостовидный протез из пластмассы с опорой на 34 и 36 ,37 зубы

*мостовидный протез с опорой на 33,34 и на 36 зуб и на 37 зуб

*консольный протез с опорой на 34 зуб или с опорой на 37 зуб

#349

*!Мужчина 75 лет. Съёмные пластиночные протезы при полной адентии верхней и нижней челюстей изготовлены в третий раз. Жалобы: «привык к протезам сразу, но через полтора месяца появился шум в ушах». Объективно: старческое выражение лица.

Какая из перечисленных ниже ошибок, НАИБОЛЕЕ вероятно, была допущена?

*завышена высота нижнего отдела лица

*нарушен процесс полимизации

*недопаковка пластмассы

*+высота нижнего отдела лица занижена

*поставлены длинные зубы

#350

*!Мужчина 34 лет ,12,11,21,22,32,31,41,42 зубы поражены кариозным процессом. Наличие полостей 4 класса по Блеку. Сопутствующее заболевание – флюороз. При осмотре и зондировании зубы изменены в цвете, эмаль неплотная.

Какая из перечисленных ортопедических конструкции целесообразна?

*+коронки

*полукоронки

*люминиры

*вкладки

*штифты

#351

*!НАИБОЛЕЕ информативный метод определения взаимного расположения головки, диска и заднего ската бугорка ВНЧС это

*миография

*+томография

*реография

*аксиография

*мастикациография

#352

*!НАИБОЛЕЕ информативный метод определения состояние мягких тканей ВНЧС?

*томография

*компьютерная томография

*+магнитно-резонансная томография

*рентгенография в 3 проекциях

*прицельная рентгенография

#353

*!У Мужчины 72 лет, беззубая верхняя челюсть. Атрофия альвеолярного отростка средней степени, маловыраженные бугры, средняя глубина неба, выраженный торус. Какой из перечисленных типов полной вторичной адентии НАИБОЛЕЕ вероятен?

*I – тип по Оксману

*+II- тип по Оксману

- *II- тип по Суппле
- *III- тип по Оксману
- *III- тип по Суппле

#354

*!У Мужчины 65 лет, на нижней челюсти двухсторонний концевой дефект зубного ряда.

Зубная формула : 00004321 / 12340000

Прикус ортогнатический Атрофия альвеолярных отростков умеренная.Слизистая полости рта без особенностей

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+бюгельный протез
- *мостовидный протез
- *консольные протезы
- *адгезивный протез
- *составной протез

#355

*!Мужчина 74 лет. На этапе ортопедического лечения, при введении в полость рта восковой композиции частичных съемных пластиночных протезов в/ч и н\ч нижняя треть лица удлинена, губы смыкаются с трудом, складки лица сглажены, при разговоре имеется еле заметная щель между фронтальными зубами, слышен стук зубов. Все антагонизирующие зубы смыкаются равномерно и плотно

Какая из перечисленных ошибок была НАИБОЛЕЕ вероятно допущена врачом на этапе определения центральной окклюзии?

- *высота прикуса снижена
- *+высота прикуса завышена
- *зафиксирована передняя окклюзия
- *зафиксирована боковая окклюзия
- *зафиксирована задняя окклюзия

#356

*!При каких из перечисленных клинических ситуаций НАИБОЛЕЕ целесообразно изготовить бюгельный протез с использованием 5-типа опорно-удерживающего кламмера системы Нея?

- *двухсторонний концевой дефект-ограничен премолярами
- *односторонний концевой дефект-ограничен премолярами
- *включенные дефекты в переднем отделе с одиночно стоящими премолярами
- *+включенные дефекты в боковом отделе с одиночно стоящими молярами
- *одиночно стоящие премоляры на верхней и нижней челюсти

#357

*!Мужчина 38 лет. Обратился с жалобами на боли в области 11 зуба. При осмотре патологии твердых тканей не выявлено. В анамнезе отмечает механическую травму.

Какой из перечисленных дополнительных методов обследования НАИБОЛЕЕ рационально провести?

- *мастикациографию
- *одонтопародонтограмму
- *+рентгенографию
- *реографию
- *миографию

#358

*!Мужчина 25 лет, жалуется на повышенную чувствительность зубов к внешним раздражителям. При осмотре Полости рта: 22,21/11,12 зубах по режущему краю имеется полулунная вырезка. Стенки, края и дно углублений гладкие.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+гипоплазия эмали
- *гиперплазия эмали
- *эрозия
- *клиновидный дефект
- *эрозивная форма флюороза

#359

*!При изготовлении какой несъёмной шины НАИБОЛЕЕ целесообразно препарированием сделать параллельные пазы на верхних зубах включенных в шину?

- *+ полукоронки
- *кольцевой
- *колпачковой
- *экваторной
- *коронковой

#360

*!Мужчина 25, лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие правого центрального резца верхней челюсти. Прикус ортогнатический, слизистая полости рта без видимой патологии

Какой из перечисленных диагнозов по классификации Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *1 класс
- *2 класс
- *3 класс
- *+4 класс
- *5 класс

#361

*!Мужчина 70 лет, объективно: альвеолярные отростки и бугры на верхней челюсти отсутствуют, нёбо плоское. Переходная складка расположена в одной горизонтальной плоскости с твёрдым нёбом.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+беззубая верхняя челюсть III тип по Шредеру
- *беззубая верхняя челюсть II тип по Шредеру
- *беззубая верхняя челюсть, III класс по Суппле
- *беззубая верхняя челюсть, III тип по Келлеру
- *по Оксману 2 тип беззубой верхней челюсти

#362

*!Мужчина 49 лет, обратился с целью протезирования. При осмотре отсутствуют зубы 36, 37 38 46 47 48.

Какой протез из ниже перечисленного является НАИБОЛЕЕ рациональным для замещения дефекта зубного ряда?

- *мостовидный
- *+бюгельный
- *консольный
- *полный съёмный
- *адгезивный

#363

*!При проверке конструкции частичного съемного протеза на верхней и нижней челюстях определяется неплотное прилегание восковых базисов к модели.

Какая тактика врача стоматолога НАИБОЛЕЕ целесообразная?

- *исправить восковые базисы в полости рта пациента
- *дополнительно положить воск к восковым базисам
- *+необходимо вновь определить центральную окклюзию
- *снять корригирующим материалом оттиск с восковыми базисами
- *снять функциональный оттиск индивидуальной ложкой

#364

*!Мужчина 30 лет, обратился в ортопедический кабинет с жалобами на разрушение коронки и изменении цвета 12 зуба, ранее проведено эндодонтическое лечение

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+восстановление стекловолоконным штифтом
- *штифтование анкерным штифтом
- *восстановление культевой металлической вкладкой
- *штифтовый зуб по Ричмонду
- *штифтовый зуб по Ахметову

#365

*!У Мужчины 56 лет, при объективном осмотре обнаружена повышенная стираемость твердых тканей зуба, уменьшение вертикальных размеров коронок всех зубов, снижение межальвеолярной высоты, высота нижней трети лица не изменена.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- * генерализованная суб компенсированная повышенная стираемость
- * локализованная компенсированная стираемость
- * локализованная некомпенсированная повышенная стираемость зубов
- *+ генерализованная компенсированная форма повышенной стираемости
- * генерализованная некомпенсированная форма повышенной стираемости

#366

*!Мужчина 62 года. Объективно: на верхней и нижней челюсти имеются хорошо выраженные альвеолярные отростки, покрытые слегка податливой слизистой оболочкой. Небо также покрыто равномерным слоем слизистой оболочки, умеренно податливой в задней его трети. Естественные складки слизистой оболочки (уздечка губ, щёк и языка как на верхней, так и на нижней челюсти достаточно удалены от вершины альвеолярной части.

Какой из перечисленных классов по классификации Супле НАИБОЛЕЕ соответствует приведенное описание?

- *+ I класс
- * II класс
- * III класс
- * IV класс
- * V класс

#367

*!Женщина 40 лет, обратилась с жалобами на изменение цвета передних зубов на верхней челюсти после эндодонтического лечения. По результатам обследования рекомендовано изготовление металлокерамических коронок на 11,21 зубы.

Какую из перечисленных форм НАИБОЛЕЕ целесообразно придать зубам после препарирования?

- * квадратную
- * призматическую

- * +конусовидную
- * эллипсовидную
- * цилиндрическую

#368

*!Мужчина 45 лет, обратился в клинику с жалобами на отсутствие зубов, затрудненное пережевывание пищи. Из анамнеза: ранее ортопедическое лечение не проводилось. При осмотре полости рта: имеется двухсторонний включенный дефекты зубного ряда на нижней челюсти.

Какой из перечисленных ниже зубных рядов по классификации Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+1 класс по Кеннеди
- *2 класс по Кеннеди
- *4 класс по Кеннеди
- *2,4класс по Кеннеди
- *3 класс по Кеннеди

#369

*!Мужчина 57 лет, находится на этапе ортопедического лечения. При проверке восковой конструкции частичного съемного протеза на верхней челюсти ортопедом выявлено, что боковые зубы смыкаются плотно, а в переднем отделе имеется разобщение.

Какая из перечисленных ниже окклюзий, НАИБОЛЕЕ вероятно, была зафиксирована на предыдущем этапе ортопедического лечения?

- *боковая
- *+передняя
- *центральная
- *боковая левая
- *боковая правая

#370

*!Мужчине 68 лет, запланировано изготовление полного съемного пластиночного протеза на верхнюю челюсть. При осмотре: резкая атрофия альвеолярного отростка, верхнечелюстных бугров, плоское небо.

Какой из перечисленных ниже типов атрофии альвеолярного отростка НАИБОЛЕЕ соответствует классификации по Оксману

- *1 тип
- *2 тип
- *+3 тип
- *4 тип
- *5 тип

#371

*!Мужчине 52 лет, запланирован частичный съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть. При осмотре: имеется дефект зубного ряда в переднем отделе, с выраженной атрофией альвеолярного гребня и податливой слизистой оболочкой.

Какая из перечисленных ниже постановок зубов НАИБОЛЕЕ целесообразна в данной ситуации?

- *на металлическом базисе
- *+на искусственной десне
- *на двухслойном базисе
- *на мягкой подкладке
- *на приточке

#372

*!Мужчина 54 лет, предъявляет жалобы на стираемость зубов. При осмотре: коронковая часть всех зубов стерта до контактных площадок. Высота нижнего отдела лица челюсти без изменений.

Какая из перечисленных ниже форм повышенной стираемости НАИБОЛЕЕ вероятна?

- *компенсированная, 1 степень тяжести
- *декомпенсированная, 1 степень тяжести
- *+компенсированная, 2 степень тяжести
- *декомпенсированная, 2 степень тяжести
- *смешанная,компенсированная

#373

*!Женщина 48 лет, предъявляет жалобы на выдвижение зубов верхней челюсти. При осмотре выявлено перемещение 15, 16, 17 зубов верхней челюсти с увеличением костной ткани, окружающей зуб. Соотношение вне- и внутриальвеолярной части зуба при этом не изменилось.

Какая из перечисленных ниже форм зубоальвеолярного удлинения по Пономареву В.А. НАИБОЛЕЕ вероятна?

- *+первая форма
- *вторая форма
- *третья форма
- *вторая форма, 1 подгруппа
- *вторая форма, 2 подгруппа

#374

*!Мужчина 53 лет, обратился с жалобами на жжение, металлический привкус во рту. При осмотре: имеются металлический мостовидный протез на верхней челюсти и золотые коронки на зубах нижней челюсти с правой стороны.

Какой из перечисленных ниже предварительных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *аллергический стоматит
- *токсический стоматит
- *протезный стоматит
- *+явления непереносимости
- *парниковый эффект

#375

*!Женщина 27 лет, обратилась в клинику с жалобами на эстетический дефект. Из анамнеза: неоднократно лечила 17 зуб по поводу кариеса, пломба часто выпадала. Объективно: на жевательной поверхности 17 зуба имеется скол пломбы, зуб в цвете не изменен.

Какой вид вкладки НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *инлей
- *+онлей
- *пинлей
- *оверлей
- *культю

#376

*!Женщине 56 лет на верхнюю челюсть изготавливают частичный съемный пластиночный с фиксацией телескопической системой на 15 и 25 зубы

Чем из перечисленных НАИБОЛЕЕ вероятно представлена телескопическая система?

- *зуб-кламмер
- *коронка-вкладка
- *коронка-кламмер
- *+колпачок-коронка

*имплантат-кламмер

#377

*!Женщина 37 лет обратилась с целью протезирования. При осмотре: на верхней челюсти выявлены дефекты зубного ряда, включенный во фронтальном отделе и концевой в боковом отделе. Рекомендовано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть. Какая из перечисленных ниже систем фиксации бюгельного протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*система Нея

*+замковые крепления

*телескопическая система

*удерживающие кламмера

*система Румпеля-Дольдера

#378

*!Мужчина 67 лет предъявляет жалобы на полное отсутствие зубов верхней и нижней челюстей. При осмотре выявлены экзостозы на верхней челюсти и резкая атрофия альвеолярного гребня на нижней челюсти.

Какой базис из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразен?

*металлический

*пластмассовый

*силиконовый

*нейлоновый

*+двухслойный

#379

*!Мужчина 60 лет, обратился с целью протезирования. При осмотре коронковая часть передних зубов на верхней и нижней челюсти стерты, $\frac{1}{2}$ высоту коронок, корни устойчивы. На панорамной рентгенограмме корневые каналы 131211212223 и 4342413132333 запломбированы. Имеется концевой дефект на верхней челюсти слева, двухсторонний концевой дефекты на нижней челюсти.

Какой вид ортопедического лечения из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразно провести в первую очередь?

*бюгельные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти

*частичные съемные пластиночные протезы на обе челюсти

*комбинированные коронки на передние зубы обеих челюстей

*культевые штифтовые вкладки на передние зубы обеих челюстей

*+восстановление высоты нижнего отдела лица пластмассовой каппой

#380

*!Женщина 57 лет, предъявляет жалобы на подвижность зубов верхней челюсти. При обследовании выявлена подвижность зубов в боковых отделах челюсти с поражением пародонта.

Какая стабилизация шинирующих конструкций из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*передняя

*сагитальная

*трансверзальная

*+парасагитальная

*передне – боковая

#381

*!Женщина 54, лет предъявляет жалобы на жжение в полости рта после протезирования. При осмотре: на верхней челюсти имеются старые металлические мостовидные протезы и новый частичный съемный платиночный протез на нижней челюсти.

Какую из перечисленных ниже диагностических методов обследования НАИБОЛЕЕ целесообразно провести?

- *электроодонтодиагностику
- *одонтопародонтограмму
- *гнатодинамометрию
- *окклюзиограмму
- *+кожные пробы

#382

*!Мужчины 56 лет, предъявляет жалобы на стираемость зубов. При осмотре: коронковая часть всех зубов стерты до контактных площадок. Высота нижнего отдела лица челюсти не изменена.

Какой из перечисленных ниже методов лечения повышенной стираемости НАИБОЛЕЕ целесообразен после восстановления высоты нижнего отдела лица?

- *культевые штифтовые вкладки
- *комбинированные коронки
- *металлические коронки
- *+металлокерамические коронки
- *пластмассовая каппа

#383

*!Мужчина 49 лет, обратился с целью протезирования после полной резекции верхней челюсти.

Применение какого из перечисленных ниже obturators НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *пустотелого
- *формирующего
- *+воздухоносного
- *плавающего
- *массивного

#384

*!Мужчина 54 лет, обратился в клинику с жалобами на отсутствие зубов, затрудненное пережевывание пищи. Из анамнеза: ранее ортопедическое лечение не проводилось. При осмотре полости рта: имеется двухсторонний концевой дефекты зубного ряда на нижней челюсти.

Какой из перечисленных ниже предварительных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+дефект зубного ряда 1 класс по Кеннеди
- *дефект зубного ряда 2 класс по Кеннеди
- *дефект зубного ряда 3 класс по Кеннеди
- *дефект зубного ряда 4 класс по Кеннеди
- *дефект зубного ряда 4 класс по Гаврилову

#385

*!Женщине 70 лет, запланировано изготовление полного съемного пластиночного протеза на нижнюю челюсть. При объективном осмотре полости рта: выявлена неравномерная атрофия альвеолярного отростка.

Какой из перечисленных ниже типов атрофии альвеолярного отростка НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *1 тип по Оксману
- *2 тип по Оксман
- *3 тип по Оксману

*+4 тип по Оксману

*1 тип по Шредеру

#386

*! Женщине 45 лет, запланирован частичный съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть. При осмотре: имеется включенный дефект зубного ряда в переднем отделе, с выраженным альвеолярным гребнем.

Какая из перечисленных ниже постановок зубов НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*на металлическом базисе

*на искусственной десне

*на двухслойном базисе

*на мягкой подкладке

*+на приточке

#387

*!Женщина 52 лет, предъявляет жалобы на выдвижение зубов на верхней челюсти. При осмотре выявлено перемещение 25, 26, 27 зубов на верхней челюсти с увеличением костной ткани, окружающей зуб. Соотношение вне- и внутриальвеолярной части зуба при этом не изменилось.

Какой из перечисленных ниже форм зубоальвеолярного удлинения по Пономареву В.А. НАИБОЛЕЕ соответствует описанная ситуация?

*+первой форме

*второй форме

*третьей форме

*второй форме, 1 подгруппе

*второй форме, 2 подгруппе

#388

*!Мужчина 25 лет, обратился в клинику с жалобами на эстетический дефект. Из анамнеза: неоднократно лечил 16, 26 по поводу кариеса, пломбы часто выпадали. Объективно: на всей поверхности 16, 26 зубов пломбы сколоты, зубы в цвете изменены. Какой вид вкладки НАИБОЛЕЕ целесообразен?

*инлей

*онлей

*пинлей

*+оверлей

*культю

#389

*!Мужчине 55 лет, на верхнюю челюсть изготовлен частичный съемный пластиночный протез. В полости рта протез фиксируется телескопической системой на 13 и 23 зубы. Применение какого из ниже перечисленных систем НАИБОЛЕЕ целесообразно?

*зуб-кламмер

*коронка-вкладка

*коронка-кламмер

*+колпачок-коронка

*имплантат-кламмер

#390

*!Мужчина 50 лет, обратился с целью протезирования. При осмотре коронковая часть передних зубов на верхней и нижней челюсти стерты, на $\frac{1}{2}$ высоту коронок, корни устойчивы. На панорамной рентгенограмме корневые каналы 131211212223 и 4342413132333 запломбированы. Имеется концевой дефект на верхней челюсти слева, двухсторонний концевой дефекты на нижней челюсти.

Какой вид ортопедической конструкции из перечисленных ниже, НАИБОЛЕЕ целесообразно применить в первую очередь?

- *бюгельные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти на аттачменах
- *частичные съемные пластиночные протезы на обе челюсти
- *комбинированные коронки на передние зубы обеих челюстей
- *культевые штифтовые вкладки на передние зубы обеих челюстей
- *+восстановление высоты нижнего отдела лица пластмассовой каппой

#391

*!Мужчина 30 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на постоянное выпадение пломбы. При осмотре коронка 2.6 разрушена на 1/3 высоты коронки зуба, зуб запломбирован, антагонизирующие зубы не в контакте. Для изготовления на 2.6 зуб восстановительную металлическую штампованную коронку, врач отпрепарировал 2.6 зуб, снял частичный анатомический слепок с верхней челюсти. При припасовке коронки было выявлено, что коронка завывает окклюзию. На каком этапе НАИБОЛЕЕ вероятно была допущена ошибка?

- *1-лабораторном
- *2-лабораторном
- *+1-клиническом
- *2-клиническом
- *3-клиническом

#392

*!Мужчина 48 лет, обратился с просьбой изготовить мостовидный протез при отсутствии 2.1;1.1;2.2 зубов. Врач припасовал протез на опорные зубы и обнаружил, что в положении центральной окклюзии смыкаются только верхние резцы с фасетками. Остальные зубы не смыкаются. Припой в месте пайки между коронкой 13 зуба и промежуточной частью касается десневого сосочка. Врач освободил десневой сосочек от припоя..... Какое из перечисленных дальнейших действий врача НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *установить мостовидный протез поглубже
- * отполировать тело мостовидного протеза
- *+ удалить контактный участок фасетки
- * допрепарировать опорные зубы
- * допрепарировать зубы антагонисты

#393

*!Мужчина 50 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов на нижней челюсти. Зубы удалялись вследствие осложненного кариеса 5 лет назад. Зубы устойчивые. Зубная формула: 87654321/12300678

Какая из перечисленных конструкций протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- * штампованно-паяный мостовидный протез
- *+металлокерамический мостовидный протез
- *металлопластмассовый мостовидный протез
- *адгезивный мостовидный протез
- *пластмассовый мостовидный протез

#394

*!Мужчина 47 лет, обратился в клинику для ортопедического лечения с диагнозом: «Дефект зубного ряда в/ч I класс по Кеннеди ».

Зубная формула: 00054321 ! 12340000

Сохранившиеся зубы устойчивы, интактны, имеют хорошо выраженную анатомическую форму. Альвеолярные отростки умеренно атрофированы, слизистая полости рта без особенностей.

Рекомендовано изготовить бюгельный протез на верхнюю челюсть.

Применение какого из перечисленных оттисковых материалов НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *+эластический
- *твердокристаллический
- *термопластический
- *гидроколлоидный
- *полиэфирный

#395

*!Женщина 75 лет, обратилась с жалобами на полное отсутствие зубов на нижней челюсти. Ранее протезировалась.

Объективно: Лицо симметричное. Нижняя треть лица снижена.

Слизистая покрывающая альвеолярные отростки и небо атрофирована натянута тонким слоем. Места прикрепления естественных складок расположены близко к вершине альвеолярного отростка, резкая, равномерная атрофия альвеолярного отростка.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *2 тип по Оксману, 1 класс по Суппле
- *1 тип по Оксману, 3 класс по Суппле
- *+3 тип по Оксману, 2 класс по Суппле
- *4 тип по Оксману, 4 класс по Суппле
- *2 тип по Оксману, 2 класс по Суппле

#396

*!Мужчина 43 лет, обратился с жалобой на одностороннюю боль. Хруст и тугоподвижность нижней челюсти. Шум в суставах, головные боли. Объективно: отсутствие боковых 28, 27, 26, 46, 47, 48 зубов 14, 13, 12, 11, 21, 21, 22, 23, 24, 25 зубов обнаружена патологическая стираемость зубов. При открывании нижней челюсти челюсть смещается в одну сторону. Открывание рта ограничена до 3 см. При пальпации латерального крыловидного мышца безболезненна.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *парез лицевого нерва
- *+остеоартроз
- *нейромускулярный дисфункциональный синдром
- *артикуляционный окклюзионный синдром
- *вывих височно-нижнечелюстного сустава

#397

*!Мужчина 62 года, жалобы на полное отсутствие зубов на верхней и нижней челюстях. Больному изготовлен полный съемный протез на верхнюю и нижнюю челюсть. После наложения протеза у больного при внешнем осмотре сглаженность носо-губных и подбородочных складок, боли в ВНЧС

В компетенции какого специалиста лечение данной патологии?

- *врача стоматолога-терапевта
- *хирурга-стоматолога
- *детского стоматолога
- *врача-ортодонта
- *+врача-ортопеда

#398

*!Женщина 65 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов, эстетический дефект, нарушение акта жевания. Анамнез болезни: зубы удалялись в течение 12 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась. Объективные данные: на верхней челюсти отсутствуют центральные резцы, остальные зубы интактны, слизистая полости рта без видимой патологии

Какой из перечисленных диагнозов по классификации Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+4 класс
- *1 класс
- *3 класс
- *2 класс
- *I класс, 2 подкласс

#399

*!Женщина 43 года, обратилась с жалобами на хруст, шелканье в области височно-нижнечелюстного сустава, а также шум в ушах и их заложенность, асимметрию лица. При объективном осмотре обнаружено снижение межальвеолярной высоты, отсутствие боковых зубов, в переднем отделе зубного ряда наличие преждевременных окклюзионных контактов, боковое смещение нижней челюсти.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *патологическая стираемость
- *+окклюзионно-артикуляционный синдром
- *острый артрит-артроз ВНЧС
- *феномен Попова-Годона
- *травматическая окклюзия

#400

*!Мужчина 65 лет, обратился с жалобами на потерю всех зубов и затруднённый приём пищи. При объективном осмотре наблюдается высокая альвеолярная часть, покрытая слегка податливой слизистой оболочкой, высокие бугры верхней челюсти, выраженный свод неба, покрытый равномерным слоем слизистой оболочки и умеренно податливой в задней его трети. Естественные складки слизистой оболочки как на верхней, так и на нижней челюсти достаточно удалены от вершины альвеолярной части. Высокое расположение переходной складки.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+1 тип по Оксману, I класс по Суппле
- *2 тип по Оксману, IV класс по Суппле
- *3 тип по Оксману, I класс по Суппле,
- *4 тип по Оксману, IV класс по Суппле
- *4 тип по Оксману, III класс по Суппле

#401

*!Мужчина 68 лет, обратился с жалобами на отсутствие всех зубов. При объективном осмотре отмечается смещение нижней челюсти вперед, средневывраженная атрофия альвеолярного гребня и бугров верхней челюсти, менее глубокое небо и более низкое прикрепление подвижной слизистой оболочки.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+2 тип по Оксману
- *3 тип по Оксману
- *4 тип по Оксману
- *1 тип по Оксману
- *5 тип по Оксману

#402

*!В клинику обратился мужчина 48 лет, с жалобами на подвижность зубов с нарушением функции жевания. Объективно: верхняя губа слегка выступает, коронки верхних центральных зубов расположены веерообразно. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 зубы подвижны I степени, 28, 27, 26, 36, 37, 38 зубы отсутствуют. Прикус ортогнатический. Имеются тремы и диастемы между зубами. Шейки зубов оголены. При пальпации на всех зубах зубодесневые карманы выделяют небольшое количество гноя. Десна гиперемирована, отечна.

Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ целесообразным?

- *фронтальная стабилизация с применением колпачковой шины
- *сагитальная стабилизация, с применением экваторных коронок
- *парасагитальная стабилизация с применением шины из полукоронок
- *+круговая стабилизация с применением бюгельного протеза
- *фронтальная стабилизация с применением мостовидного протеза

#403

*!Мужчина 25 лет, обратился с жалобой на разрушение коронки 17 зуба. Анамнез: 17 зуб лечился по поводу кариеса и неоднократно лечился у терапевта-стоматолога. Наложённая пломба 2 раза выпадала. Объективно: клиническая коронка 17 зуба низкая, на окклюзионной поверхности зуба стоит обширная пломба. Зуб депульпирован, перкуссия отрицательная, на рентгенограмме корневые каналы запломбированы до верхушки корней. Патологических изменений нет.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *цельнолитая коронка с анкерным штифтом
- *пластмассовая коронка
- *+культевая коронка с парапульпарным штифтом
- *штифтовый зуб по Ричмонду
- *пластмассовая коронка со штифтом

#404

*!Женщина 43 года, жалобы на косметический дефект на вестибулярной поверхности чащеобразные углубления овальной формы. На дне углубления эмали истончена. И через нее просвечивают дентин желтого цвета. Дно стенки и края углубления гладкие. Дефекты локализуются в области экватора и щечной области.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *искусственные протезы
- *+виниры
- *полукоронки
- *комбинированные коронки
- *восстановительные пломбы

#405

*!Мужчина 56 лет, жалуется на недостаточную фиксацию протеза на нижнюю беззубую челюсть во время функции жевания и разговора. Объективно: определяются наличие широкого объемного языка, заполняющего свободное пространство.

Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ рациональным и эффективным?

- *удлинение границы протеза
- *+создание углубления в базисе с язычной стороны
- *сделать эластическую подкладку под базис протеза
- *перебазировка самотвердеющей пластмассой
- *переделка съёмного протеза

#406

*!Мужчина 44 года, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобой на разрушение 26 зуба. Объективно: клиническая коронка 26 зуба низкая, разрушена кариесом, зуб депульпирован. Перкуссия отрицательная. На рентгенограмме корневые каналы запломбированы до верхушек корней.

Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ рациональным и эффективным?

- *восстановление пломбы с последующим протезированием штампованной коронкой
- *восстановительная пломба из светополимеризующей пластмассы
- *+штифтование штифтами с последующим протезированием штампованной коронкой
- *восстановительная коронка из пластмассы

*восстановительная пломба с последующим протезированием металлокерамической коронкой

#407

*!Мужчина 47 лет, в полости рта отсутствует 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 28 зубы. Оставшиеся зубы имеют физиологическую подвижность.

Какая из ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*бюгельный протез

*+частично- съемный протез

*мостовидный протез

*шинирующий бюгельный протез

*съемный мостовидный протез

#408

*!Мужчина 25 лет, обратился с жалобой на внезапное блокирование движений в височно-нижнечелюстном суставе. При этом отмечает болезненность в области сустава. Анамнез: эти симптомы появились после широкого открывания рта во время откусывания яблока. Пациент отмечает, что при надавливании пальцем в области сустава движения нижней челюсти восстанавливаются.

Объективно: лицо симметрично, кожные покровы чистые, прикус ортогнатический, бледно-розового цвета. На 16, 17 зубах имеются пломбы.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

*+вывих мениска

*вывих челюсти

*перелом нижней челюсти

*неврогенная контрактура

*подвывих челюсти

#409

*!Мужчина 70 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов, нарушение акта жевания. Анамнез болезни: зубы удалялись в течение 10 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась.

Объективные данные: на верхней челюсти отсутствуют все премоляры и моляры, оставшиеся зубы интактны

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

*3 класс по Кеннеди на нижней челюсти

*4 класс по Кеннеди на нижней челюсти

*+1 класс по Кеннеди на нижней челюсти

*2 класс по Кеннеди на нижней челюсти

*III класс по Гаврилову на нижней челюсти

#410

*!Женщина 45 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов, эстетический дефект, нарушение акта жевания. Анамнез болезни: зубы удалялись в течение 7 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась. Объективные данные: на верхней челюсти отсутствуют центральные резцы, остальные зубы интактны

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

*II класс по Кеннеди на верхней челюсти

*I класс по Кеннеди на верхней челюсти

*+IV класс по Кеннеди на верхней челюсти

*I класс по Кеннеди на верхней челюсти

*+III класс по Гаврилову на верхней челюсти

#411

*!Мужчина 35 лет, обратился к врачу-ортопеду с жалобами на эстетический дефект, затрудненную речь. Зубы были неоднократно пломбированы. Объективно: 11,21 зубы разрушены, имеются остатки пломбы, зубы устойчивые, перкуссия безболезненна.

Какая из ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+металлокерамические коронки на 11, 21 зубы
- *коронки из СПС на 11, 21 зубы
- *цельнолитые коронки из золота на 11, 21 зубы
- *мостовидный протез из золота
- *штампованные коронки на 11, 21 зубы

#412

*!Женщина 68 лет, обратилась с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти и частичное на нижней челюсти. Были изготовлены полный съемный протез на верхнюю челюсть и частичный съемный на нижнюю челюсть. После припасовки и сдачи полного съемного протеза на верхнюю челюсть протез не фиксируется.

Какой из предложенных тактик НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *+переделка полного съемного протеза
- *коррекция протеза
- *фиксация протеза с помощью фиксирующего геля
- *перебазировка протеза
- *определение центральной окклюзии

#413

*!Мужчина 39 лет, жалуется на отсутствие 11, 12 зуба. Зубы потерял вследствие травмы 2 месяца назад. Объективно: Слизистая полости рта без патологических изменений. На в\ч отсутствуют 11, 12 зубы. Прикус ортогнатический.

Какая из ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+мостовидный протез из пластмассы
- *частичный съемный протез
- *полный съемный протез
- *мостовидный протез из золота
- *мостовидный протез из СПС

#414

*!Мужчина перенес инфаркт миокарда три месяца назад. Подвижность зубов 31, 32, 33, 41, 42, 43 - 2-3-й степени. Отсутствуют жевательные зубы на нижней челюсти.

НАИБОЛЕЕ рациональным и последовательным методом лечения является

- *заклучение терапевта о состоянии здоровья и возможности проведения ортопедического лечения.
- *терапевтическое лечение пародонтита.
- *шинирующий бюгельный протез на нижнюю челюсть.
- *съемный протез на нижнюю челюсть.
- *+комплексное лечение: терапевтическое + ортопедическое (шинирующий бюгельный протез).

#415

*!У Женщины 40 лет, на 23 зубе отсутствует коронковая часть,

Какой метод изготовления штифтово-культевой конструкции НАИБОЛЕЕ целесообразен при последующем покрытии translucentной цельнокерамической коронкой?

- *стекловолоконный штифт и культя из композита
- *стандартный анкерный титановый штифт и культя из композита

- *стандартный анкерный медный штифт и культя из композита
- *стандартный анкерный штифт из нержавеющей стали и культя из композита
- *+цельнолитая металлическая штифтово-культевая вкладка.

#416

- *!У Женщины 35 лет, коронковая часть разрушена свыше 55%, рекомендовано изготовить вкладку при препарировании полости зуба под вкладку
- Под каким углом НАИБОЛЕЕ целесообразно формировать фальс?
- *15 градус
- *30 градус
- *+45 градус
- *60 градус
- *90 градус

#417

- *!У Женщины 30 лет, при обследовании,прикус ортогнатический,фиксированный,интактный
- Какие НАИБОЛЕЕ важные анатомические ориентиры зубов фиксируют межальвеолярное расстояние при ортогнатическом прикусе?
- *щечные жевательные бугры верхних и нижних боковых зубов
- *небные и язычные жевательные бугры верхних и нижних боковых зубов
- *щечные бугры верхних и язычные бугры нижних боковых зубов
- *+небные бугры верхних и щечные бугры нижних боковых зубов
- *режущие края верхних зубов

#418

- *!У мужчины 52 лет, при обследовании полости рта односторонний концевой дефект зубного ряда
- Какому классу по классификации Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятно относится данный дефект?
- *первому
- *+второму
- *третьему
- *четвертому
- *седьмому классу

#419

- *!Мужчина 30 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на постоянное выпадение пломбы. При осмотре коронка 2.6 разрушена на 1/3 высоты коронки зуба, зуб запломбирован, антагонизирующие зубы не в контакте. Для изготовления на 2.6 зуб восстановительную металлическую штампованную коронку, врач отпрепарировал 2.6 зуб, снял частичный анатомический слепок с верхней челюсти. При припасовке коронки было выявлено, что коронка завывает окклюзию. На каком этапе НАИБОЛЕЕ вероятно была допущена ошибка?
- *1-лабораторном
- *2-лабораторном
- *+2-клиническом
- *+1-клиническом
- *3- клиническом

#420

*!У мужчины 67лет, беззубая верхняя челюсть. Атрофия альвеолярного отростка средней степени, маловыраженные бугры, средняя глубина неба, выраженный торус.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *полная вторичная адентия, I – тип по Оксману
- *+полная вторичная адентия, II- тип по Оксману
- *полная вторичная адентия, II- тип по Суппле
- *полная вторичная адентия, III- тип по Оксману
- *полная вторичная адентия, III- тип по Суппле

#422

*!Мужчине 75лет, при припасовке индивидуальной ложки на нижнюю челюсть с использованием функциональных проб по Гербсту, в момент глотания слепочная ложка смещается с нижней челюсти,

Какая НАИБОЛЕЕ рациональная тактика врача стоматолога-ортопеда?

- *+ложку необходимо укоротить на участке от места позади бугорка до челюстно-подъязычной линии
- *ложку в таких случаях укорачивают по вестибулярному краю сзади, в области поперечных тяжей и уздечки
- *ложку укорачивают по вестибулярному краю спереди, в области уздечки языка
- *ложку укорачивают вдоль челюстно-подъязычной линии
- *ложку укорачивают в зоне между клыками с вестибулярной стороны

#423

*!У мужчины 48лет, на нижней челюсти двухсторонний концевой дефект зубного ряда.

Зубная формула : 00004321 / 12340000

Был изготовлен частичный съемный пластиночный протез с удерживающими кламмерами на 34 и 44 зубы.

Какой НАИБОЛЕЕ рациональный вид кламмерной фиксации съемного протеза указан?

- *+трансверзальный
- *поперечный
- *точечный
- *сагитальный
- *диагональный

#424

*!У мужчины 56лет, диагноз : «Дефект зубного ряда на нижней челюсти 3-класс по Кеннеди». Рекомендовано изготовить составной мостовидный протез с опорами на 37 и 33 зубы

Почему выбрана такая конструкция протеза?

- *из-за подвижности опорных зубов, ограничивающих дефект
- *из-за включенного бокового дефекта зубного ряда
- *+из-за большой конвергенции зубов, ограничивающих дефект
- *из-за большой протяженности дефекта зубного ряда
- *из-за глубокого прикуса, при смыкании зубов

#425

*!Мужчине 48лет, запланировали бюгельные протезы на в/ч и н/ч. Сняли анатомические слепки. Отлили из высокопрочного гипса модели. Приготовленную модель изучают в параллелометре; в лаборатории техник начал подводить к каждому опорному зубу грифель, но по данной методике параллелометрии разделительная линия не совпадала с анатомическими экваторами зубов.

Какой метод параллелометрии НАИБОЛЕЕ соответствует описанному?

- *метод выявления среднего наклона длинных осей опорных зубов
- *+произвольный метод

- *метод выбора
- *метод анализа наклона зубов
- *метод определения экватора

#426

*!Мужчине 34 лет, был изготовлен штампованно-паянный мостовидный протез. Десна в области протеза гиперемированна, отечна. При зондировании края коронки не обнаруживаются.

На каком этапе НАИБОЛЕЕ вероятно была допущена ошибка?

- *1-клиническом
- *1-лабораторном
- *+2-клиническом
- *2-лабораторном
- *3-клиническом

#427

*!Мужчина 47 лет, обратился в клинику для ортопедического лечения с диагнозом: «Дефект зубного ряда в/ч II класс по Кеннеди ».

Зубная формула: 00054321 ! 12340000

Сохранившиеся зубы устойчивы, интактны, имеют хорошо выраженную анатомическую форму. Альвеолярные отростки умеренно атрофированы, слизистая оболочка альвеолярных отростков и твердого неба плотная, умеренно податливая.

Рекомендовано - изготовить бюгельный протез на верхнюю челюсть.

Какие оттискные материалы НАИБОЛЕЕ целесообразно использовать?

- *+эластические
- *твердокристаллические
- *термопластические
- *гидроколлоидные
- *полиэфирные

#428

*!Мужчина 27 лет, обратился с целью протезирования. Объективно: высота нижнего отдела лица не изменена. Слизистая полости рта бледно-розовой окраски.

Зубная формула: 870054321/12345678.

Какой НАИБОЛЕЕ вероятный диагноз по классификации по Кеннеди?

- *1 класс
- *2 класс
- *+3 класс
- *4 класс
- *5 класс

#429

*!Мужчина 36 лет, обратился в клинику с целью протезирования. Анамнез: зубы удалены вследствие осложненного кариеса, ранее не протезировался.

Объективно: Зубная формула: 00000321/12345678

Слизистая оболочка бледно розового цвета, без видимых патологических изменений.

Прикус по типу ортогнатического.

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+частично-съемный пластиночный протез
- *полный съемный пластиночный протез
- *съемный мостовидный протез
- *адгезивный мостовидный протез
- *пластмассовые каппы, составной протез

#430

*!Женщина 68 лет, обратилась с жалобами на полное отсутствие зубов на нижней челюсти. Ранее протезировалась.

Объективно: Лицо симметричное. Нижняя треть лица снижена.

Слизистая покрывающая альвеолярные отростки и небо атрофирована натянута тонким слоем. Места прикрепления естественных складок расположены близко к вершине альвеолярного отростка, резкая, равномерная атрофия альвеолярного отростка.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

*2 тип по Оксману, 1 класс по Суппле

*1 тип по Оксману, 3 класс по Суппле

*+3 тип по Оксману, 2 класс по Суппле

*4 тип по Оксману, 4 класс по Суппле

*2 тип по Оксману, 2 класс по Суппле

#431

*!Женщина 33 года, обратилась с жалобами на изменение цвета передних зубов и частое выпадение пломбы. Объективно: 11,12,21 зубы ранее леченные, перкуссия безболезненна

Диагноз: Дефект коронки 11,12,21 зубов.

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*вкладка

*штифтовый зуб

*литая коронка

*+металлокерамическая коронка

*пластмассовая полукоронка

#432

*!Мужчина 65 лет, обратился с жалобами на отсутствие зубов, затрудненный прием пищи. Объективно-на верхней челюсти полная адентия, на нижней челюсти-двухсторонний концевой дефект

Слизистая бледно-розового цвета, уздечки и щечные тяжи на в/ч расположены близко к вершине альвеолярного гребня, на н/ч оставшиеся зубы устойчивые, перкуссия б/б, выявлена равномерная атрофия альвеолярного отростка.

На этапе проверки конструкции протеза врач заметил, что при улыбке пациента видна альвеолярная часть протеза.

Какая НАИБОЛЕЕ вероятная причина ошибки?

*+постановка на искусственной десне

*неправильно подобраны искусственные зубы

*перекрестная постановка

*постановка на «приточке»

*неправильно определен тип прикуса

#433

*!Мужчины 48 лет, отсутствует 32,33,34,35,36 зубы, врач решил изготовить болному металлокерамический мостовидный протез с опорами на 31 и 37 зубы.

Правильно ли выбрана конструкция протеза и почему?

*правильно – мостовидные протезы полностью восстанавливает жевательное давление

*неправильно – опорные зубы не депульпированы

*+неправильно – большая нагрузка на опорные зубы

*правильно – эстетично, быстро привыкает к протезу

*неправильно - количество опорных зубов недостаточно

#434

*!Мужчина 32 лет, обратился с жалобой на боли при накусывании на 26 зуб. Из анамнеза неделю назад на 26 зуб изготовлена металлическая коронка, при временном пользовании коронкой до фиксации болевых ощущений не было.

Какая тактика врача стоматолога-ортопеда НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+снятие коронки с зуба
- *назначить противовоспалительную терапию
- *назначить обезболивающие
- *депульпировать зуб через коронку
- *удаление зуба с коронкой

#435

*!Мужчина 61лет, жалобы на полное отсутствие зубов на верхней челюсти. Объективно: Лицо симметричное, кожные покровы чистые, носогубные складки выражены, нижняя треть лица снижена. В полости рта: на в/ч зубы полностью отсутствуют, на н/ч сохранились 35, 34, 33, 43, 44 зубы, перкуссия б/б, устойчивы. После сдачи врачом полного съемного протеза на в/ч и частичного съемного - на н/ч через несколько дней больной предъявил жалобы на боли в области ВНЧС и прикусывание щеки слева.

Какая НАИБОЛЕЕ вероятная причина ошибки ?

- *+неправильное определение центрального соотношения челюстей
- * деформация прикусного валика во время определения центральной окклюзии
- * неправильная постановка искусственных зубов
- * ошибка во время заливки моделей в кювету
- * нарушен режим полимеризации

#436

*!Мужчина 43 лет, обратился с жалобой на одностороннюю боль. Хруст и тугоподвижность нижней челюсти. Шум в суставах, головные боли. Объективно: отсутствие боковых 28, 27, 26, 46, 47, 48 зубов 14, 13, 12, 11, 21, 21, 22, 23, 24, 25 зубах обнаружена патологическая стираемость зубов. При открывании нижней челюсти челюсть смещается в одну сторону. Открывание рта ограничено до 3 см. При пальпации латерального крыловидного мышца безболезненна.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *парез лицевого нерва
- *+остеоартроз
- *нейромускулярный дисфункциональный синдром
- *артикуляционный окклюзионный синдром
- *вывих височно-нижнечелюстного сустава

#437

*!Женщина 65 лет, обратилась в клинику ортопедической стоматологии с жалобами на отсутствие зубов, нарушение акта жевания. Анамнез болезни: зубы удалялись в течение 12 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась.

Объективные данные: на нижней челюсти справа отсутствуют премоляры и моляры

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *3 класс по Кеннеди на нижней челюсти
- *4 класс по Кеннеди на нижней челюсти
- *1класс по Кеннеди на нижней челюсти
- *+2 класс по Кеннеди на нижней челюсти
- *3 класс по Гаврилову на нижней челюсти

#438

*!Мужчина 43 лет, обратился с жалобами на хруст, щелканье в области височно-нижнечелюстного сустава, а также шум в ушах и их заложенность, асимметрию лица. При объективном осмотре обнаружено снижение межальвеолярной высоты, отсутствие

боковых зубов, в переднем отделе зубного ряда наличие преждевременных окклюзионных контактов, боковое смещение нижней челюсти.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- * патологическая стираемость
- *+окклюзионно-артикуляционный синдром
- * артрозо-артрит ВНЧС
- * феномен Попова-Годона
- * травматическая окклюзия

#439

*! Женщина 65 лет, обратился с жалобами на потерю всех зубов и затруднённый приём пищи. При объективном осмотре наблюдается высокая альвеолярная часть, покрытая слегка податливой слизистой оболочкой, высокие бугры верхней челюсти, выраженный свод неба, покрытый равномерным слоем слизистой оболочки и умеренно податливой в задней его трети. Естественные складки слизистой оболочки как на верхней, так и на нижней челюсти достаточно удалены от вершины альвеолярной части. Высокое расположение переходной складки.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+1 тип по Оксману, I класс по Суппле
- *2 тип по Оксману, IV класс по Суппле
- *3 тип по Оксману, I класс по Суппле
- *4 тип по Оксману, IV класс по Суппле
- *4 тип по Оксману, III класс по Суппле

#440

*! Мужчина 68 лет, обратился с жалобами на отсутствие всех зубов. При объективном осмотре отмечается смещение нижней челюсти вперед, средневыраженная атрофия альвеолярного гребня и бугров верхней челюсти, менее глубокое небо и более низкое прикрепление подвижной слизистой оболочки.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+2 тип по Оксману
- *3 тип по Оксману
- *4 тип по Оксману
- *1 тип по Оксману
- *5 тип по Оксману

#441

*! Мужчина 25 лет обратился в клинику с жалобами на отсутствие верхнего переднего зуба. При обследовании установлено зубная формула:

8 7 6 5 4 3 2 1 \ 1 0 2 3 4 5 6 7 8

Прикус по типу ортогнатического.

Какой из перечисленных диагнозов по классификации Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *I класс по Кеннеди
- *II класс по Кеннеди
- *III класс по Кеннеди
- *+IV класс по Кеннеди
- *III класс по Гаврилову

#442

*! Мужчина 70 лет, объективно альвеолярные отростки и бугры на верхней челюсти отсутствуют, небо плоское. Переходная складка расположена в одной горизонтальной плоскости с твёрдым нёбом.

Какой из перечисленных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *+беззубая верхняя челюсть III тип по Шредеру

- *беззубая верхняя челюсть II тип по Шредеру
- *беззубая верхняя челюсть III класс по Суппле
- *беззубая верхняя челюсть по Оксману 1 тип
- *по Оксману 2 тип беззубой верхней челюсти

#443

*!Мужчина 49 лет, обратился с целью протезирования. При осмотре отсутствуют зубы 36, 37 38 46 47 48. Прикус ортогнатический. Оставшиеся зубы интактны. Какая из ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *мостовидный
- *+бюгельный
- *консольный
- *полный съемный
- *металлокерамические коронки

#444

*!Мужчина 30 лет, обратился в ортопедический кабинет с жалобами на разрушение коронки 12 зуба до десны.

Какой метод лечения НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *+восстановление стандартным стекловолоконным штифтом и протезирование металлокерамической коронкой
- *штифтование анкерным штифтом, восстановление светополимеризующейся пластмассой
- *восстановление культевой штифтовой металлической вкладкой, протезирование керамической коронкой
- *штифтовый зуб по Ричмонду
- *простой штифтовый зуб

#445

*!В клинику обратился мужчина, 48 лет с жалобами на подвижность зубов с нарушением функции жевания. Объективно: верхняя губа слегка выступает, коронки верхних центральных зубов расположены веерообразно. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 зубы подвижны I степени, 28, 27, 26, 36, 37, 38 зубы отсутствуют. Прикус ортогнатический. Имеются тремы и диастемы между зубами. Шейки зубов оголены. При пальпации на всех зубах зубодесневые карманы выделяют небольшое количество гноя. Десна гиперемирована, отечна.

Какой метод лечения НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *фронтальная стабилизация с применением колпачковой шины
- *сагитальная стабилизация, с применением экваторных коронок
- *парасагитальная стабилизация с применением шины из полукоронок
- *+круговая стабилизация с применением бюгельного протеза
- *фронтальная стабилизация с применением мостовидного протеза

#446

*!Мужчина 32 лет обратился с жалобой на разрушение коронки 17 зуба. 17 зуб лечился по поводу кариеса и неоднократно лечился у терапевта-стоматолога. Вставленная пломба 2 раза выпадала. Объективно: клиническая коронка 17 зуба низкая, на окклюзионной поверхности зуба стоит обширная пломба. Зуб депульпирован, перкуссия отрицательная, на рентгенограмме корневые каналы запломбированы до верхушки корней. Патологических изменений нет.

Какая ортопедическая конструкция НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *цельнолитая коронка с анкерным штифтом
- *пластмассовая коронка
- *+культевая коронка с парапульпарным штифтом
- *штифтовый зуб по Ричмонду

*пластмассовая коронка со штифтом

#447

*!Женщина 43, года жалобы на косметический дефект на вестибулярной поверхности чашеобразные углубления овальной формы. На дне углубления эмали истончена. И через нее просвечивают дентин желтого цвета. Но стенки и края углубления гладкие. Дефекты локализируются в области экватора и щечной области.

Какая ортопедическая конструкция НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*металлические коронки

*+виниры

*полукоронки

*комбинированные коронки

*восстановительные пломбы

#448

*!Пациент 56 лет, жалуется на недостаточную фиксацию протеза на нижнюю беззубую челюсть во время функции жевания и разговора. Объективно: определяются наличие широкого объемного языка, заполняющего свободное пространство.

Какой метод лечения НАИБОЛЕЕ эффективен?

*удлинить границы протеза

*+создать углубление в базисе с язычной стороны

*сделать эластическую подкладку под базис протеза

*перебазировка самотвердеющей пластмассой

*переделать съемный протез

#449

*!Больному 44 года, обратился в клинику ортопедической стоматологии с жалобой на разрушение 26 зуба. Объективно: клиническая коронка 26 зуба низкая, разрушена кариесом, зуб депульпирован. Перкуссия отрицательная. На рентгенограмме корневые каналы запломбированы до верхушек корней.

Какой метод лечения НАИБОЛЕЕ целесообразен?

*восстановление пломбы с последующим протезированием штампованной коронкой

*восстановительная пломба из светополимеризующей пластмассы

*+штифтование штифтами с последующим протезированием штампованной коронкой

*восстановительная коронка из пластмассы

*восстановительная пломба с последующим протезированием металлокерамической коронкой

#450

*!Больной 47 лет, в полости рта отсутствует 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 28 зубы.

Оставшиеся зубы имеют физиологическую подвижность.

Какой протез НАИБОЛЕЕ целесообразен?

*бюгельный протез

*+частичный съемный протез

*мостовидный протез

*шинирующий бюгельный протез

*съемный мостовидный протез

#451

*!Мужчины 56 лет, жалуется на плохое пережевывание пищи из-за отсутствия зубов. Зубы удалены 2 месяца тому назад вследствие осложненного кариеса. Имеется частичная вторичная адентия верхней челюсти с отсутствием 16, 15, 25, 26 зубов. Остальные зубы интактны. Нижний зубной ряд интактен.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *бюгельный протез
- *составные мостовидные протезы
- *адгезивные мостовидные протезы
- *+металло-керамические мостовидные протезы
- *частичные съемные протезы

#452

*!Мужчины 52 лет, жалуется на плохое пережевывание пищи из-за отсутствия зубов. Зубы удалены в связи с подвижностью месяц назад. Объективно-отсутствуют премоляры и моляры на правой стороны верхней челюсти. Свод твердого неба выражен. На нижней челюсти зубы интактны, слизистая полости рта без видимой патологии.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна ?

- *+бюгельный протез на аттачменах
- *частичный съемный протез
- *консольный протез
- *бюгельный протез на кламмерах
- *составной протез

#453

*!Мужчина 25 лет, жалуется на косметический дефект. Со слов на вестибулярной поверхности передних зубов имелись темные пятна, которые 5 лет тому назад покрыты золотыми коронками. Объективно- центральные резцы, клыки верхней челюсти под коронками. Состояние коронок удовлетворительное. Перкуссия зубов без особенностей. Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ целесообразно?

- *сделать рентгенографию
- *провести одонтометрию
- *заменить коронки на пластмассовые
- *снять коронки и изготовить металло-керамические
- *+снять коронки и изготовить из циркония

#454

*!Женщина 28 лет , жалуется на косметический дефект. Объективно- 12,11,21,22,32,31,41,42 зубы поражены кариозным процессом. Наличие полостей 4 класса по Блеку. Сопутствующее заболевание – флюороз. При осмотре и зондировании зубы изменены в цвете, эмаль неплотная.

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *+коронки
- *полукоронки
- *люминиры
- *вкладки
- *виниры

#455

*!НАИБОЛЕЕ информативный и доступный метод определения состояния периапикальных тканей зубов, подлежащих использованию под опору мостовидных протезов

- *миография
- *томография
- *реография
- *+ рентгенография
- * мастикациография

#456

*!Какие из перечисленных методов дополнительного обследования пациентов с частичной вторичной адентией НАИБОЛЕЕ целесообразно провести для выбора рациональной конструкции протезов

*томография

*компьютерная томография

*магнитно-резонансная томография

*+ортопантомограмму

*прицельная рентгенография

#457

*!Мужчины 72 лет, жалуется на плохое пережевывание и откусывания пищи из-за отсутствия зубов. Объективно имеется беззубая верхняя челюсть. Атрофия альвеолярного отростка средней степени, маловыраженные бугры, средняя глубина неба, выраженный торус. Слизистая бледно-розовой окраски, увлажненная

Какой из перечисленных типов полной вторичной адентии НАИБОЛЕЕ вероятен?

*I – тип по Оксману

*+II- тип по Оксману

*II- тип по Суппле

*III- тип по Оксману

*III- тип по Суппле

#458

*!Мужчины 65 лет, жалуется на плохое пережевывание пищи из-за отсутствия зубов. Зубы удалены из-за подвижности 3 месяца тому назад. Объективно- на нижней челюсти двухсторонний концевой дефект зубного ряда ограниченный клыками. На верхней челюсти полный съемный пластиночный протез в хорошем состоянии

Прикус ортогнатический Атрофия альвеолярных отростков умеренная. Слизистая полости рта без особенностей

Какая из перечисленных ортопедических конструкций НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*+бюгельный протез

*мостовидный протез

*консольные протезы

*адгезивный протез

*частичный пластиночный

#459

*!Мужчина 74 лет, жалуется на плохую фиксацию полных съемных протезов. Со слов пациента протезы он носит более 5 лет. Неоднократно делалась реставрация базиса протезов. Объективно-полная вторичная адентия челюстей с равномерной атрофией альвеолярных отростков. Слизистая умеренно податлива, увлажнена.

Какая тактика врача стоматолога-ортопеда НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*рекомендовать адгезивы

*+сделать новые протезы

*сделать перебазировку

*сделать присоски на протез

*утяжелить нижний протез

#460

*!Мужчина 30 лет, обратился в клинику с жалобами на отсутствие верхнего переднего зуба. При обследовании установлено зубная формула:

8 7 6 5 4 3 2 0 1 I 1 2 3 4 5 6 7 8

Прикус по типу ортогнатического.

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*мостовидный протез из СПС

- *коронки из СПС
- *частичный пластиночный протез
- *+мостовидный протез из металлокерамики
- *мостовидный протез из золота

#461

- *!Женщина 68 лет, обратилась с жалобами на полное отсутствие зубов на верхней челюсти и частичное на нижней челюсти. Были изготовлены полный съемный протез на верхнюю челюсть и частичный съемный на нижнюю челюсть. После припасовки и сдачи полного съемного протеза на верхнюю челюсть протез не фиксируется. Какой из предложенных тактик НАИБОЛЕЕ целесообразен?
- *+переделка полного съемного протеза
 - *коррекция протеза
 - *фиксация протеза с помощью фиксирующего геля
 - *перебазировка протеза
 - *определение центральной окклюзии

#462

- *!Мужчина 25 лет, обратился к врачу стоматологу на проф.осмотр. объективно: в полости рта слизистая бледно-розового цвета, хорошо увлажнена, зубы 35, 36 отсутствуют. Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?
- *бюгельный протез
 - *частичный съемный протез
 - *полный съемный протез
 - *+мостовидный протез
 - *консольный протез

#463

- *!Мужчина 39 лет, безработный, жалуется на отсутствие 11, 12 зуба. Зубы потерял вследствие травмы 2 месяца назад. Объективно: Слизистая полости рта без патологических изменений. На в\ч отсутствуют 11, 12 зубы. Прикус ортогнатический. Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?
- *+мостовидный протез из пластмассы
 - *частичный съемный протез
 - *полный съемный протез
 - *мостовидный протез из золота
 - *мостовидный протез из СПС

#464

- *!Мужчина 50 лет, жалуется на частичное отсутствие зубов, эстетический дефект, нарушение акта жевания. Зубы удалялись в течение 9 лет вследствие осложненного кариеса. Ранее съемными протезами не протезировалась. Объективно: на верхней челюсти отсутствуют все премоляры, моляры и два центральных резца, оставшиеся зубы имеют патологическую подвижность 1 степени. Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?
- *мостовидный протез
 - *+частичный съемный протез
 - *полный съемный протез
 - *микро протез
 - *консольный протез

#465

*!Мужчина 45 лет, жалуется на частичное отсутствие зубов, на подвижность зубов с нарушением функции жевания. Объективно: верхняя губа слегка выступает, коронки верхних центральных зубов расположены веерообразно. 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, зубы подвижны I степени, 28, 27, 26, 35, 36, 38 зубы отсутствуют. Прикус ортогнатический. Ранее протезами не протезировалась.

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*бюгельный протез с шинирующими элементами

*+частичный съемный протез

*полный съемный протез

*микро протез с шинирующими элементами

*мостовидный протез из СПС

#466

*!Мужчина 30 лет. При объективном осмотре обнаружена повышенная стираемость твердых тканей зуба II степени, уменьшение вертикальных размеров коронок всех зубов, снижение межальвеолярной высоты, высота нижней трети лица не изменена. Зубная формула: на верхней челюсти двухсторонний концевой дефект а на нижней челюсти односторонний концевой дефект

Какая конструкция протеза НАИБОЛЕЕ эффективна?

*бюгельный протез с шинирующими элементами

*+частичный съемный протез

*полный съемный протез

*микро протез с шинирующими элементами

*металлокерамический мостовидный протез

#467

*!Мужчина 43 года, обратился с жалобой на жжение, металлический привкус во рту. При осмотре в полости имеются металлический мостовидный протез на верхней челюсти и золотые коронки на зубах нижней челюсти с правой стороны.

Какой из перечисленных ниже предварительных диагнозов НАИБОЛЕЕ вероятен?

*+явления непереносимости

*токсический стоматит

*протезный стоматит

*аллергический стоматит

*парниковый эффект

#468

*!Мужчине 30 лет, обратился с целью рационального протезирования. При осмотре на нижней челюсти выявлены включенный дефекты во фронтальном отделе и концевой в боковом отделе. Рекомендовано изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть.

Какая из перечисленных ниже систем фиксации бюгельного протеза НАИБОЛЕЕ целесообразна?

*пелоты

*система Нея

*+замковые крепления

*удерживающие кламмера

*система Румпеля-Дольдера

#469

*!Женщина 65 лет, предъявляет жалобы на полное отсутствие зубов верхней и нижней.

При осмотре выявлены: резкая атрофия альвеолярных отростков и гиперчувствительность слизистой оболочки протезного ложа.

При изготовлении полных съемных протезов

Какой базис из перечисленных ниже НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *+двухслойный
- *силиконовый
- *нейлоновый
- *пластмассовый
- *металлический

#470

*!Женщина 53 лет, предъявляет жалобы на подвижность зубов на верхней челюсти. При осмотре: выявлена подвижность зубов в боковых отделах челюсти с поражением пародонта.

Какая НАИБОЛЕЕ рациональная стабилизация шинирующих конструкций показана при лечении локализованного пародонтита?

- *передняя
- *саггитальная
- *трансверзальная
- *+парасаггитальная
- *передне – боковая

#471

*!При припасовке индивидуальной ложки на верхнюю челюсть с использованием функциональных проб по Гербсту у мужчины 23-х лет, при вытягивании губ слепочная ложка смещается с верхней челюсти

В каком месте индивидуальной ложки НАИБОЛЕЕ целесообразна коррекция?

- *+ укорачивание вдоль переходной складки
- *в таких случаях укорачивают по линии А
- *укорачивают по боковому краю
- *необходимо укоротить на участке верхнечелюстного бугра
- *укорачивают в зоне между клыками

#472

*!Врач рекомендует пациенту бюгельный протез на нижнюю челюсть. Изучая модель на параллелометре, предлагает изготовить 2-тип опорно-удерживающий кламмер системы Нея.

НАИБОЛЕЕ вероятно это объясняется следующей клинической картиной

- *+экваторы опорного зуба выражены
- *экваторы опорного зуба не выражены
- *опорный зуб имеет наклон в оральную сторону
- *опорный зуб имеет наклон в вестибулярную сторону
- *опорные зубы конвергированы в сторону дефекта

#473

*!У женщины 45 лет, беззубая верхняя челюсть. Атрофия альвеолярного отростка средней степени, маловыраженные бугры, средняя глубина неба, выраженный торус.

Какой НАИБОЛЕЕ соответствующий тип беззубой верхней челюсти по Шредеру?

- *I
- *+II
- *III
- *IV
- *V

#474

*!У женщины 52-х лет беззубая нижняя челюсть. Челюсть с резко выраженной альвеолярной частью, переходная складка расположена далеко от альвеолярного гребня. Какой НАИБОЛЕЕ соответствующий тип беззубой нижней челюсти по Келлеру?

- *+I
- *II
- *III
- *V
- *V!

#475

*!У мужчины 46 лет, с целью одонтопрепарирования 4.6 зуба произведена местная проводниковая анестезия 2% раствором новокаина. Через 50 секунд после введения у больной появилось чувство страха, холодный липкий пот, синюшность губ, снизилось давление до 60 мм.рт.ст, расширились зрачки, определяется отсутствие реакции зрачков на свет, непроизвольный акт мочеиспускания.

Какой из перечисленных осложнений НАИБОЛЕЕ вероятен?

- *коллапс
- *обморок
- *диабетическая кома
- *+анафилактический шок
- *гипертонический криз

#476

*!Мужчина 45 лет, 5 лет назад были изготовлены штампованно-паяные мостовидные протезы на нижнюю челюсть У больного за счет воспалительной контрактуры медиальной крыловидной мышцы имеется ограничение рта. Затрудненное протезирование за счет контрактуры. Контрактура 2-степени. В анамнезе - ограничение открывание рта появилось 2 дня тому назад.

Какой НАИБОЛЕЕ рациональный метод анестезии показан?

- *по Берше
- *по Вайсбрему
- *по Егорову
- *мандибулярный
- *+по Берше-Дубову

#477

*!Мужчина 38 лет на этапе одонтопрепарирования при проведении туберальной анестезии произошел отлом иглы

Какая тактика ведения больного НАИБОЛЕЕ целесообразна?

- *назначить курс рассасывающей терапии
- *немедленное удаление иглы из мягких тканей
- *+рентгенография в 2-х проекциях и наблюдение
- *провести курс противовоспалительной терапии
- *инфильтрировать область расположения иглы раствором анестетика

#478

*!Женщина 65 лет предстоит одонтопрепарирование 45и 47зуба Страдает гипертонической болезнью в течение 20 лет

Какой из перечисленных ниже местных анестетиков НАИБОЛЕЕ целесообразен?

- *2% раствор лидокаина с адреналином
- *ультракаин-форте
- *+мепивастезин
- *4% убистезин-форте
- *2% раствор новокаина с адреналином

#479

*!Мужчина 20 лет во время проведения ортопедических манипуляций наступил коллапс

Какой пульс НАИБОЛЕЕ характерен во время коллапса?

- *частый, нитевидный
- *+нитевидный, редкий
- *частый, хорошего наполнения
- *редкий, хорошего наполнения
- *не определяется

#480

*!Мужчина 25 лет на этапе одонтопрепарирования предстоит туберальная анестезия
Какое НАИБОЛЕЕ правильное место вкола иглы при туберальной анестезии при внутриворотном методе?

- *+переходная складка на уровне второго моляра позади скуло-альвеолярного гребня
- *в угол, образуемый нижним краем скуловой кости и скуло-альвеолярным гребнем
- *в область резцового сосочка или сбоку от него
- *на 1 см впереди и несколько впереди от большого небного отверстия
- *у основания перегородки носа с обеих сторон

#481

*!Мужчине 28 лет на этапе одонтопрепарирования предстоит анестезия слизистой твердого неба

Какая НАИБОЛЕЕ вероятная причина некроза слизистой твердого неба, возникающая после анестезии?

- *+введение большого количества анестетика
- *введение 0,1-0,2 мл анестетика
- *ранение иглой большого небного нерва
- *ранение иглой малого небного нерва
- *ранение иглой носонейного нерва

#482

*!Какие из перечисленных лекарственных препаратов НАИБОЛЕЕ вероятно относятся к местноанестезирующим средствам группы сложных эфиров?

- *тримекаин, лидокаин, бупивакаин
- *+диэтиленгликоль, новокаин
- *анальгин, аспирин, парацетамол
- *димедрол, супрастин, тавегил
- *реланиум, седуксен

#483

*!Какие из перечисленных лекарственных препаратов НАИБОЛЕЕ вероятно относятся к местным анестезирующим средствам группы амидов?

- *+тримекаин, лидокаин, бупивакаин
- *диэтиленгликоль, хлортал, новокаин
- *димедрол, супрастин, тавегил
- *анальгин, аспирин, парацетамол
- *реланиум, седуксен

#484

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно соответствует между методами обезболивания и местом вкола?

- *небная анестезия- в переходную складку между верхними центральными резцами
- *+туберальная анестезия,-в переходную складку на уровне 17 или 27
- *на середине между небным швом и альвеолярным отростком
- *анестезия по Вайсблату- сбоку у основания резцового сосочка
- *резцовая анестезия- на середине трагусорбитальной линии

#485

*!Что из перечисленного НАИБОЛЕЕ вероятно соответствовует между методами обезболивания и местом вкола?

- *+резцовая анестезия - по бокам у основания резцового сосочка
- *туберальная анестезия- в переходную складку между верхними центральными резцами
- *небная анестезия- в переходную складку за скулоальвеолярным гребнем
- *инфраорбитальная анестезия- на середине трагоорбитальной линии
- *анестезия по Вайсблату- на середине расстояния между небным швом

#486

*!Для одонтопрепарирования 45 зуба под металлокерамику больному А. 60 лет, врач произвел инфильтрационную анестезию с двух сторон. Препарирование зуба было болезненным. Возникла необходимость повторно произвести анестезию. Какую НАИБОЛЕЕ рациональную анестезию необходимо было выполнить первоначально?

- *мандибулярная и инфильтрационная
- *по Берше-Дубову
- *+интралигаментарная
- *ментальная
- *туберальная

#487

*!Что из перечисленного является НАИБОЛЕЕ вероятными причинами расцементирования металлокерамических коронок?

- *+чрезмерная конусность культи зуба
- *чрезмерная толщина литого каркаса
- *усадка металла при литье
- *некачественное литье
- *деформация двухслойного слепка

#488

*!Чем из перечисленных НАИБОЛЕЕ целесообразно восстановить зуб при отломе коронковой части на уровне десны?

- *полукоронкой
- *экваторной коронкой
- *+штифтовой конструкцией
- *съемным протезом
- *вкладкой

#489

*!В каком месте НАИБОЛЕЕ целесообразно расположить уступ при препарировании зуба под фарфоровую коронку?

- *+по всему периметру шейки зуба
- *на вестибулярной поверхности
- *с оральной и апроксимальных сторон
- *на апроксимальных поверхностях
- *с оральной стороны

#490

*!Что из перечисленных НАИБОЛЕЕ вероятно относится к основным параметрам функциональной ценности зуба

- *воспаление десны и цвет зуба
- *цвет и размер зуба

- *+атрофия кости и подвижность зуба
- *подвижность зуба и зубные отложения
- *зубные отложения и воспаление десны

#491

- *!К чему из перечисленных НАИБОЛЕЕ вероятно приведет создание чрезмерной конусности культи зуба при препарировании под металлокерамическую конструкцию
- *травме пародонта
- *+ослаблению фиксации протеза
- *затрудненному наложению протеза
- *эстетическому дефекту в области шейки зуба
- *снижению жевательной эффективности

#492

- *!При изготовлении металлопластмассовой коронки сошлифовывается значительное количество твердых тканей и формируется уступ для
- *улучшения фиксации коронки
- *создания плотного контакта коронки с тканями культи зуба
- *+уменьшения травмы десны и эстетического эффекта
- *достижения плотного контакта с зубами - антагонистами
- *создания контактного пункта с соседними зубами

#493

- *!При изготовлении металлопластмассовой коронки НАИБОЛЕЕ целесообразно рабочий оттиск снять массой
- *+силиконовой
- *альгинатной
- *фторкаучуковой
- *термопластичной
- *цинкоксидаэвгеноловой

#494

- *!Проверку окклюзионных контактов на этапе припасовки искусственной коронки НАИБОЛЕЕ целесообразно проводить в окклюзиях
- *сагиттальных
- *сагиттальных и центральной
- *центральной и боковых
- *боковых и сагиттальных
- *+сагиттальных, боковых и центральной

#495

- *!Проверку окклюзионных контактов на этапе припасовки несъемного мостовидного протеза НАИБОЛЕЕ целесообразно проводить при следующих окклюзиях
- *сагиттальных
- *сагиттальных и центральной
- *центральной и боковых
- *боковых и сагиттальных
- *+сагиттальных, боковых и центральной

#496

- *!К какому из перечисленных классов по классификации Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятно относится двусторонний дистально неограниченный (концевой) дефект зубного ряда

- *+первому
- *второму
- *третьему
- *четвертому
- *пятому

#497

- *!Перед снятием двухслойного слепка НАИБОЛЕЕ целесообразно сделать ретракция десны чтобы получить, или
- *+точный отпечаток поддесневой части зуба
- *точный отпечаток наддесневой части зуба
- *остановить кровотечение
- *обезболить десневой край
- *высушить поверхность культы зуба

#498

- *!К какому из перечисленных классов по классификации по Кеннеди НАИБОЛЕЕ вероятно относится односторонний дистально неограниченный (концевой) дефект зубного ряда?
- *первому
- *+второму
- *третьему
- *четвертому
- *пятому

#499

- *!Какая из перечисленных форм промежуточной части мостовидного протеза НАИБОЛЕЕ характерна при отсутствии зубов 22 и 23?
- *седловидная
- *промывная
- *+касательная
- *ступенчатая
- *диаторическая

#500

- *!Что из перечисленных является НАИБОЛЕЕ вероятной причиной изготовления составного мостовидного протеза?
- *подвижность опорных зубов
- *концевой дефект зубного ряда
- *низкие клинические коронки зубов ограничивающие дефект
- *большая протяженность дефекта зубного ряда
- *+большая конвергенция зубов , ограничивающих дефект